双相情感障碍资料库（面向患者）

认识躁狂与抑郁 · 识别发作 · 就医诊断 · 规范治疗

节律管理 · 复发预警 · 危机应对 · 家属支持

> **免责声明：**本资料库仅作健康知识科普与学习参考，**不能替代精神科医生的面诊、诊断与处方。** 自评量表（如 MDQ、HCL-32）仅用于自我筛查，**不能作为确诊依据。**双相障碍需要精神科医生全病程管理， 不可依据本资料自行选药、加药、减药或停药，也不可自行停用心境稳定剂。

> **紧急情况：**若出现持续不眠却精力异常旺盛、冲动挥霍或高危性行为、易激惹到可能伤人毁物， 或在抑郁/混合状态下出现自伤、自杀的念头、计划或准备行为，请立即拨打 **120**（急救）或 **110**（报警）， 或拨打 **12356** 全国统一心理援助热线（24 小时免费），并尽快联系家属陪伴、前往精神科急诊。

版本：V0.1 ｜ 生成日期：2026 年 10 月

本 PDF 由同目录下 Markdown 资料库（10 大模块 + 可选附加模块，共 45 篇内容）自动汇编生成。

目录

模块1：疾病正式名称与分类词条

1. 标准学名（ICD-11与DSM-5）
2. 子类型与子条目
3. 临床简称与常用别名
4. 易混淆名词区分
5. 历史名称

模块2：基础认知

1. 什么是双相情感障碍
2. 情绪“过山车”通俗原理
3. 误区辟谣
4. 患病特点与可康复性

模块3：症状表现

1. 躁狂发作
2. 轻躁狂发作
3. 抑郁发作（双相抑郁相）
4. 混合特征与混合发作
5. 快速循环
6. 发作分期与病程模式
7. I型II型与环性心境区分

模块4：诱因与高危因素

1. 生物学因素
2. 心理因素
3. 环境因素
4. 保护因素

模块5：就医与诊断指南

1. 就诊触发信号
2. 就诊科室与专业人员
3. 就诊前准备清单
4. 诊断流程与评估量表
5. 常见共病

模块6：治疗方案

1. 药物治疗
2. 心理治疗
3. 物理治疗
4. 治疗预期与目标

模块7：自我调节与日常康复实操

1. 急性躁狂与轻躁狂期应对方法
2. 情绪与睡眠监测
3. 人际社会节律与规律作息
4. 长期自我管理
5. 复发预警信号

模块8：危机识别与求助资源

1. 需要紧急就医的危险信号
2. 国内心理危机热线与求助渠道
3. 复诊时机与住院时机

模块9：生活与社会支持

1. 与家人亲友沟通
2. 工作学习场景应对
3. 婚姻与生育
4. 财务与冲动消费

模块10：常见Q&A

1. 高频问答QA

可选附加模块

共病专题
康复者视角
家属参考附录

模块 1

疾病正式名称与分类词条

1. 标准学名（ICD-11与DSM-5）

> 本页解释"双相情感障碍"这一大类，在两套国际诊断体系——世界卫生组织的 **ICD-11** 与美国精神医学学会的 **DSM-5**——里到底叫什么、归在哪一章、编码是多少。**编码是医院统计、病历书写、医保对接用的内部编号，不是给你自我对号入座的清单，更不能替代精神科医生面诊。** 你病历上的具体诊断，以接诊机构采用的版本和医生判断为准。

1.1 上位名称：两套体系怎么叫这一大类

"双相"不是一个单一的病，而是**一组**以心境在"病理性高涨（躁狂/轻躁狂）"与"病理性低落（抑郁）"两极之间摆动为核心的精神障碍的总称。

项目	ICD-11（世界卫生组织，2018年发布、2022年起各国正式使用）	DSM-5 / DSM-5-TR（美国精神医学学会，2013/2022）
上位章节	归入"**精神、行为或神经发育障碍**"大类下的"**心境障碍（Mood disorders）**"	单独成章，名为"**Bipolar and Related Disorders（双相及相关障碍）**"
本章中文名	**双相及相关障碍**	**双相及相关障碍**
本章英文名	Bipolar or related disorders	Bipolar and Related Disorders
在整体分类中的位置	与"抑郁障碍（Depressive disorders）"并列于"心境障碍"之下，二者是"兄弟章"，不是包含关系	双相章单独排在"抑郁障碍"之前，强调双相和单相抑郁是两类病
主要用途	国际健康统计、各国病历编码、医保与公共卫生对接	临床研究、学术交流、心理治疗与保险沟通常用

【临床共识】两套体系在"双相包含哪些主要亚型"上几乎一一对应，但**名称、编码、病程要求略有差别。**同一位患者，在 ICD-11 病历上可能写"双相 I 型障碍（6A60）"，在美国体系资料里看到的是"Bipolar I Disorder，296.xx"——这不是两个病，而是同一个东西的两种编号语言。

1.2 主要亚型的命名与编码对照表

下表按 WHO ICD-11 浏览器（icd.who.int）现行编码核实整理（核实日期 2026-10-20）：

亚型	ICD-11 编码	ICD-11 英文名	DSM-5 常用编码（ICD-10-CM）	DSM-5 英文名
双相 I 型障碍	**6A60**	Bipolar type I disorder	**F31.xx**（按当前发作分期细分）	Bipolar I Disorder
双相 II 型障碍	**6A61**	Bipolar type II disorder	**F31.81**	Bipolar II Disorder
环性心境障碍	**6A62**	Cyclothymic disorder	**F34.0**	Cyclothymic Disorder
其他特定的双相及相关障碍	**6A6Y**	Other specified bipolar or related disorders	F31.89 等	Other Specified Bipolar and Related Disorder

亚型	ICD-11 编码	ICD-11 英文名	DSM-5 常用编码（ICD-10-CM）	DSM-5 英文名
未特定的双相及相关障碍	**6A6Z**	Bipolar or related disorders, unspecified	F31.9	Unspecified Bipolar and Related Disorder

【研究结论】注意一个历史差别：在 **ICD-10（1992–2022 年间我国长期沿用）** 里，双相障碍被编码为 **F31**，并按"躁狂发作/双相抑郁发作/混合发作"等细分；到了 ICD-11，WHO 把双相 I 型、II 型、环性心境**各自独立成编码（6A60/6A61/6A62）**，不再混在一个 F31 下。所以你在老病历、老科普里看到的"F31.1""F31.3"，对应的就是今天说的双相 I 型或其某次发作相。

1.3 几个容易被忽略的命名细节

- **"躁狂发作""轻躁狂发作""重性抑郁发作"本身不是独立诊断。**它们是"发作"，是双相病程中的一个个段落——就像哮喘的"一次急性发作"不是一个独立的病名。【临床共识】
- **双相障碍和抑郁障碍曾经被混在一起。**在 DSM-IV（1994）里，双相是放在"心境障碍"大章下的一个小节；**DSM-5（2013）和 ICD-11 都把"双相及相关障碍"与"抑郁障碍"明确分开**，单独立章。原因很现实：双相的治疗（尤其心境稳定剂）和单相抑郁（尤其抗抑郁药单用）差别很大，混诊会耽误治疗。
- **"抑郁相""躁狂相"里的"相"字**，指的是同一次病程中的某一阶段。病历上写"双相 I 型，目前为抑郁发作"，意思是：这个人历史上有过躁狂发作，现在这一段表现为低落。

1.4 这些编码是干什么用的（以及不是干什么用的）

编码的真实用途	编码不是用来做这些的
医院病案室统计本病种的数量、资源消耗	不是你在网上自测后给自己贴的标签
医保报销、病种分组、公共卫生上报	不是"严不严重"的等级——6A60 不比 6A61 更"高级"或更"危险"
医生之间、医院之间病历沟通的统一语言	不是保险买不买、单位招不招你的依据（隐私受法律保护）
科研入组、流行病学调查的统一口径	不是"得了就一辈子改不了"的烙印
提醒医生"这个病人要警惕抗抑郁药单药转躁"	不是用来给自己下"我是不是双相"结论的

【个人体验】很多患者第一次在病历本上看到一串数字编码，会紧张地拿手机查，越查越害怕。其实那串数字对你唯一的意义是：**医生知道该用哪一类治疗思路、该警惕什么风险。**它不定义你是谁，也不预测你的未来。

1.5 一个特别重要的提醒：编码 ≠ 自测结论

【临床共识】网上有很多"三分钟测测你是不是双相"的小测验。它们可能用到 **MDQ（心境障碍问卷）**、**HCL-32（轻躁狂症状清单）** 等工具，但这些量表**仅用于筛查/辅助评估，不能据此确诊。**双相的诊断有几个门槛是量表代替不了的：

- 躁狂/轻躁狂症状是否**持续了规定时长**（躁狂≥1周、轻躁狂≥4天）；
- 这些改变是不是**与平时明显不同**、身边人也能观察到；

- 有没有达到**功能损害**（工作、社交、花钱、安全出问题）；
- 能不能用物质、甲亢、药物（尤其是抗抑郁药）等其他原因解释。

这些都需要精神科医生面诊、询问病史、结合必要的躯体检查才能判断。

1.6 本资料库后续条目怎么用这些名称

本资料库统一采用 **ICD-11 的中文规范名称**为主（因为它是我国现行病历与统计对接的方向），并在首次出现时附上 DSM-5/ICD-10-CM 编码备查：

- 双相 I 型障碍（6A60）
- 双相 II 型障碍（6A61）
- 环性心境障碍（6A62）
- 双相障碍——其他特定（6A6Y）/未特定（6A6Z）

具体每个亚型长什么样、诊断门槛是什么，见同模块下一篇《2. 子类型与子条目》。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Bipolar or related disorders（6A60–6A6Z）
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）· Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
- American Psychiatric Association：DSM-5 / DSM-5-TR 官方介绍（Bipolar and Related Disorders 章节）
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》诊断分类章节
- 世界卫生组织：Depressive disorder (depression) 事实清单

2. 子类型与子条目

> "双相"不是一个病，而是**一组病**。本页用一张大对照表，把临床上最主要的三个类型——**双相 I 型、双相 II 型、环性心境障碍**——的一句话特征、典型表现、病程门槛一次说清。**有类似感受 ≠ 确诊**；I 型和 II 型的关键区别，不在于"哪个更重"，而在于**有没有出现过完整的躁狂发作**。最终诊断由精神科医生面诊做出。

2.1 三大类型大对照表

类型	一句话特征	典型表现（患者视角）	病程/发作门槛（诊断参考）
双相 I 型障碍（6A60）	**至少有过一次"躁狂发作"**，之后可能反复转抑郁	某段时间突然连续几天到一周以上：觉得自己无所不能、话特别多、一夜只睡两三个小时还精力旺盛、疯狂花钱或投资、冲动开车、人际关系骤变；发作时自己往往不觉得有病，身边人先察觉"他疯了一样"	至少**一次躁狂发作**：心境高涨/易激惹 + 活动增多/精力增加，伴≥3项（夸大、睡眠需要减少、话多、思维奔逸、随境转移、冲动行为），**持续 ≥ 1 周**（或严重到需住院）；可伴或不伴重性抑郁发作
双相 II 型障碍（6A61）	**有过"轻躁狂发作"，也有过重性抑郁发作，但从来没有过完整的躁狂发作**	抑郁时和单相抑郁一样痛苦；好转期会有几天"状态特别好"——思路快、效率高、睡眠变少但不累，常被自己和周围人当成"终于好了"；直到下一次抑郁沉下去才发现不对	至少**一次轻躁狂发作（≥4天）+ 至少一次重性抑郁发作**；**从无躁狂发作。**轻躁狂症状较躁狂轻，一般不出现精神病性症状、不需要住院、社会功能未严重崩溃
环性心境障碍（6A62）	**长达数年的、反反复复的轻性心境波动**，从来没有哪一次达到"完整发作"的标准	像坐小过山车：几年里交替出现"状态不错、有点飘飘然、话多睡得少"和"有点低落、没劲、没兴致"，每次都不算重，但就是**没有真正稳定的时候**；常被当成"性格起伏大""情绪化"而漏诊	**≥ 2 年（儿童/青少年 ≥1 年）**反复多次轻性高涨与轻性低落，**从未达到**躁狂/轻躁狂或重性抑郁发作的完整标准；期间正常情绪期每次不超过几个月

【临床共识】I 型和 II 型的**核心分界线只有一条：有没有过"完整的躁狂发作"。**不是"I 型比 II 型更严重"这么简单——II 型患者因为**抑郁发作更频繁、病程更迁延**，主观痛苦和功能损害有时并不轻；而 I 型的风险更多集中在那一次次躁狂/混合发作的冲动与安全上。

2.2 躁狂 vs 轻躁狂：一张表看清差别

很多人问："我那几天状态特别好，到底算躁狂还是轻躁狂？"差别主要在**严重程度、持续时间、功能损害**：

维度	躁狂发作（manic episode）	轻躁狂发作（hypomanic episode）
持续时间	**≥ 1 周**（或任何时长但严重到必须住院）	**≥ 4 天**
心境	异常高涨/兴奋，或极度易激惹	轻度高涨、开朗、精力旺，或轻度易激惹
睡眠需要	明显觉得"不需要睡"，几天不睡仍精力充沛	睡眠需要减少，但通常还能睡几个小时

维度	躁狂发作（manic episode）	轻躁狂发作（hypomanic episode）
功能损害	**明显**：工作、社交、家庭关系崩盘；常出现挥霍、高危性行为、盲目投资、鲁莽驾驶	**较轻**：别人能看出"你最近有点不一样"，但生活大多还能维持
精神病性症状	**可有**：夸大妄想（认为自己有特殊身份/能力/财富）、幻觉	**一般没有**
是否需要住院	常需要	一般不需要
患者自知力	发作期常**不觉得自己有病**	部分人能意识到"我有点飘了"，但也有人不觉得

【个人体验】轻躁狂期往往是患者**最舍不得放手**的阶段："那几天我效率极高、心情极好、创意不断，为什么要治？"——问题在于，这阵风之后常常跟着一场更长、更深的抑郁；而且轻躁狂里做的决定（辞职、分手、大额投资、高危行为），事后往往要花很久收拾残局。

2.3 两个重要的"附加标注"：混合特征与快速循环

它们不是独立亚型，而是医生写在诊断后面的"修饰词"，但对治疗和安全很关键：

标注	是什么	为什么重要
伴混合特征 / 混合发作	**同一时段里，躁狂症状和抑郁症状同时搅在一起**：比如情绪高涨、脑子转得飞快，却又空虚绝望、烦躁想伤害自己；或抑郁着却话多、睡得少、坐立不安	【临床共识】**混合状态的自杀风险尤其高**——因为抑郁的绝望加上了躁狂/激越带来的行动力和冲动，最危险
快速循环	**一年内发作 ≥ 4 次**（躁狂、轻躁狂、抑郁或混合发作中的任意组合）	常与**抗抑郁药单药使用、睡眠紊乱、甲状腺功能异常**等有关；治疗反应相对差一些，需要医生更仔细地调整方案

2.4 其他两个"兜底"条目

- **其他特定的双相及相关障碍（6A6Y）**：症状像双相，但**没完全达到**上面三种的时长或条数标准（例如轻躁狂只持续了 2–3 天、或抑郁发作次数不够等）。医生写它，是因为"确实有病，但还不够格放进 I/II/环性"。
- **未特定的双相及相关障碍（6A6Z）**：医生手头信息还不够，先放这个筐里，等复诊、补充病史后再明确。

【临床共识】"被写进 6A6Y 或 6A6Z"不代表"你没病"，更不代表"医院糊弄你"——它往往意味着**还需要更多时间和信息**来定型。这在精神科初诊中很常见。

2.5 一个常见疑问："我到底属于哪一型？"

很多患者会拿着上面的表逐行对，越对越糊涂。其实：

- **说不清的时候，不必硬给自己归类。**医生会通过问诊、发作史、身边人补充的信息来判断；

- **很多人最初只被当成"抑郁症"治**，直到后来出现过一次轻躁狂/躁狂，才被更正为双相 II 型或 I 型——**诊断在病程中被修正，是这个病的常态，不是医生误诊**；
- **I 型和 II 型之间一般不会互相"转变"**，但你的发作相（躁狂相、抑郁相、混合相）会反复交替；
- **重要的不是"我叫哪一型"，而是"我现在处于哪个相、该警惕什么"。**

【个人体验】患者最常说的一句话是："我管它 I 型 II 型，我只想知道怎么不再大起大落。"——这恰恰是对的方向：分型是医生选治疗思路的依据，**让情绪稳定下来、别再被甩出去，才是你真正关心的事。**

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Bipolar type I (6A60) / type II (6A61) / Cyclothymic disorder (6A62)
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 章节（躁狂/轻躁狂/重性抑郁发作诊断标准）
- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：CG185 Bipolar disorder: assessment and management
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》分型章节
- 国际双相障碍学会（ISBD）：ISBD 混合状态操作性定义

3. 临床简称与常用别名

> 在医院、科普文章、网络论坛和家人嘴里，这个病会被说成各种各样的名字——"双相""躁郁症""躁狂抑郁症"" bipolar……"。本页把**正式名 ↔ 俗称/旧称/英文缩写**一一对应起来，帮你听懂别人在说什么，也避免把"情绪有点起伏"误当成一个诊断。

3.1 正式名 ↔ 临床常用简称/别名对照表

正式名称（ICD-11 / 临床规范）	临床简称 / 英文缩写	常见俗称 / 旧称	备注
双相 I 型障碍	BP-I、BD-I	躁郁症（传统说法多涵盖 I 型）	有过完整躁狂发作
双相 II 型障碍	BP-II、BD-II	常被误当"抑郁症"	轻躁狂 + 抑郁，从无躁狂
环性心境障碍	Cyclo、Cyclothymia	"情绪化""脾气起伏大"	长期轻性波动，易被当性格
双相及相关障碍（总称）	**BD**（Bipolar Disorder）、**BPAD**（Bipolar Affective Disorder）	**双相、双相障碍、双相情感障碍**	国内病历最常用"双相情感障碍"
双相障碍（泛称）	Manic-depressive illness	**躁狂抑郁症、躁狂抑郁性精神病、躁郁症**	旧称，欧美 20 世纪常用
发作相描述	——	**躁狂相、抑郁相、混合相**	指同一次病程中的某一阶段

3.2 几个特别容易误解的名字

① "双相""双相障碍""双相情感障碍"——哪个才对?

【临床共识】这三个指的是同一个东西，只是完整度不同：

- **双相**：最口语的简称，朋友间、病友群里这么说没问题；
- **双相障碍**：书面简称，病历、科普标题常用；
- **双相情感障碍**：国内医院病历上**最完整、最正式**的写法（对应 ICD-11 的"双相及相关障碍"这一大类）。

听到哪个都不必纠结——它们说的都是"情绪会在高涨和低落两极之间病理性摆动"这组病。

② "躁郁症""躁狂抑郁症"——老一辈病历上的旧名字

这是**最有历史感的一个俗称。**在 Kraepelin 时代（19 世纪末）一直到 20 世纪中后期，这个病在欧美和我国都叫"躁狂抑郁症（manic-depressive illness）"，再往后又被加上"精神病"三个字叫"躁狂抑郁性精神病"。

【临床共识】这个名字今天**已经不再作为正式诊断名使用**，但你会在以下地方反复听到：父母辈的老病历、老医生口中、港台和民间口语里、以及英文科普（"manic depression"）。**它和今天的"双相障碍"是同一大类病**，不是两种病；只是"精神病"三个字带有强烈的病耻感，现代命名特意把它拿掉了。

【研究结论】从"躁狂抑郁性精神病"改为"双相（情感）障碍"，不是简单的文字游戏：精神医学命名研究普遍认为，去掉"精神病""疯狂"等污名化字眼，能显著降低患者的病耻感、提高就医意愿和治疗依从性——这也是近几十年各国诊断体系共同的去污名化趋势。

③ "双相"里的"相"是什么意思?

"相"在这里是**"阶段/相位"**的意思，不是"照相"也不是"相互"。情绪高涨的阶段叫"躁狂相"，情绪低落的阶段叫"抑郁相"，两者搅在一起叫"混合相"。所以：

- **"双相" = 有两个相（躁狂相 + 抑郁相）交替出现**；
- 不是"一个人有两个人格"——这是最常见的误解，下一篇《4. 易混淆名词区分》会专门拆。

【个人体验】我第一次在病历上看到"双相"两个字时完全不懂，回家还跟家里人吵了一架——他们一直说我这是"躁郁症""想太多"，我才反应过来，原来医生写的"双相情感障碍"，和我爸妈嘴里那个老名字，说的根本就是同一回事。

④ 英文都怎么写?

英文写法/缩写	全称	使用场合
bipolar (disorder)	bipolar disorder	国际通用，最常见
BD	Bipolar Disorder	病历、病友群缩写
BPAD	Bipolar Affective Disorder	英国、部分英联邦国家病历写法
manic-depressive illness/psychosis	躁狂抑郁症	历史名称、文学作品、老文献
BP-I / BP-II	Bipolar I / II	区分一型二型
hypomania / mania	轻躁狂 / 躁狂	描述发作相时用

3.3 不是诊断名、但常被当成病名的词

下面这些说法在日常中很常见，**它们描述的是一种状态或阶段，不是一个独立的精神科诊断**：

说法	到底是什么	是不是诊断
情绪高涨/情绪低落	正常人也有，事出有因、事过能回	❌ 不是诊断
"我最近有点躁"	可能只是兴奋、熬夜后状态飘，也可能是轻躁狂早期	❌ 口头说法，要医生判断
躁狂发作 / 轻躁狂发作 / 抑郁发作	双相病程中的"一段"，不是独立病名	⚠️ 是病程段落，依附于双相诊断
"周期性精神病"	我国 CCMD 时代用过的旧条目，约相当于快速循环型双相	❌ 旧称，今天归入双相谱系

说法	到底是什么	是不是诊断
"情绪病""情感病"	民间对心境障碍的笼统说法	❌ 不是规范诊断
"天才病""达芬奇综合征"	把双相浪漫化、天才化的网络说法	❌ 完全不是诊断，详见模块2《3. 误区辟谣》

【临床共识】"我最近情绪起伏大"和"我得了双相"是**两件事**。前者人人都有，后者是要满足"发作时长、功能损害、不能用其他原因解释"等一整套门槛的疾病状态。判断权在医生，不在这张表。

3.4 医院病历上可能出现的其他名字

- **"双相障碍，目前为躁狂发作/抑郁发作/混合发作，部分缓解/完全缓解"**：说明分型 + 你现在处于哪一段；
- **"双相 II 型，反复发作"**：说明有过多次发作；
- **"环性心境障碍"**：那几年起起伏伏但没大发作过；
- **"双相障碍（待分型）"**：初诊还没定型，先观察；
- **"伴快速循环特征""伴混合特征"**：见上一篇 2.3。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Bipolar or related disorders
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 章节
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD-3）》相关历史条目
- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management
- 国际双相障碍学会（ISBD）：术语与诊断共识

4. 易混淆名词区分

> "双相"这两个字，在生活里天天被用歪——有人情绪好两天就说自己"躁狂"，有人吵架翻脸就被扣"人格分裂"的帽子。本页把最容易混淆的几组概念——正常情绪波动 vs 双相、双相 vs 单相抑郁、双相 vs 精神分裂、双相 vs "人格分裂"、双相 vs ADHD、双相 vs 边缘型人格——一次分清。**目的不是让你自我诊断，而是减少"我是不是得了更可怕的病"这种不必要的恐慌，也减少把双相轻描淡写成"性格问题"。**

4.1 正常情绪波动 vs 病理性双相波动（最核心的一张表）

判别维度	正常的情绪起伏	双相的情绪摆动
有没有现实诱因	由具体事引起：升职了开心、挨骂了低落	常常**没有明确诱因**，或诱因与反应强度完全不成比例
持续时间	几小时到几天，事过就回	**高涨相≥1周（躁狂）或≥4天（轻躁狂）、低落相≥2周**，一段一段地持续
强度	开心、难过，但能自控	高涨到"不需要睡觉、觉得自己无所不能、停不下来"；低落到起不了床、觉得活着没意义
功能损害	不影响上班、吃饭、人际关系	**明显损害**：疯狂花钱、辞职、分手、高危行为、卧床不起、无法工作
身边人怎么看	"他今天心情不错/不好"	**"他好像变了一个人""最近不对劲"**——旁人比患者更早察觉
能不能自己收住	能	发作期**自己收不住**，旁人劝、自己想停都停不下来

【临床共识】**情绪有起伏本身是健康的。** 问题不在于"有没有高的时候、低的时候"，而在于这套情绪调节系统**是不是失灵了**——该回落的时候回不来，该平稳的时候突然被甩到另一极。

4.2 双相 ≠ 抑郁症（单相抑郁）——这是最关键、也最容易漏的区别

这一组区别为什么放在第一条？因为**临床上大量双相 II 型患者最初被误诊为单相抑郁症**，而误治（尤其抗抑郁药单药）可能诱发转躁、加快循环。

维度	单相抑郁障碍	双相障碍
有没有过情绪高涨/轻躁狂/躁狂	**从来没有**	**有过**（I 型有躁狂，II 型有轻躁狂）
情绪曲线	主要在**低位**波动	在**高低两极之间摆动**
治疗核心	抗抑郁药 + 心理治疗为主	**心境稳定剂为基石**，抗抑郁药要非常谨慎

维度	单相抑郁障碍	双相障碍
警惕点	——	**抗抑郁药单药使用可能诱发转躁/快速循环**【临床共识】
抑郁发作特点	相对"干净"地低落	双相抑郁常更"不典型"：嗜睡、食欲暴增、肢体灌铅感、情绪反应性强

【个人体验】很多双相 II 型患者回顾："我前几年一直被当成抑郁症治，越吃越觉得自己'飘'——几天几夜不睡、疯狂买东西、然后又砸进去更深的抑郁。"——这就是为什么初诊时医生会**反复追问你有没有过那几天"状态特别好"的时候**，哪怕你自己觉得那是"我终于好了"。

4.3 双相 ≠ 精神分裂症

这是患者最常自己吓自己的一点，必须说清楚：

维度	双相障碍	精神分裂症
核心问题	**情绪**在两极间摆动	**现实检验**出问题：幻觉、妄想、思维混乱
现实检验力	**大多数时候完整**——你知道自己那几天"不对"	**受损**——坚信幻觉妄想是真的
精神病性症状	**只在严重躁狂/抑郁发作时短暂出现**（如夸大妄想），发作过后消失	持续、弥散
发作间期	**社会功能大多可恢复正常**	常残留阴性症状，功能受损较持久

【临床共识】**双相不会"变成"精神分裂症。** 严重躁狂期可能短暂出现"我是天才、我有特殊使命"这类夸大想法，这叫"伴精神病性特征的躁狂发作"，发作过去后会恢复——它和精神分裂症是两回事。

4.4 双相 ≠ "人格分裂 / 双重人格"（大众最大的误会）

【个人体验】每次有人听说"双相"，第一反应常常是："哦！就是有两个人格、一会儿一个样？"——**完全不是。**

- **"人格分裂/双重人格"**，医学上叫**解离性身份障碍**，是另一类极少见的病，和童年严重创伤有关；
- **双相的"相"是"情绪的相位"，不是"另一个人格"。**从头到尾是**同一个人**，只是情绪、精力、睡眠在两极之间摆。

维度	双相障碍	解离性身份障碍（俗称"人格分裂"）
变的是什么	**情绪、精力、睡眠、冲动**	**身份记忆**——另一个"我"出现、时间断片
自我感	始终是同一个人	体验到不同身份切换、对某段时间"断片"
常见误解来源	电视剧把情绪波动演成"换了个人"	影视剧的夸张渲染

4.5 双相 ≠ ADHD（注意缺陷多动障碍）

两者在青少年、青年期都可能出现"坐不住、话多、注意力不集中、冲动"，容易混：

维度	ADHD	躁狂/轻躁狂期
起病	**儿童期就存在**，从小注意力差、好动	**阶段性发作**，平时可能正常
时间特点	长期、持续、跨场景	**一阵一阵**，有明确的起止
情绪	以烦躁、注意力不集中为主	有**明显的高涨/夸大、睡眠需要减少**
睡眠	不一定	发作期典型的"睡得极少却不累"

【临床共识】ADHD 是从小的特质，双相是阶段性的发作；但两者**可以共病**，所以医生会仔细区分，避免把双相的躁狂期当成"就是坐不住"。

4.6 双相 ≠ 边缘型人格障碍

这两个在"情绪起伏大、人际关系剧烈摇摆"上很像，是临床上最难分的一对：

维度	双相障碍	边缘型人格障碍
情绪波动的节奏	**发作式**：一段相对稳定 → 突然一段高涨或低落，持续数天到数周	**反应式、快速切换**：被一件小事触发，几小时内情绪就翻江倒海
核心冲突	情绪高低两极的疾病性摆动	**害怕被抛弃、身份感不稳定、关系剧烈爱恨交替**
时间跨度	以**天/周**计	以**小时**计，来得快去得也快
典型话题	睡眠需要减少、夸大、挥霍、抑郁期长	害怕独处、激烈争吵、自伤、空虚感

【研究结论】两者**共病不少见**，鉴别需要有经验的精神科医生仔细梳理情绪波动的时间模式——这正是为什么不能靠网上自测下结论。

4.7 双相 ≠ "喜怒无常的坏性格"

最后，也是最需要拆穿的一条：

维度	普通人"脾气差/情绪化"	双相障碍
能不能自控	能，冷静下来就好	发作期控不住，且自己事后也痛苦
对生活的影响	吵架而已，不影响基本盘	挥霍几十万、辞职、分手、住院、自杀念头
睡眠	该睡还能睡	典型的"几天不睡还精力爆棚"或连续卧床
治疗	不需要治病，调整相处方式即可	**需要规范药物 + 心理治疗，不治疗会反复发作、越拖越重**

【临床共识】**"性格不好"和"双相"的分界线，在于那是不是一段段自己收不回、明显改变了行为和功能的发作。** 把双相患者说成"就是性格喜怒无常"，和把哮喘说成"就是爱喘气"一样——既不准确，也很伤人。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 章节及鉴别诊断
- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器 · Bipolar or related disorders 与 Mood disorders
- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management（鉴别诊断章节）

- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》鉴别诊断章节
- 国际双相障碍学会（ISBD）：双相障碍与单相抑郁、ADHD、人格障碍鉴别共识

5. 历史名称

> 双相今天的名字，不是一开始就有的。从古希腊人把"躁狂"和"忧郁"当成两种独立的病，到 19 世纪发现它们会在同一个人身上交替出现，再到 Kraepelin 的"躁狂抑郁性精神病"、DSM-III（1980）首次采用"双相"这个词——名字的每一次变化，都代表医学对这个病的认识更深了一层。本页用一条简明脉络，帮你看懂"为什么我妈病历上写的是'躁狂抑郁性精神病'，而我病历上写的是'双相情感障碍'"。

5.1 一张时间线看懂名字的演变

年代	代表性名称 / 事件	谁在用	当时怎么理解这个病
古希腊—古罗马	**躁狂（mania）与忧郁（melancholia）被当成两种独立的病**	希波克拉底等	认为是体液失衡：黄胆汁过多→躁狂，黑胆汁过多→忧郁
1854	**Falret 提出"循环性精神病（la folie circulaire）"**	法国精神病学家 Falret	**第一次明确指出**：躁狂和抑郁可以在同一个人身上交替出现，中间夹着清醒期——这是双相概念的真正起点
同期（1854）	**Baillarger 提出"双相型精神病（folie à double forme）"**	法国精神病学家 Baillarger	几乎同时独立描述了"高涨与低落两态交替"，"双相"一词的雏形
1899	**Kraepelin 确立"躁狂抑郁性精神病（manic-depressive insanity）"**	德国精神病学家 Kraepelin（现代精神病学奠基人）	把反复发作、发作间期可恢复、不导致进行性衰退的这组病，与早发性痴呆（后来的精神分裂症）明确区分开——这是双相诊断体系的基石
20 世纪上半叶	"躁狂抑郁症 / 躁狂抑郁性精神病"	欧美、中国沿用	Kraepelin 体系统治大半个世纪；我国 CCMD 各版也长期使用"躁狂抑郁性精神病"
1980（DSM-III）	**首次采用"双相（Bipolar）"一词**，与"单相抑郁"分开	美国精神医学学会	决定性转折：明确区分"有过躁狂/轻躁狂"（双相）和"只有抑郁"（单相），治疗思路随之分开
1994（DSM-IV）	分出 **双相 I 型 / 双相 II 型**，环性心境单列	美国精神医学学会	认识到"只有轻躁狂、没有躁狂"的一大群患者被埋没在抑郁症里
1992（ICD-10）	**F31 双相情感障碍**，按当前发作相细分	世界卫生组织	我国长期沿用，老病历上的"F31.1""F31.3"就是这一版
2001（CCMD-3）	**双相障碍**，分躁狂相/抑郁相/混合相/快速循环	中华医学会精神科分会	中国本土分类，"躁郁症"在民间仍是口头叫法
2013（DSM-5）	**"双相及相关障碍"单独立章**，排在抑郁障碍之前	美国精神医学学会	强调双相与单相是两类病；细化"混合特征""快速循环"等标注

年代	代表性名称 / 事件	谁在用	当时怎么理解这个病
2018/2022（ICD-11）	**双相及相关障碍（6A60 I 型 / 6A61 II 型 / 6A62 环性心境）**	世界卫生组织	I 型、II 型、环性心境各自独立编码，与 DSM-5 基本对齐

5.2 三个关键转折点，为什么重要

转折点一：1854 年，发现"原来是同一个人身上的两极"

【研究结论】在 Falret 和 Baillarger 之前，医生看到一个人兴奋话多就诊"躁狂"，看到一个人消沉就诊"忧郁"，从没想过**这两拨病人可能是同一批人**——只是在病程的不同阶段被看到了。Falret 的"循环性精神病"第一次把这条规律点破：**它们会交替，中间还夹着清醒期。** 这个发现，是整个双相诊断史的原点。

转折点二：Kraepelin 把它和"早发性痴呆"分开

【临床共识】Kraepelin 在 19 世纪末做了一件影响至今的事：他长期追踪大量病人，发现有一组病**反复发作、发作间期能恢复正常、不会越来越傻**——他叫它"躁狂抑郁性精神病"；另一组病则**进行性衰退、最后社会功能瓦解**——他叫它"早发性痴呆"（即今天的精神分裂症）。这个区分，让无数双相患者第一次知道：**我的病是会缓解、会好起来的，不是一天天烂下去。** 这在当时是巨大的安慰。

转折点三：1980 年 DSM-III 把"双相"和"单相抑郁"分开

【研究结论】在那之前，只要病人来的那次是低落的，就被诊为"抑郁"，于是**大量双相 II 型患者被当成单相抑郁治。**问题是：双相的人单用抗抑郁药，可能被"推"进躁狂或快速循环。DSM-III 确立"双相"概念、后来 DSM-IV 又分出 II 型，**本质是为了让治疗不踩雷**——这也是为什么今天医生初诊一个抑郁病人，总要反复追问"你有没有过那几天特别飘、特别能扛、睡得特别少的时候"。

5.3 为什么名字一直在变？这不是"折腾"

【个人体验】有患者抱怨："我爸病历上写的是'躁狂抑郁性精神病'，我哥写的是'躁郁症'，到我这儿变成了'双相情感障碍'，是不是医院在乱改？"

其实不是。名字的变化背后是：

1. **从"两种病"到"一组病"**：古人以为躁狂和忧郁是两个病，今天知道它们是同一组病的两个相；
2. **从"躁郁症"到"双相"**：去掉"郁"字，是因为很多双相患者抑郁相并不突出、或主要表现为混合/快速循环；去掉"精神病"三个字，是为了撕掉那层"疯子"的病耻标签；
3. **从"笼统"到"分型"**：I 型、II 型、环性心境被分开，是为了治疗更精准——不同型的用药侧重点、复发风险、安全提示都不一样；
4. **从"想不开"到"有生物学基础"**：从体液学说，到发现锂盐能稳情绪、发现遗传与生物节律证据，这个病越来越被当作"大脑情绪调节系统的病"，而不是"性格疯了"。

【临床共识】**改名不是否定过去，而是医学在进步。** 如果你家人的老病历上写着"躁狂抑郁性精神病""躁郁症"，那不是病名错了，而是那个年代能给的最接近的标签——今天我们有了更准确、治疗更有效、也更少病耻感的名字。

5.4 一个安慰性的结尾

一百多年来，这个病被从"体液失衡"说到"精神病"，再说到"双相情感障碍"，换过七八个名字，被人骂过"疯子""喜怒无常""天才病"。但有一件事从来没变：

> **它是一种真实的、反复发作的、但可以被治疗、可以被管理的疾病。**

名字会继续变，编码会继续更新，但你经历的那些"飘到天上"和"沉到谷底"是真实的；你需要的帮助，也是真实的。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-III (1980) 至 DSM-5-TR (2022) 双相分类演变
- 世界卫生组织：ICD-10 F31 与 ICD-11 6A60–6A62 分类对照
- 中华医学会精神医学分会：《中国精神障碍分类与诊断标准（CCMD-3）》及《中国双相障碍防治指南（第二版）》历史沿革
- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management
- 国际双相障碍学会（ISBD）：双相障碍概念史

模块 2

基础认知

1. 什么是双相情感障碍

> 本页用最朴素的语言讲清楚三件事：**情绪为什么会有起伏；什么时候这种起伏变成了病；这个病在人群里到底有多常见。** 读完你不会立刻确诊，但能大致判断"我/家人现在的状态，是该观察观察，还是该去看医生"。本资料库不能替代精神科面诊。

1.1 先说好消息：有高有低，本来就是人之常情

想象你的情绪是一条随波浪起伏的河：

- 收到好消息、玩得开心，**心情上扬**——你更精神、话更多、效率高；
- 受了挫折、累了、天阴，**心情下沉**——你低落、不想动、想多睡；
- 事情过去、休息够了，**它会自己回到中间那条平稳的基线。**

【临床共识】**情绪有波动是健康的。** 它让你能为好事兴奋、为损失难过、在压力下放慢节奏。没有任何起伏、永远一条直线的人，反而是不正常的。

问题从来不是"我情绪有高有低"，而是：

> **这条情绪的河，是不是被一阵一阵的巨浪卷走，再也回不到中间了？**

双相，就是情绪的"高"和"低"都被放大、拉长、推离正常区间，而且**该回的时候回不来。**

1.2 正常的开心/低落 vs 双相的发作（一张表分清）

维度	正常的高/低	双相的发作
高的时候	开心、有劲、能专心做事	连续几天兴奋到不需要睡觉、觉得自己无所不能、停不下来、乱花钱/乱做决定
低的时候	难过、累、想休息	连续两周以上起不了床、觉得活着没意义、连小事都做不动
持续	几小时到几天，事过就回	**高涨≥4–7天、低落≥2周**，一段一段地持续
对生活	不影响吃饭、工作、存钱	钱花光、工作丢、关系崩、躺平下不了床
谁先发现	自己知道	**身边人先发现"你好像变了个人"**

【个人体验】很多患者第一次描述自己是："我不是心情好一点或差一点，我是**整个人像被换了电池——要么电多到半夜还在高速运转，要么彻底开不了机。**"——这就是从"正常起伏"滑向"双相发作"的典型感受。

1.3 这个病到底"双"在哪?

"双"指的是**情绪的两个极端相位**:

- **一极是"高"——躁狂相/轻躁狂相**:心境异常高涨或易激惹、活动和精力异常增多、**睡眠需要减少(注意:是"不想睡、不需要睡",不是"睡不着")**、话多、脑子转得快、夸大、注意力随境转移、做出冲动的事(挥霍、高危性行为、盲目投资、鲁莽开车);
- **另一极是"低"——抑郁相**:情绪低落、兴趣减退、精力下降、自责、睡眠和食欲改变、动作变慢或坐立不安,严重时有自伤自杀念头;
- 两极之间,是**发作间期**——多数人这段时间能恢复到正常生活。

【临床共识】这两极**会在同一个人身上交替出现**,中间可能夹着平稳期;也可能搅在一起变成"混合发作"(一边亢奋一边绝望,详见模块3)。不是"这个人一半时间开心、一半时间难过"这么简单,而是**每次摆动都强到偏离正常、持续够久、并且留下烂摊子。**

1.4 这些改变,自己和别人都能看见

双相发作最"实在"的证据,往往是**身边人的观察**——因为人在轻躁狂/躁狂期常常不觉得自己有病。你可以对照下面这些"可被观察到的改变":

- 睡眠:连续几天**睡得极少却一点不累**(和"失眠痛苦地躺着"完全不同);
- 花钱/行为:短期内大额消费、疯狂网购、突然辞职、突然冲动投资、性冒险;
- 言语:话多得停不下来、别人插不上嘴、话题跳来跳去;
- 情绪:异常兴奋/自负,或者一点就炸、极度易激惹、跟人吵架;
- 低落相:连续两周以上几乎不起床、不见人、不上班。

【个人体验】很多家属后来说:"其实几个月前就觉得他不对——半夜三点还在收拾屋子、手机里多了一堆莫名其妙的订单——只是以为他是最近运气好、心情好。"**愿意把这些变化当回事,是早期识别的关键。**

1.5 这个病有多常见?——一组让你不孤单的数字

【研究结论】根据 **2019 年《柳叶刀•精神病学》(Lancet Psychiatry)发表的中国精神卫生调查(CMHS)**:我国成人**双相障碍的 12 个月患病率约为 0.5%** 左右(终生患病率略高);放到全球看,世界卫生组织(WHO)和各国流行病学数据显示,双相障碍(含 I 型、II 型、环性心境)合计**终生患病率约 1%–2%。**

这个数字意味着:

- 它**比焦虑障碍、抑郁障碍少见**,但绝对不是"罕见病"——一个几千人的单位、一所学校里,就有这样的人;
- 发病年龄偏早,多在**青少年晚期到 20 多岁**首次发作;
- **很多年里被漏诊、误诊**——双相 II 型患者平均要花好几年、看很多次医生,才被正确识别。

【个人体验】知道"大约一百个人里就有一两个"有什么用?——**让你不再觉得自己是怪物。** 你以为只有你会在半夜三点突然"灵感爆发"、然后又躺两周爬不起来;其实有一群和你一样的人,只是大家都不说。

1.6 那"我现在这样"算不算双相?

不要给自己下诊断。但如果你或家人发现下面这些情况，**任何一条持续存在，都值得去精神科谈一次**：

- 你有过一段连续几天**睡得极少却精力爆棚、脑子转得飞快、花钱/做事停不下来**的时期吗?
- 这段"好状态"之后，是不是**往往跟着一段更长、更深的低落**?
- 你是不是**长期被当成"抑郁症"治，但时好时坏、甚至越治越飘**?
- 身边人是不是反复说"你那段时间好像变了个人"?
- 你是不是已经因为情绪大起大落，**花光过钱、辞过职、搞砸过重要关系**?

【临床共识】**不必等到"严重住院"才求助。** 双相越早识别、越早用对方向（尤其别一味单用抗抑郁药），恢复越稳、越不容易反复发作。带着"我大概什么时候开始、有过哪几次大起大落"的记录去一次门诊，比自己在网上猜三个月有用得多。

> **再次提醒：有上面这些感受 ≠ 确诊。** 它只是提示你"值得去问医生一句"。诊断有严格的时长、功能、排除标准，由精神科医生面诊判断。

参考来源

- 世界卫生组织：Depressive disorder (depression) 及双相障碍事实介绍
- Huang Y, Wang Y, Wang H, et al. **Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study.** *Lancet Psychiatry.* 2019;6(3):211-224.
- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 章节
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》概述章节

2. 情绪"过山车"通俗原理

> 你不需要懂医学术语，也能理解自己为什么会这样大起大落。本页用一个生活比喻（**家里的温度恒温器坏了**）+ 几个简单概念，把双相的发病原理讲清楚。读完你会明白：**这不是你"性格疯""想不开"，而是大脑里一套负责稳定情绪、掌管睡眠和节律的系统出了故障——它可以被调回去。**

2.1 主比喻：你脑子里的"情绪恒温器"坏了

想象你家里装了一个空调温控器。它的任务是：热了就制冷，冷了就制热，把室温稳稳维持在 25℃ 左右。

- **正常的恒温器**：温度在 25℃ 上下一两度小幅波动，几乎感觉不到；
- **坏了的恒温器**：一会儿失控加热，屋子烧到 40℃ 还不停（你躁狂/轻躁狂了）；一会儿又失控制冷，冻到 5℃ 还不关机（你抑郁了）。

【临床共识】双相，本质上就是你大脑里这个"情绪恒温器"——**负责把情绪、精力、睡眠稳定在正常区间的那套系统**——失灵了。它不再能"热了就降、冷了就升"，而是被一阵一阵推到极端，**该回中间的时候回不来。**

这就是为什么：

- 你飘起来的时候，别人劝"你冷静点"没用——恒温器坏了，不是你"不想冷静"；
- 你沉下去的时候，别人说"你振作点"没用——系统没把温度升回来；
- 你靠"意志力"拧不动它——**你不能用命令去修一个坏掉的温控器。**

2.2 这个"恒温器"靠什么运转？——三样东西

不需要记名字，知道大概分工即可：

系统（简化说法）	相当于	在双相里的角色
生物节律 / 生物钟（含睡眠中枢）	恒温器的"主电源"	管你几点睡、几点起、白天有没有精神。**它一旦被打乱（熬夜、倒时差、作息颠倒），整台机器就容易失控转躁**
神经递质系统	恒温器里的"调温旋钮"	多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺等"信使"负责情绪和精力的开关；过高就亢奋话多睡少，过低就低落没劲
遗传易感性	这台恒温器出厂时的"敏感度"	有的人家用电器天生就容易跳闸——双相有明显家族聚集性

【临床共识】双相和单相抑郁最大的生理差别之一，就在于**生物节律系统**：双相患者的生物钟、睡眠-觉醒周期本来就更"脆"，一点点节律紊乱就可能把情绪整个甩出去。这也是为什么医生反复强调"规律作息、别熬夜"——**对普通人只是建议，对双相患者这是治疗的一部分。**

2.3 机器是怎么被"推出正常区间"的？——触发链条

恒温器不会一天就坏。通常是**底子（遗传易感性）+ 导火索（压力/睡眠剥夺）**一起把它推出去的：

【研究结论】下面这条链条，是双相转躁最经典的路径：

1. **压力事件**（加班冲刺、失恋、搬家、吵架、重大变故）→ 人开始**熬夜、作息乱、睡眠被剥夺**；
2. 睡眠一乱，生物钟"主电源"不稳 → 情绪恒温器开始**往上飘**；
3. 飘起来后，人更不想睡、更兴奋、更爱做事 → **睡眠进一步减少**；
4. 睡眠越少 → 情绪越飘；情绪越飘 → 越不需要睡——这是个**恶性循环**，直到一段完整的躁狂/轻躁狂发作形成；
5. 那阵风烧完，能量耗尽，人又**重重摔进抑郁相。**

【个人体验】很多患者回头看才发现规律："我每次'飘'之前，都有一段特别忙、特别晚睡、连轴转的日子。"——**睡眠剥夺和作息紊乱，是双相转躁最常见、也最能自我管理的诱因。** 这也是为什么后面模块7会花一整节讲"规律作息和社会节律"。

2.4 还有哪些"推手"？

推手	怎么把情绪甩出去
遗传/家族史	直系亲属有双相、抑郁，患病风险明显更高（是"风险高"，不是"必然"）
睡眠剥夺 / 倒班 / 跨时区	直接扰动生物钟，最容易转躁
长期高压、重大生活变故	像一直给坏了的恒温器通电
酒精、兴奋剂、某些物质	可能诱发或加重躁狂
不当用药	**尤其抗抑郁药单药使用**，可能把抑郁相"推"成躁狂/快速循环——这就是为什么初诊要反复排查双相
躯体问题	如甲状腺功能异常、感染后状态，会伪装或加重情绪波动

【临床共识】注意一个重点：**不是你"想太多"把自己搞成这样，而是一套有生物学基础的调节系统失灵了。** 你可以把它理解成"情绪和睡眠的生物钟偏敏感"——和有的人天生对花粉过敏、对寒冷敏感一样，不是道德问题。

2.5 那它能被"调回去"吗？

能。而且理解原理后你会发现，治疗思路完全对得上：

- **药物（心境稳定剂等）** = 给坏了的恒温器换一个**稳定的调温旋钮**，让情绪不再轻易冲到极端；
- **规律作息、保护睡眠（IPSRT 人际社会节律治疗）** = 稳住那台机器的**主电源**，不让它被熬夜、倒时差轻易掀翻；
- **心理治疗、识别早期信号** = 学会在温度刚要飘走时就发现、及时处理，而不是等到烧成大火；
- **减少触发** = 少熬夜、少硬扛高压、用药遵医嘱，别再故意去踹那台坏机器。

【个人体验】很多患者做完这一步的感觉是："原来我不是'疯了一阵又丧一阵'，我是**身体里那个管情绪和睡觉的开关松了**——那它就有办法拧紧。"

2.6 把这一页浓缩成三句话

1. **你不是性格疯，是大脑里那个"情绪+睡眠"的恒温器失灵了**——这是个可以校准的系统问题，不是道德问题。
2. **睡眠一乱，情绪就容易被甩出去**——对双相患者，规律作息不是养生口号，是治疗。
3. **它不是一天坏的，也不会一天修好**——但通过规范治疗 + 稳住节律，多数人能让这个过山车慢下来、不再冲到轨道外。

【临床共识】理解这些原理，不是让你自我诊断或自我用药，而是让你在治疗时不再觉得"我这人没救了"——你经历的每一次大起大落，都是这套系统在诚实地向你报告：**它需要被认真地、长期地照顾了。**

参考来源

- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management（病因与维持治疗章节）
- 世界卫生组织：Depressive disorder 事实清单
- 国际双相障碍学会（ISBD）/ 国际社会节律治疗研究：关于睡眠-觉醒节律与转躁的研究综述
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 病因学章节
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》病理生理章节

3. 误区辟谣

> 病耻感和浪漫化，是双相患者迟迟不就医、偷偷停药、硬扛不求助的两大原因。外界一句"你不就是喜怒无常""你那是天才病、别治傻了"，对正在发作的人来说，可能等于在说"你的痛苦和危险都是你自己的错"。本页用"误区 → 为什么错 → 正确认识"的对照表，把最常见的误解一次拆穿。**本页不替代面诊，用药与治疗请遵精神科医生医嘱。**

3.1 关于"性格"和"天才病"

误区说法	为什么错	正确认识
"双相就是性格古怪、喜怒无常、情绪化"	双相的大起大落是**一段段持续数天到数周、自己收不回、并造成功能损害的发作**，不是日常那种一时高兴一时赌气。把它说成"性格"，等于把哮喘说成"爱喘气"。【临床共识】	它是病，不是脾气。需要的是识别和治疗。
"躁狂期效率高、灵感多，是天才病，别治没了"	【个人体验】这是患者最舍不得放手的一条。但轻躁狂/躁狂那阵子的"高产"，常常伴随着**挥霍、辞职、关系破裂、高危行为**；而且那阵风过后，往往是**更长更深的抑郁**。那点"灵感"，是用后面几个月甚至几年的代价换的。【临床共识】	真正稳定后那种"平稳的高效"，比发病时的"亢奋高产"珍贵得多，也可持续得多。
"有双相的人都特别聪明、有艺术天赋"	把病浪漫化最危险。事实是：**双相不挑智商，普通人、普通人的工作、普通人的家庭都会得**；它带来的痛苦和风险是真实的，和"天赋"没有必然因果。【争议观点】	拿"天才病"美化它，只会耽误那些不够"天才"的患者就医。
"你就是意志力差、控制不住脾气"	躁狂/混合发作期，大脑的冲动控制和睡眠节律系统已经失控，**理智上知道不对，身体停不下来**。这就像对一个发烧的人说"你意志坚强点就不烧了"。【临床共识】	意志力要用在"按时复诊、规律作息"上，而不是硬扛发作。

3.2 关于药物

误区说法	为什么错	正确认识
"吃药会把人吃傻、把情绪压平，变成木头人"	规范使用心境稳定剂，目标是**把情绪从极端拉回正常区间**，不是把人压成麻木。部分人初期会有手抖、犯困、反应慢等副作用，但医生会调整；长期来看，**稳定下来的人比发作时更清醒、更有创造力**。【临床共识】	真正让人"变傻、变迟钝"的，是反复发作本身和漏服停药导致的一次次失控。
"是药三分毒，能不吃就不吃，靠自己调节"	双相是**复发率高**的病，尤其有过多次发作后，单靠"心态调整"很难长期稳住；不规范治疗的代价是一次次躁狂/抑郁发作和冲动损失。该维持治疗时不维持，反而更糟。【临床共识】	用哪种药、用多久、怎么监测，由医生权衡；自行停药风险更大（见下条）。
"感觉好点了，就自己把药停了"	【临床共识】双相最危险的操作之一就是**自行停药/漏服**。症状缓解后通常需要维持治疗防复发；突然停药可能诱发**撤药反应和新一轮、甚至更猛的转躁**。	停药、减药的时机让医生定，绝不能自己拍脑袋。

误区说法	为什么错	正确认识
"我只是抑郁，为什么给我开'情绪稳定剂'？我要抗抑郁药"	【临床共识】这是双相治疗的核心：**双相抑郁单用抗抑郁药，可能诱发转躁、加快循环**。医生给你加心境稳定剂，不是"多开药"，是在保护你别被"推"进躁狂。	初诊被追问"有没有飘起来的时候"、被开心境稳定剂，恰恰是医生在认真对你负责。
"锂盐那些药副作用大，伤肾伤甲状腺"	碳酸锂等心境稳定剂确实需要**定期抽血监测血药浓度、肾功能、甲状腺功能**——这是规范治疗的一部分，恰恰说明它可控、可监测，而不是"吃了就完蛋"。【临床共识】	该监测就监测、该复查就复查，比盲目害怕强得多。

3.3 关于"靠自己调整"

误区说法	为什么错	正确认识
"只要心态好、想开点，双相自己会好"	轻躁狂那阵风可能自己过去，但**它会再来，而且常常伴随更重的抑郁和冲动损失**。心态调整是辅助，替代不了心境稳定剂和节律管理。【临床共识】	自我调节放进稳定期用；急性期先就医。
"出去玩一趟、旅旅游就好了"	短期离开压力源可能缓解，但只要生物节律被打乱（熬夜、倒时差），旅游反而可能**诱发转躁**。很多患者"出去玩那几天飘上天，回来直接抑郁两周"。	休假要尽量保持作息；它不是治疗本身。
"运动、冥想就能治好，不用看医生"	规律运动、正念对稳定期有明确辅助作用，但**不能替代急性期的药物和专业随访**。	把它们放进你的长期康复计划里，但先去看医生、把急性期稳住。
"躁狂就是开心、兴奋，有什么好治的"	躁狂期不只是开心：它常伴**极度易激惹、冲动、伤人毁物、挥霍、高危行为**，混合期更是亢奋与绝望并存。那种"兴奋"往往事后让人付出巨大代价。【临床共识】	躁狂期是**需要干预的高风险状态**，不是"人逢喜事精神爽"。

3.4 关于"预后"

误区说法	为什么错	正确认识
"得了双相就一辈子完了，废了"	双相是**可治疗、可管理**的病。多数患者经过规范治疗（心境稳定剂 + 心理治疗 + 规律作息）可以显著减少发作、恢复工作和家庭功能，过上完整的生活。【研究结论】	它像高血压、哮喘一样需要长期管理，但不等于人生被判了死刑。
"双相最后都会变成精神病/精神分裂"	**不会。** 双相和精神分裂是两类病；严重躁狂期可能短暂出现夸大等精神病性症状，但发作过后恢复，不会进行性变成精神分裂。【临床共识】	不必自己吓自己。
"反正会复发，治不治都一样"	不对。复发确实常见，但**早治、规范维持、规律作息、识别早期信号**，能明显拉长发作间隔、减轻每次的严重程度。治与不治，长期结局差别很大。【临床共识】	你做的每一件稳定的事，都在减少下一次被甩出去的概率。
"看精神科很丢人、会留案底"	双相的门诊/随访病历属于个人敏感医疗信息，受法律保护，与所谓"案底"、无犯罪记录无关。【临床共识】	愿意为自己健康负责、坚持复诊的人，是勇敢的人。

3.5 给正在读这一页的你三句话

1. **这不是你的错。** 双相是有生物学基础（遗传 + 生物节律 + 神经递质）的疾病，不是性格缺陷。
2. **别贪恋躁狂期那点"爽"。** 它是要还的，而且往往连本带利。
3. **"我又开始睡很少、又开始停不下来"不是天赋，是警报。** 那是你该联系医生、稳住作息的时候。

参考来源

- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management
- 世界卫生组织：Depressive disorder 事实清单
- 国际双相障碍学会（ISBD）：科普与治疗共识
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普资源

4. 患病特点与可康复性

> 这一页写给"已经被诊断、或者高度怀疑自己可能是"的你。读完你会知道：**这个病通常什么时候找上门、它会不会好、好了之后会不会复发、复发了怎么办。** 核心结论先行：双相是**可治疗、可康复**的疾病，多数人经过规范治疗能恢复正常工作生活；它可能像高血压、哮喘一样需要长期管理，但不影响你去爱、去工作、拥有想要的人生。

4.1 双相通常有哪些特点

特点	具体表现	对你的意义
发病偏早	首次发作多在**青少年晚期到 20 多岁**；很多人十几岁起就"比别人情绪起伏大"，成年后第一次明确大发作	如果你从年轻时就容易大起大落，不是你"矫情"，是这个病本来就早发
反复发作、波动	不是一锤子买卖，而是**一阵躁狂/轻躁狂、一阵抑郁，中间夹着长短不一的平稳期**	波动是这个病的本来面貌，不是"你又搞砸了"
发作间期多可恢复	多数人在两次发作之间，**社会功能能恢复到接近病前水平**——能工作、能爱人、能社交	这是它和"进行性衰退"类疾病最大的不同，也是希望所在
常被先当成"抑郁症"	双相 II 型尤其如此：人来时总是低落相，轻躁狂被当成"我终于好了"，**平均要拖好几年才被正确识别**	这不是你的错，但越早就医、越早就对方向，越好
睡眠/节律特别敏感	熬夜、倒时差、倒班、作息一乱，就容易被"甩"进躁狂	规律作息对你不是养生，是治疗
容易共病	常合并焦虑、物质使用问题、注意力问题等	治疗时医生会一起评估，不是只盯"情绪"

【临床共识】**越早识别、越早规范治疗，长期结局越好。** 拖得越久、发作次数越多，越容易走向慢性化和快速循环。

4.2 它会不会好？——预后的真实样子

【研究结论】综合 NICE 指南和《中国双相障碍防治指南》，可以这样客观地告诉你：

- **双相是发作性的病**：每次发作大多能**自行缓解**，发作间期社会功能多可恢复——这是它"可康复"的基础；
- **但它也是容易复发的病**：有过一次发作后，若不维持治疗，未来再次发作的概率较高；发作次数越多，复发倾向越强；
- **规范治疗能显著改变结局**：坚持心境稳定剂维持 + 心理治疗 + 规律作息的人，发作间隔明显拉长、每次严重程度明显减轻，很多人可以长期稳定、正常生活；
- **不是"治愈到永远不再发"，而是"学会管理，让它不影响人生"。**

【个人体验】很多患者治疗一两年后回头看，会说同一句话："我早知道这样，就不该自己硬扛那几年、不该随便停药。"——**稳定下来的速度和质量，往往比你最悲观时想象的好。**

4.3 会不会复发？——会，但可以管理

【临床共识】双相**容易复发**，但"复发"≠"治不好"，就像哮喘、糖尿病会反复，长期管理下可以不影响生活质量。

复发/转躁最常见的诱因：

- **自行停药、减药、漏服**（最常见、最不该）；
- **睡眠剥夺、熬夜、倒时差、作息紊乱**；
- 长期高压、重大生活变故（失业、失恋、家人生病）；
- 酒精、兴奋剂、某些物质；
- 躯体问题（如甲状腺功能异常）、用药不当（尤其抗抑郁药单药）。

降低复发的有效做法：

1. **症状缓解后仍按医嘱维持治疗**，不自行停药；需要停药时由医生安排、逐步来；
2. **死守住睡眠和作息**——固定起床睡觉时间，这是最便宜也最有效的"防转躁药"；
3. **识别早期信号**（见下方清单），刚冒头就联系医生，别等烧成大火；
4. **继续做心理治疗学到的东西**（情绪监测、社会节律、家庭沟通）；
5. **稳定的社会支持**：哪怕只有 1–2 个懂你的家人或朋友。

4.4 早期复发信号自查清单（可抄下来给家人看）

下面这些，是很多患者和家属共同总结出来的"又要飘了"或"又要沉了"的苗头。**一旦连续几天出现，就是联系医生、调整作息的信号，而不是新的灾难。**

要转躁/轻躁狂的早期信号：

- [ ] 最近连续几天**睡得明显变少，却不觉得困**
- [ ] 话变多、脑子转得快、想法一个接一个
- [ ] 开始大手大脚花钱、疯狂购物、乱投资
- [ ] 变得特别自信、觉得自己"什么都行"
- [ ] 容易烦躁、一点小事就想跟人吵
- [ ] 计划突然变得又多又大、停不下来

要转抑郁的早期信号：

- [ ] 开始睡不醒或睡不着、不想动、不想见人
- [ ] 对以前喜欢的事提不起劲
- [ ] 觉得"做什么都没意义"
- [ ] 注意力、胃口明显变差

> 出现上面任何一组信号，**先做两件事**：① 告诉一个你信任的家人/朋友；② 尽快联系你的精神科医生或复诊。不要自己加药、减药。

4.5 一个重要的类比：把双相当"高血压/哮喘"长期管理

维度	高血压/哮喘	双相障碍
急性发作	血压飙升 / 哮喘急性发作	躁狂/轻躁狂发作、重度抑郁发作
平时状态	不发作时和常人一样	缓解期可正常工作生活、谈恋爱
长期用药	降压药 / 吸入药维持	心境稳定剂等维持治疗
生活方式	低盐、规律作息、避免诱因	**规律睡眠作息、减压、避免物质**
复发	停药、熬夜时可能反弹	停药、熬夜、高压时可能转躁/转郁
社会观感	没人说高血压患者"软弱"	却有人说双相患者"喜怒无常"——**这是偏见，不是事实**

【临床共识】**你不需要"彻底根治"双相，你需要学会和它共处。** 像高血压患者学会"哪天该量血压、哪天该避免诱因"一样，你会慢慢知道自己的触发点、早期信号、该找谁。这种管理能力一旦学会，是一辈子的。

4.6 去羞耻化：你不是一个人在战斗

【个人体验】这是患者最常说的几句话，留给你：

> "我以为只有我会半夜三点精神百倍、然后躺两周起不来，后来发现病友群里一大把。"
>
> "我花了好几年才敢告诉我爱人，他说'原来你那些年不是矫情，是病啊'。"
>
> "那些让我羞愧的挥霍、发脾气、躺平，原来都是一次次发作，不是我这个人烂。"

【临床共识】**病耻感是社会问题，不是你的问题。** 你不需要为一种疾病道歉，就像你不会为高血压道歉一样。愿意面对它、规范治疗、慢慢康复的人，值得被尊重——包括被你自己尊重。

4.7 给你的三句话

1. **多数人能稳定下来，你也是。** 双相是可治疗、可管理的病。
2. **复发不代表失败。** 像管理高血压一样管理它，而不是被它吓退。
3. **守住睡眠、别自行停药、早识别信号**——这三件事，比你想象的更能左右你的未来。

参考来源

- NICE：CG185 Bipolar disorder: assessment and management（预后与复发预防章节）
- 世界卫生组织：Depressive disorder 事实清单
- 国际双相障碍学会（ISBD）：双相障碍维持治疗与复发管理共识
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南（第二版）》预后与复发预防章节
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普资源

模块 3

症状表现

1. 躁狂发作

> 躁狂发作不是"心情特别好"，而是一种**情绪、思维、精力同时被拧到最大档**的病理性高涨：你可能连续几天几夜不睡却毫无困意，话多到停不下来，觉得自己无所不能，然后做出冲动消费、盲目投资、高危性行为、鲁莽驾驶等事后追悔莫及的事。本页帮你把"那种不对劲的高"翻译清楚——**它不是天赋降临，是病的症状；对照不用于自我确诊，最终由精神科医生面诊判断。**

1.1 什么是躁狂发作

【临床共识】躁狂发作（manic episode）是双相 I 型障碍的核心事件：在**至少连续 1 周**的几乎每一天、大部分时间里，出现明显异常的**心境高涨、扩张或易激惹**，同时伴有**活动增多或精力增加**，症状足以严重损害社会功能、需要住院，或伴有精神病性症状（如幻觉、妄想）。

【个人体验】经历过的人这样描述它：

> "那段时间我一天只睡两三个小时，白天还精神得像充了电。我觉得自己突然开了窍，要辞职创业、要把所有积蓄投进去、还要同时追两个人。"
> "我不觉得我有病，我觉得我'终于活过来了'。是我妈说我三天没合眼、说话别人根本插不上嘴，硬把我拉去医院的。"
> "我全程在发火——谁劝我，我跟谁吵，觉得全世界都在阻拦我做一件大事。"

1.2 诊断标准里的"三高"与七个伴随症状

【临床共识】诊断躁狂发作，核心是**心境异常**加上**活动/精力异常**，并在下列伴随症状中出现 ≥ 3 项（若心境仅表现为易激惹，则需 ≥ 4 项）：

类别	具体症状
自我评价过高 / 夸大	从"我今天状态真好"到坚信自己有特殊天赋、身份、超能力，甚至妄想级别
睡眠需要减少	**注意：是"睡得很少却不觉得困"，不是"想睡睡不着"**——连续只睡 2～3 小时仍精力旺盛
话多	说话又快又响、别人插不上嘴、强迫性地说个不停，感觉"不说不行"
思维奔逸	脑子里念头一个接一个飞快跳转，主观体验为"思维赛跑""舌头追不上脑子"
注意力容易被吸引	注意力随境转移，鸡毛蒜皮的小事都能把思路拉走，想法像脱缰的弹珠台
目标指向活动增多	工作、学习、社交、性活动、制定宏大计划同时爆增；坐不住
冲动/高风险行为	挥霍、盲目投资、鲁莽驾驶、不安全性行为、愚蠢的商业决策——事后常追悔

1.3 按"情绪 / 思维 / 躯体 / 行为"四个角度拆解

① 情绪症状

【个人体验】两种完全不同的"高"：

- **高涨/扩张型**：莫名的欣快、话痨、对谁都热情、觉得世界无比美好，"看人都顺眼"；
- **易激惹型**：一点就着、极度不耐烦、挑剔、和人吵架甚至动手——这一型在临床上非常常见，尤其在男性患者中。

【临床共识】情绪可以在这两极之间快速摆动：上一秒还春风得意，下一秒因为一件小事暴怒，再下一秒又跌到委屈想哭——这就接近后面要讲的"混合特征"。

② 思维症状

- **夸大**：从轻度的"我能力特别强"到妄想级别的"我是天选之人""我认识大人物""我有发明能改变世界"；
- **思维奔逸**：说话从一个话题跳到另一个话题，旁人听起来"前言不搭后语"，但患者自己觉得逻辑飞快、处处是灵感；
- **注意随境转移**：谈话中突然被窗外的车声、手机的一条通知带走思路。

【临床共识】当夸大达到坚信不疑、与现实完全脱节的程度（如坚信自己腰缠万贯、有特殊使命），就属于**精神病性症状**——这往往提示发作更重、需要尽快医疗介入。

③ 躯体症状

- **睡眠需要显著减少**（关键鉴别点，见下）；
- 不知疲倦，连续活动一整天仍觉得"还能再战五百回合"；
- 坐立不安、来回踱步、手抖、心跳加快；
- 食欲下降（光顾着兴奋，忘了吃）；
- 有的患者几天几夜不睡、不喝不吃，身体快速透支。

④ 行为症状

行为类别	典型表现	事后代价
挥霍	疯狂购物、买根本用不上的东西、打赏主播、大额转账	负债、信用卡爆掉
盲目投资/创业	辞职、押上全部身家做"大项目"、频繁借钱	钱财尽失、家庭矛盾
高危性行为	一夜情、不加保护、与陌生人发生关系	性传播感染、意外怀孕、关系破裂
鲁莽驾驶	超速、飙车、酒驾、危险并线	交通事故、法律后果
激越/冲动伤人	吵架、摔东西、与人肢体冲突	肇事肇祸、报警、受伤
社交/工作爆炸式增多	通宵聚会、同时开几个项目、疯狂发朋友圈	体力透支、人际关系崩盘

1.4 关键鉴别：睡眠需要减少 ≠ 失眠

【临床共识】这是家属和患者本人最容易误判的一点，请务必记住：

维度	躁狂的"睡眠需要减少"	普通失眠/焦虑的"睡不着"
主观感受	**睡得少，但不困、不难受，甚至觉得不需要睡**	想睡但睡不着，痛苦、疲惫
白天状态	精力旺盛、坐不住、话多	疲惫、头昏、注意力差
驱动力	"我有太多事要做，舍不得睡"	"我想睡，但脑子停不下来"
常见场景	连续几天只睡 2～3 小时仍通宵干活/聚会	入睡困难、早醒，白天补觉

【个人体验】家属常说的一句话是："他/她不是失眠，是根本不睡，还越不睡越精神。"——当你身边有人出现这种模式，而不是普通的辗转反侧，就要高度警惕躁狂可能。

1.5 严重程度：什么时候算"躁狂"而不是"状态好"

【临床共识】同样是"话多、兴奋、效率高"，医学上怎么区分？

维度	一般的"状态好"	病理性躁狂
持续时间	几小时到一两天，自然回落	**≥ 1 周**几乎天天如此
功能影响	提高效率、开心	**明显损害**工作、人际、财务，或需住院
判断能力	知道自己兴奋，能收敛	缺乏自知力，不觉得有问题
冲动行为	有分寸	出现挥霍、高危行为、夸张计划
精神病性症状	无	可出现夸大妄想、幻听等
身边人反应	"你今天气色不错"	"你不对劲，我们很担心"

1.6 躁狂发作自查清单（可打印）

> 用法：过去至少一周，几乎每天大部分时间里，下列条目符合打勾。**勾中越多、且已经影响生活/财务/关系，请尽快到精神科就诊；若出现冲动伤人、自伤、严重挥霍或彻夜不眠，请联系家属立即就医。**

- [ ] 心情异常高涨、特别开心，或者特别容易发火，持续 ≥ 1 周
- [ ] 一天只睡很少（如 2～3 小时）却不觉得困，白天依然精力旺盛
- [ ] 话多到别人插不上嘴，或者说话又快又大声、停不下来
- [ ] 脑子里念头飞转、一个接一个，觉得"灵感爆发"
- [ ] 自我评价异常膨胀，觉得自己特别厉害、有特殊计划/使命
- [ ] 注意力特别容易被小事带跑，没法专注一件事
- [ ] 同时爆增很多活动：疯狂购物、盲目投资、频繁社交、通宵聚会
- [ ] 出现挥霍、盲目投资、高危性行为、鲁莽驾驶等冲动行为

- [ ] 家人/朋友明确说"你最近不对劲"，并为此担心
- [ ] 出现坚信不疑的夸大想法、听到不存在的声音等（**此条为紧急信号**）

1.7 给患者和家属的三句话

1. **"我状态好、效率高"不一定是真的好**——当它持续一周以上、伴随睡眠需要减少和冲动行为，往往是躁狂发作。
2. **本人常常不自知**，这正是这个病最麻烦的地方；家属的观察往往比患者本人更早、更准。
3. **及早干预，恢复得更快、代价更小**——不要等挥霍了一大笔钱、出了交通事故、闹到要住院才就医。

> 安全提示：若首次出现剧烈胸痛、意识不清、抽搐等躯体急症信号，请先拨打 120 排除躯体疾病，不要把身体问题误当情绪问题硬扛。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 躁狂发作诊断标准
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar type I disorder (6A60)
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》躁狂发作章节
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

2. 轻躁狂发作

> 轻躁狂是一种**较轻的"高"**：持续 ≥ 4 天，你确实更外向、更自信、效率更高、睡得更少，但它**不会让你彻底失控、不需要住院、也没有幻觉妄想**。最麻烦的是——**你自己往往觉得这是"人生巅峰状态"，根本不觉得是病；而家人朋友却比你更早察觉"你不对劲"。** 本页帮你分清"状态好"和"轻躁狂"，并理解它为什么对双相 II 型如此关键。

2.1 什么是轻躁狂发作

【临床共识】轻躁狂发作（hypomanic episode）在症状种类上与躁狂发作**基本相同**（心境高涨/易激惹、活动增多/精力增加、睡眠需要减少、话多、思维奔逸、夸大、注意随境转移、冲动行为），但有三个关键区别：

维度	躁狂发作	轻躁狂发作
持续时间	≥ 1 周	**≥ 4 天**
社会功能损害	严重损害，需住院或伴精神病性症状	**无显著功能损害**，尚能维持基本生活和工作
精神病性症状	可有	**绝无**（出现即升级为躁狂）
自知力	常丧失，不觉得有病	可能隐约觉得"状态好"，但周围人会察觉变化

【个人体验】轻躁狂的典型自述：

> "那段时间我特别自信，开会发言思路清晰，连续几天只睡 4 小时就精力充沛，见谁都想打招呼。我以为自己终于'开窍了'。"
> "我老婆说我那阵子买东西特别大手大脚、每天换一个新计划，她说'你跟平时不一样'。我还跟她吵，说她见不得我好。"
> "我比平时外向得多，话多、爱组织聚会、工作效率奇高。但同事后来提醒我：你那两周做的几个决定，现在回头看都很草率。"

2.2 为什么轻躁狂特别容易被漏掉

【临床共识】轻躁狂是双相障碍里**最容易被漏诊、误诊**的一段，原因有三：

1. **患者本人不觉得难受**——它带来的是"爽"的感觉，不是痛苦；
2. **没有明显功能崩溃**——还能上班、还能社交，外人甚至觉得"你最近状态真不错"；
3. **它常常跟着一次抑郁发作来**——患者因为痛苦的抑郁去看病，却从不主动提那段"好时光"。

【研究结论】临床上相当一部分"单相抑郁症"患者，其实是**双相 II 型**：他们只在抑郁相求助，而那段被自己当作"状态好"的轻躁狂被完全忽略了。这也是为什么医生会反复追问："你有没有过一段时间，特别兴奋、睡得少、话多、跟平时明显不一样？"

2.3 轻躁狂 vs 躁狂 vs 正常的"状态好"

维度	正常的好心情/高效率	轻躁狂	躁狂
持续时间	几小时～1～2 天，自然回落	**≥ 4 天**几乎天天如此	≥ 1 周
睡眠	正常睡，或略少但白天累	**睡得少却不困**，精力旺盛	睡眠需要显著减少，通宵不睡
功能	提升，且能收敛	基本正常，但可出现草率决定	明显损害，需住院/伴精神病性症状
判断力	有分寸	轻度膨胀，偶有小冲动	明显失控，挥霍/高危行为
周围人评价	"你今天气色不错"	**"你跟平时不一样，有点过了"**	"你疯了，我们必须带你去医院"
自知力	清楚	可能隐约觉得"状态好"	常完全丧失

2.4 轻躁狂自查清单（可打印）

> 用法：下列变化是否在**连续至少 4 天**里，几乎每天大部分时间都存在，且与你平时的 baseline（平时状态）明显不同？**勾中越多，越值得在就诊时主动告诉医生。**

- [ ] 心境异常高涨、特别乐观自信，或者特别容易烦躁
- [ ] 睡得比平时少很多（如每天只睡 4～5 小时）却不觉得困、白天依然精神
- [ ] 话比平时多、说话快、喜欢主动找人聊
- [ ] 脑子里灵感不断、念头比平时多很多
- [ ] 自我评价升高，觉得自己特别能干、特别有魅力
- [ ] 同时做很多事：工作狂、疯狂社交、突然开始一堆新计划
- [ ] 花钱比平时大手大脚，或做了几个后来后悔的草率决定
- [ ] 比平时更爱冒险、更冲动（如冲动消费、飙车、大胆搭讪）
- [ ] 注意力比平时更容易被小事带跑
- [ ] 家人/朋友明确说："你最近跟平时不一样"

【个人体验】一个简单的自测角度：**"如果连续两周你都处于这种'开挂'状态，身边至少有一个人提醒过你不对劲——那它就不只是'状态好'。"**

2.5 家人往往比本人更早察觉

【临床共识】因为轻躁狂本人的主观体验是愉快的，所以**家属、同事、老朋友往往是第一个发现"你变了"的人。**下面这些家属视角的描述，对识别轻躁狂非常有价值：

家属观察到的变化	可能提示
"他最近特别能花钱，买了一堆没用的东西"	挥霍倾向
"她每天只睡三四个小时，还说自己不需要睡"	睡眠需要减少
"他说话特别多、特别快，别人根本插不上嘴"	话多/思维奔逸

家属观察到的变化	可能提示
"她突然辞职、要创业、要投资一个完全不懂的项目"	夸大+盲目计划
"他对谁都过度热情，甚至跟陌生人称兄道弟"	情感高涨/脱抑制
"她变得特别容易发火，一点小事就炸"	易激惹型轻躁狂

> 给家属的一句话：**"他状态好"和"他病了"之间，差的往往就是你观察到的这些"小不对劲"。** 把这些变化记下来，就诊时带给医生，非常关键。

2.6 轻躁狂在双相分型里的位置

【临床共识】记住这条核心规则：

- **双相 I 型**：至少有过一次**躁狂发作**（轻躁狂可有可无）；
- **双相 II 型**：至少有过一次**重性抑郁发作** + 至少一次**轻躁狂发作**，**从没有过完整的躁狂发作**；
- 如果你有过轻躁狂 + 反复抑郁，却一直被当成"单相抑郁"治疗，要特别警惕——**单用抗抑郁药可能诱发转躁或快速循环**（详见模块 4 与模块 7）。

【争议观点】临床上对"阈下轻躁狂""软双相"等概念存在讨论——有些人的轻躁狂很轻、很短、不典型。这部分边界情况需要医生综合判断，不是靠自我对照就能下结论的。

2.7 给患者的三句话

1. **"我状态特别好"不一定是真的好**——持续 4 天以上的兴奋、少睡、多话，可能就是轻躁狂。
2. **主动把这段"好时光"告诉医生**——它直接决定你是"单相抑郁"还是"双相 II 型"，治疗方向完全不同。
3. **被家人提醒时，先别急着生气**——他们看到的，往往是你自己看不到的那部分。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 轻躁狂发作（Hypomanic Episode）诊断标准
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar type II disorder (6A61)
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》双相 II 型与轻躁狂章节
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

3. 抑郁发作（双相抑郁相）

> 双相障碍的患者，一生中**大部分时间其实是在抑郁相里**——情绪低落、兴趣丧失、精力下降、思维迟缓、自责、睡不好或睡不醒、吃不下或暴食、注意力差、出现消极念头。它的"样子"和单相抑郁症非常像，但**治疗方向常常不一样**：误把它当单相抑郁单用抗抑郁药，可能诱发转躁或快速循环。本页帮你识别双相抑郁相，并理解它和单相抑郁的细微差别。

3.1 双相抑郁相的核心症状

【临床共识】双相抑郁相的症状与重性抑郁发作基本一致：在**至少连续 2 周**里，几乎每天大部分时间出现下列核心症状，且造成痛苦或功能损害：

类别	具体表现
情绪	情绪低落、悲伤、空虚、麻木；易激惹（尤其男性、青少年）
兴趣/快感	兴趣减退、快感缺失——以前喜欢的事提不起劲
精力	精力下降、持续疲劳、"连刷牙都要动员半天"
思维	思维迟缓、注意力下降、犹豫不决、自我评价过低、自责自罪、无价值感
躯体	睡眠改变（失眠或嗜睡）、食欲/体重改变（下降或上升）
行为	行动迟缓或烦躁不安；社交退缩；出现消极/自伤念头

【个人体验】双相患者描述抑郁相的几句话：

> "不是普通的心情不好，是那种从骨头里透出来的沉——像穿了件湿透的棉袄，脱不掉。"
> "我理智上知道以前喜欢打游戏，但现在手柄拿到手里，'哦'一声就放下了。"
> "我一天能睡 12 个小时还是累，醒着也只想躺着，连手机都不想刷。"

3.2 双相抑郁相 vs 单相抑郁：治疗方向为什么不同

【临床共识】这是本页最重要的一点：**双相抑郁相在表面上和单相抑郁几乎无法区分**，但治疗原则差别很大。

维度	单相抑郁	双相抑郁相
既往史	从无躁狂/轻躁狂发作	**既往有过躁狂或轻躁狂发作**
治疗主线	抗抑郁药常为主力	**以心境稳定剂/第二代抗精神病药为基础**，抗抑郁药需谨慎
单用抗抑郁药	常规选择	**可能诱发转躁、轻躁狂、快速循环**——须由医生评估
发作模式	相对稳定的单次/复次抑郁	**高低交替**，可在抑郁后转为躁狂/轻躁狂

【临床共识】**这正是为什么医生一定要反复追问你"以前有没有过特别兴奋、特别能睡少、特别自信的阶段"**——如果有，你就是双相抑郁相，而不是单相抑郁。这个区分直接决定用药方案。

3.3 哪些"线索"提示这可能是双相抑郁，而不是单相

【研究结论】下面这些特征，在临床上提示抑郁背后可能藏着双相，值得就诊时主动告诉医生：

线索	具体表现
嗜睡 vs 失眠	抑郁时**过度睡眠**（一天睡 10～14 小时仍累），而不是典型的早醒、入睡困难
暴食 vs 食欲下降	抑郁时**食欲亢进、体重增加**，尤其偏好碳水化合物
运动性迟滞	动作明显变慢、说话变慢、整个人"卡住"，而不是焦虑性烦躁
情绪反应性	遇到好事时情绪能暂时好转（而单相抑郁常持续低沉）
症状突发突止	抑郁来得突然、缓解也快，发作之间有相对"正常"的间歇
季节模式	秋冬抑郁、春季/夏季转为高涨，呈季节性交替
发作年龄早	青少年或 20 岁出头就出现第一次抑郁发作
多次抑郁发作	反复多次抑郁，且对抗抑郁药反应"特别好"或"特别快转躁"
家族史	一级亲属有双相障碍患者
不典型特征	灌铅样肢体沉重、被人压制感、对拒绝过度敏感

【争议观点】这些线索只是"提示"，不是诊断标准——最终分型必须由精神科医生结合完整病史判断。但你主动提供这些信息，能大大减少误诊。

3.4 双相抑郁相自查清单（可打印）

> 用法：最近至少 2 周，几乎每天大部分时间符合打勾。**若出现具体的自伤/自杀计划或觉得自己控制不住，请立即告诉身边人并拨打 12356 心理援助热线，或前往医院急诊。**

- [ ] 情绪低落、空虚、麻木，几乎每天如此
- [ ] 对以前喜欢的事提不起兴趣，感受不到快乐
- [ ] 精力明显下降，做小事都觉得吃力
- [ ] 睡眠改变：失眠、早醒，**或**睡得过多仍疲惫
- [ ] 食欲/体重改变：明显下降，**或**暴食、体重上升
- [ ] 思维变慢、注意力下降、做决定困难
- [ ] 自我评价低、自责、觉得自己没用/没希望
- [ ] 行动明显变慢，或坐立不安
- [ ] 反复想到死、自伤，或出现具体计划（**此条为紧急信号**）
- [ ] 既往有过"特别兴奋、少睡、话多、效率爆表"的阶段（**此条提示需告知医生**）

3.5 一个必须单独说的红灯：自伤/自杀念头

【个人体验】在抑郁相最低落的时候，脑子里可能冒出"如果我不在了，大家都轻松""活着没什么意思"这种念头。这是**疾病本身的症状**，不是你这个人"坏"或"对不起谁"。

【临床共识】**一旦你出现具体的自伤或自杀计划、或者觉得自己可能控制不住——请立刻行动：**

- 告诉身边一个可信任的人，不要独自待着；
- 拨打全国心理援助热线 **12356**（2025 年起由国家卫生健康委推出的统一心理援助热线，24 小时免费；核实日期 2026-10-20，号码可能调整，以当地官方公布为准）；
- 情况紧急时直接拨打 **120** 或前往最近医院急诊；公安求助可拨 **110**。

详细的危机识别与急救步骤，见本资料库模块 8"危机识别与求助"。

3.6 给患者的三句话

1. **抑郁相不是你的错，也不是"想不开"**——它是双相障碍的一个临床相，是病，需要规范治疗。
2. **一定要告诉医生你有没有过"特别兴奋、少睡"的阶段**——这决定了你是单相还是双相，用药完全不同。
3. **不要因为"现在是低落期"就自行停药或加药**——情绪低落时最容易想"药没用"，但心境稳定剂的作用恰恰是预防转躁，需遵医嘱规律服用。

> 安全提示：首次出现剧烈胸痛、意识异常等躯体急症，请先拨打 120 排除躯体疾病，不要把身体问题误当情绪问题硬扛。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 重性抑郁发作诊断标准
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders 抑郁相章节
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（抑郁相治疗）
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》双相抑郁章节
- 国家卫生健康委员会：全国统一心理援助热线 12356 相关介绍
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

4. 混合特征与混合发作

> 混合状态是双相里**最折磨人、也最危险**的一种形态：躁狂和抑郁不是先后到来，而是**同一时间缠在一起**——你可能觉得情绪高涨却又绝望、脑子转得飞快却烦躁想砸东西、精力过剩却又空虚想哭。**混合状态的自杀风险尤其高**，因为你既有抑郁的绝望，又有躁狂带来的冲动和行动力。本页帮你识别它，并知道该怎么办。

4.1 什么是混合状态

【临床共识】想象一下：不是"先开心一周、再低落两周"的交替，而是**同一天里，甚至同一个小时里**，你同时体验到：

- 情绪**高涨/易激惹**，**同时**又**低落、绝望、空虚**；
- 思维**飞快奔逸**，**同时**又**自责、无价值感、消极念头**；
- 精力**过剩、坐不住**，**同时**又**沉重、疲惫、提不起劲**。

【个人体验】经历过的人这样描述：

> "我不是开心，也不是难过——我是躁狂的兴奋和抑郁的绝望，同时在我脑子里打架。我想大喊，又想消失。"
> "我脑子转得特别快，停不下来，每一个念头都在告诉我我有多失败。那种感觉像被按在水里，同时又被架在火上烤。"
> "我坐立不安、来回踱步，心里却空得要死。我觉得自己一无是处，却又有一股想砸东西的冲动。"

4.2 DSM-5 的"混合特征"标注 vs ICD-11 的混合发作

【临床共识】两个诊断系统对"混合"的表述略有不同，但核心一致：

系统	表述	通俗解释
DSM-5	"伴混合特征"标注（with mixed features specifier）	在躁狂/轻躁狂发作**背景**下，同时出现若干抑郁症状；或在抑郁发作背景下，同时出现若干躁狂/轻躁狂症状
ICD-11	混合性发作（mixed episode）	躁狂与抑郁症状在同一时段内**几乎每天都显著存在**，或在几小时内快速交替

【争议观点】临床上对"混合"的界定范围仍在讨论——从严格的"同时满足两套诊断标准"到较宽的"几个交叉症状"都有人用。但无论哪种界定，**它都是一种需要尽快医疗介入的危险状态**，不是"情绪波动大"那么简单。

4.3 为什么混合状态特别危险

【临床共识】这是本页必须最强调的一点：

> **混合状态的自杀风险，显著高于单纯的抑郁相或单纯的躁狂相。**

原因在于一个危险的叠加：

抑郁相给你的	躁狂/混合状态额外给你的	叠加结果
绝望、无价值感、想死的念头	**冲动、行动力、坐不住、思维奔逸**	不只是"想"，而是**有能力立刻去做**
行动迟缓、连床都下不了	**精力过剩、激越、难以安静**	有动力实施冲动行为

【研究结论】临床上观察到，混合状态患者的自伤、自杀企图、冲动行为比例都明显升高。这就是为什么医生一旦判断你处于混合状态，往往会更积极地干预、更密切地随访。

4.4 混合状态识别清单（可打印）

> 用法：如果你发现自己在**同一时段**里，同时出现"高涨/易激惹"侧和"低落/绝望"侧的多条症状，请高度警惕。**若出现任何自伤/自杀念头或冲动，请立即求助——详见本节末尾。**

"高"的一侧（躁狂/轻躁狂特征）：

- [ ] 情绪异常高涨、过度自信，或特别容易发火
- [ ] 睡得少却不困，精力旺盛
- [ ] 话多、说话快、停不下来
- [ ] 脑子转得飞快、念头一个接一个
- [ ] 坐立不安、来回踱步、有砸东西/摔东西的冲动
- [ ] 注意力随境转移、同时做很多事

"低"的一侧（抑郁特征）：

- [ ] 情绪低落、绝望、空虚、想哭
- [ ] 觉得自己没用、无价值、对不起人
- [ ] 对什么都提不起兴趣
- [ ] 想到死、自伤，或觉得"活着没意义"
- [ ] 沉重、疲惫、空虚，即使精力旺盛也觉得空

两侧同时存在 = 高度提示混合状态。

4.5 典型混合状态的"矛盾组合"

下面这些看似矛盾的组合，恰恰是混合状态的标志：

你可能同时体验到	它的本质
"我觉得自己无所不能，又觉得自己一无是处"	夸大 + 自责并存
"我脑子转得飞快，停不下来，却满脑子都是我有多失败"	思维奔逸 + 消极思维
"我精力过剩、坐不住，却又空虚绝望"	活动增多 + 快感缺失/低落

你可能同时体验到	它的本质
"我想大喊大叫，又想消失掉"	易激惹 + 自杀念头
"我一点就着，对谁都发火，事后又崩溃大哭"	易激惹 + 情绪崩溃

4.6 出现混合状态，该怎么办

【临床共识】

1. **这不是"我情绪波动大、性格差"，而是一种需要医疗干预的临床状态**——请尽快联系你的精神科医生，描述这种"同时既高又低"的感受。
2. **不要自行加药、停药或调药**——混合状态的用药调整必须由医生判断，自行改变可能加重转相或快速循环。
3. **环境安全**：把危险物品收好；不要独自待着；告诉一个你信任的家人或朋友你的状态。
4. **降低刺激**：减少咖啡因、酒精、熬夜和高强度刺激（吵的音乐、激烈的游戏、深夜刷手机）。

4.7 危机红线：混合状态的求助

【个人体验】当你处于混合状态，那种"既冲动又绝望"的感觉是最容易做出危险举动的时候。请记住：

- **任何具体的自伤/自杀念头、计划，或觉得自己控制不住冲动——请立刻行动：**
- 告诉身边一个可信任的人，**不要独自待着**；
- 拨打全国心理援助热线 **12356**（24 小时免费；核实日期 2026-10-20，号码可能调整，以当地官方公布为准）；
- 情况紧急直接拨 **120**（医疗急救）或前往最近医院急诊；公安求助拨 **110**。

【临床共识】混合状态往往恢复起来需要更积极的治疗和更密切的监测。**主动求助不是软弱，而是在最危险的时刻保护自己。**

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 "With mixed features" specifier 诊断说明
- 世界卫生组织：ICD-11 · Mixed bipolar episode 相关条目
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（混合特征与自杀风险）
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》混合发作章节
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

5. 快速循环

> 快速循环不是一种"永久人格标签"，而是一个**病程标注**：一年内出现 **≥ 4 次**情感发作（躁狂、轻躁狂、抑郁或混合），每次之间有明确的缓解期，或直接转向另一相。它让患者像坐过山车一样在高低之间频繁切换，更容易被误诊、更容易慢性化。好消息是：它**可以随治疗改变**，不是一辈子就这样了。

5.1 什么是快速循环

【临床共识】快速循环（rapid cycling）的诊断标准：

> **在过去 12 个月内，出现至少 4 次情感发作**——可以是躁狂、轻躁狂、抑郁或混合发作。每次发作需满足相应临床相的时长标准，且发作之间有**至少两个月的部分/完全缓解**，或从一相直接转向另一相。

【个人体验】经历过的人这样描述：

> "我这一年像被按了循环键——刚从低落里爬出来没两周，又开始兴奋少睡；兴奋没几天，又突然跌到谷底。我根本不知道下周的我会是什么样。"
> "别人一年最多情绪波动几次，我一个月就能高低来回一次。我不敢做任何长期计划，因为计划永远赶不上我转相。"

5.2 它"快"到什么程度

【临床共识】快速循环是一个连续谱：

模式	频率	通俗描述
典型发作	一年 1～3 次	相对稳定，高低交替间隔较长
快速循环	**一年 ≥ 4 次**	频繁切换，间歇短
超快速循环	一个月内多次	几乎每月都在转相
超超快速（每日循环）	一天内高低切换	一天里在几小时内波动，接近混合状态

【争议观点】后两种极快的模式，在临床上常与"混合特征"重叠——它们是不是独立的快速循环，还是严重混合状态，医生之间仍有讨论。但无论如何，频繁转相都提示需要更积极的治疗。

5.3 哪些因素和快速循环有关

【研究结论】临床上观察到，下列因素常与快速循环模式相关：

相关因素	说明
抗抑郁药单药治疗	在双相障碍中，长期单用抗抑郁药（无心境稳定剂保护）可能诱发或加重转躁、快速循环——这是最需要警惕的一点
睡眠紊乱/作息不规律	熬夜、倒班、时差、作息颠倒，是转相的常见扳机
甲状腺功能异常	尤其是亚临床甲状腺功能减退，与快速循环相关；医生常会查甲功
物质使用	酒精、兴奋剂（如咖啡因过量、可卡因、冰毒等）可诱发转相
女性与产后	部分研究提示女性、产后阶段更易出现快速循环模式
未规范治疗/自行停药	不规律用药、频繁漏服，让情绪失去稳定锚

【临床共识】这正是为什么治疗双相时，医生会**坚持让你规律服心境稳定剂、规律作息、定期复查甲功**——这些都是在帮你"打破循环"。

5.4 快速循环自查/记录模板（可打印）

> 用法：建议用情绪日记，记录每次情绪发作的起止日期和类型。**一年下来数一数：≥ 4 次，就要在就诊时主动告诉医生。**

序号	起止日期	持续天数	发作类型（躁狂/轻躁狂/抑郁/混合）	当时可能的诱因（熬夜？压力？用药变动？）
1	__月__日 – __月__日	___天		
2	__月__日 – __月__日	___天		
3	__月__日 – __月__日			
4	__月__日 – __月__日			

【个人体验】把这些记录带复诊，比你口头描述"我一年到头都在反复"有用得多——医生一眼就能看出你的循环频率和规律。

5.5 关键认知：它是"标注"，不是"判决"

【临床共识】请记住这一点，非常重要：

> **快速循环是对"当前病程模式"的描述，不是一个固定不变的人格标签。**

- 它**可以随治疗改善**——规范使用心境稳定剂、规律作息、调整用药后，很多患者的循环频率会明显下降；

- 它**会波动**——这一年循环快，不代表下一年还会这样；
- 它**提示治疗需要调整**——而不是"这个病没救了"。

【个人体验】康复者常说："我曾经一年高低来回五六次，觉得自己这辈子就这样了。后来规律吃药、固定作息、复查甲功，慢慢一年只发作一两次。循环是可以被打破的。"

5.6 出现快速循环模式，该怎么办

【临床共识】

1. **记录情绪日记**：把每次转相的时间、类型、可能诱因记下来，复诊时给医生看。
2. **规律作息是第一抓手**：固定起床时间、避免熬夜、减少倒班/时差——睡眠节律稳不住，循环很难停。
3. **不要自行加药/停药**：快速循环的用药调整必须由医生判断；尤其不要因为"低落期"就自己加抗抑郁药，或因为"兴奋期"就自己停心境稳定剂。
4. **复查躯体指标**：按医嘱复查甲功、肝肾功能、血药浓度等。
5. **警惕物质**：减少酒精、咖啡因过量，避免兴奋剂。

> 安全提示：若在快速循环中出现任何自伤/自杀念头、冲动伤人、严重挥霍或彻夜不眠，请立即联系家属就医或拨打 12356 心理援助热线（24 小时免费；核实日期 2026-10-20，号码可能调整，以当地官方公布为准）；紧急情况拨 120 / 110。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 "With rapid-cycling specifier" 诊断说明
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（快速循环与抗抑郁药使用）
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》快速循环章节
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

6. 发作分期与病程模式

> 双相障碍不是"一直病着"，而是**发作性**的：有前驱期的早期信号，有急性期的典型症状，也有发作之间相对正常的缓解期。了解自己的病程规律——什么时候开始、持续多久、怎么转相、季节有没有规律——是自我管理最重要的功课。本页帮你看懂自己的"病程地图"。

6.1 一次典型发作的三个阶段

【临床共识】一次完整的情感发作，通常可以分成三段：

阶段	时间	表现	你能做什么
前驱期	发作前数天～数周	早期信号：睡眠开始变少/变多、情绪轻微波动、易激惹、精力变化	**及早识别，联系医生，往往能阻断或减轻发作**
急性期	躁狂 ≥ 1 周；抑郁 ≥ 2 周	典型症状充分表现，功能受损	规范治疗，遵医嘱用药，必要时住院
缓解期	发作后数周～数月	症状逐渐减轻，社会功能恢复，但仍残留轻微症状	巩固治疗，维持规律作息，防复发

【个人体验】很多康复者回忆："其实每次转相前，我都有信号——先是连续几天睡不着、脾气变大，然后就彻底'高'了。可惜以前我不懂，等彻底发作了才就医。"

6.2 前驱期：最值得重视的"早期信号"

【临床共识】前驱期是**自我管理黄金窗口**——这时候干预，往往能避免一次完整发作。双相常见的早期信号包括：

转躁/转轻躁狂的早期信号：

- [ ] 睡眠开始变少，但白天不困
- [ ] 比平时话多、比平时自信
- [ ] 开始同时制定很多新计划
- [ ] 花钱比平时大手大脚
- [ ] 比平时更容易烦躁、对家人没耐心
- [ ] 注意力开始容易被带跑

转抑郁的早期信号：

- [ ] 开始觉得累、不想动
- [ ] 对喜欢的事提不起劲
- [ ] 睡眠开始紊乱（失眠或嗜睡）
- [ ] 食欲改变
- [ ] 不想见人、想独处

【个人体验】建议你把自己**独有的**早期信号写下来——每个人的"前兆"不一样。有的人是"连续三天睡不到 5 小时"，有的人是"开始疯狂刷购物软件"。识别自己的前兆，是复发管理的核心。

6.3 病程模式：发作性，而非持续性

【临床共识】双相障碍的病程有几个重要特点：

特点	说明
发作性	高低交替出现，发作之间有缓解期，不是"一直都病着"
可自发缓解	即使不治疗，部分发作也会在数周到数月后自行回落——但**这不代表可以不治疗**，因为不治疗会反复发作、慢性化
发作间期功能可恢复	多数患者在发作间期社会功能可恢复到基本正常水平，能工作、能社交
易复发	双相是高复发性疾病——不规范治疗者，复发风险显著升高

【研究结论】临床上有一个被反复观察到的趋势：**未经规范治疗的双相障碍，发作频率可能随时间推移而增加**，发作间期可能越来越短。这也是为什么"预防复发"（维持治疗、规律作息、早期识别）和"治疗发作"同样重要。

【争议观点】这个"发作越来越频繁"的趋势并非人人都会发生，它更多见于未治疗、物质使用、频繁转相的患者群体；规范治疗可以显著改变这一趋势。不必因此恐慌，但要重视维持期治疗。

6.4 季节模式：很多患者有"季节钟"

【研究结论】相当一部分双相患者的发作呈现**季节规律**：

季节	常见倾向
春季（尤其早春）	躁狂/轻躁狂高发——光照变长、气温回升，与生物节律变化相关
夏季	仍可有躁狂倾向，部分患者混合状态增多
秋冬	抑郁相增多——光照减少，与季节性情绪变化相关
初冬/换季	转相高发期

【个人体验】"我发现自己每次春天就容易'飘'——睡得少、话多、想买东西；一到秋冬就往下沉。摸清这个规律后，我会在换季前特别注意睡眠和复诊。"

【临床共识】季节模式是因人而异的——有人春天抑郁、有人春天躁狂。**记录自己几年的发作日历，你就会找到属于自己的规律。**

6.5 病程模式记录模板（可打印）

> 用法：坚持记录 1～2 年，你就能看清自己的病程规律。

年月	情绪基线（高/正常/低）	睡眠情况	发作类型	持续时间	可能诱因	当时处理
__年__月						
__年__月						
__年__月						

6.6 给患者的三句话

1. **双相是发作性的，不是一辈子陷在里面**——发作之间，你可以基本正常地生活。
2. **前驱期是黄金窗口**——学会识别自己的早期信号，往往能把一次大发作掐在摇篮里。
3. **维持治疗不是"病好了还吃药"，而是"防止它再来"**——规律随访、规律作息，就是在保护你未来的稳定。

> 安全提示：首次出现剧烈胸痛、意识异常等躯体急症，请先拨打 120 排除躯体疾病。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders 病程标注
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（复发预防与病程）
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》病程与复发章节
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

7. I型II型与环性心境区分

> 双相不是一个病，而是一族：**I 型、II 型、环性心境障碍**，它们的核心区别在于"你经历过的最高那一段"有多重。本页用一张大表把三者分清，并列出医生需要做的**鉴别诊断**——和单相抑郁、精神分裂症、焦虑障碍、ADHD、边缘型人格障碍、物质/躯体疾病怎么区分。**鉴别由医生完成，本页只帮你理解、准备就诊信息。**

7.1 三型核心区别大对照表

维度	双相 I 型（6A60）	双相 II 型（6A61）	环性心境障碍（6A62）
核心定义	至少一次**躁狂发作**	至少一次**重性抑郁发作** + 至少一次**轻躁狂发作**，从无完整躁狂	长期、反复的**轻性**心境波动，从未达到躁狂或重性抑郁的完整标准
最高相	躁狂（≥1周，可伴精神病性症状、需住院）	轻躁狂（≥4天，功能基本正常、无精神病性症状）	只是"偏高"，从不达到轻躁狂完整标准
最低相	可有重性抑郁发作，也可没有	必有重性抑郁发作	只是"偏低"，从不达到重性抑郁完整标准
功能损害	躁狂相常明显损害社会功能、可能需住院	抑郁相造成主要痛苦；轻躁狂本人常不自知	长期波动但功能相对保留，像"情绪的背景杂音"
典型起病	成年早期，常以一次躁狂急性发作起病	多以抑郁发作起病，容易被误诊为单相抑郁	青春期或成年早期起病，慢性、长期波动
识别难度	躁狂发作明显，家属易察觉	**最易漏诊/误诊**——轻躁狂被当"状态好"忽略	最易被当成"性格问题""情绪化"
患者自述	"我曾经连续几天几夜不睡、觉得自己无所不能"	"我反复抑郁，但偶尔也有状态爆棚的几周"	"我这辈子情绪就没稳过，一直高低起伏"

【临床共识】一句话记忆：

- **I 型看"最高"**——你有没有过一次完整的躁狂发作？有，就是 I 型。
- **II 型看"高低组合"**——你有抑郁发作，也有过轻躁狂，但从没到过躁狂？那就是 II 型。
- **环性心境看"长期轻波动"**——你长期在轻度高涨和轻度低落之间来回晃，但都没达到"发作"标准？那就是环性心境。

7.2 为什么 II 型最容易被误诊

【临床共识】双相 II 型是临床上最容易被漏诊的：

- 患者因为**痛苦的抑郁相**去看病，从不主动提那段"很爽"的轻躁狂；
- 医生若不问"你有没有过特别兴奋、少睡、话多的阶段"，就容易诊断为**单相抑郁症**；
- 一旦按单相抑郁**单用抗抑郁药**，可能诱发转躁、轻躁狂或快速循环。

【个人体验】"我抑郁了五六年，一直吃抗抑郁药，效果时好时坏，偶尔还'转成特别兴奋'。后来换了个医生，问我'你有没有过连续几天只睡 4 小时还精力爆棚的时候'——我说有。他说，你不是单相抑郁，是双相 II 型。"

7.3 鉴别诊断：医生要排除哪些"长得像"的病

【临床共识】双相障碍的表现很像其他几种病，医生必须逐一鉴别。下面这张表帮你理解就诊时医生在"排雷"什么：

需要鉴别的疾病	为什么容易混	关键区分点
单相抑郁症	双相抑郁相与单相抑郁表现几乎一样	**既往有无躁狂/轻躁狂史**；家族史；症状特点（嗜睡、暴食、季节模式、突发突止提示双相）
精神分裂症	躁狂相可出现夸大妄想、幻觉，看似精神病性	双相的精神病性症状**与心境高涨/低落一致**（如"我是天选之人"），发作间期功能可恢复；精神分裂症有更持续的思维/感知/社交紊乱
焦虑障碍	易激惹、坐不住、失眠、担心，可与双相重叠	焦虑以"怕、紧张、指向未来"为主，无真正的心境高涨+睡眠需要减少+冲动行为
ADHD（注意缺陷多动障碍）	注意力分散、话多、坐不住、冲动，与轻躁狂相似	ADHD 是**长期、自幼、跨场景**的稳定特质；轻躁狂是**发作性、与平时 baseline 明显不同**、持续数天到数周
边缘型人格障碍	情绪剧烈波动、人际关系不稳、冲动、自伤	人格障碍是**持久的、弥漫性的人格模式**，起病早、长期存在；双相是**发作性**的，有相对正常的间歇期
物质相关障碍	酒精、兴奋剂、可卡因、冰毒等可直接诱发躁狂样/抑郁样症状	症状与物质使用**时间关系密切**；停用后逐渐缓解
躯体疾病（甲亢等）	甲状腺功能亢进可致兴奋、失眠、心慌、易激惹，像躁狂	**必须先查甲功**等躯体指标排除；甲亢有手抖、突眼、体重下降、心慌等躯体体征

【临床共识】这张表的意义在于：**第一次就诊时，医生常让你查甲功、血常规、肝肾功能、必要时心电图/脑电图——这不是过度检查，而是在排除躯体疾病和物质因素。** 把这些排查做扎实，诊断才可靠。

7.4 就诊时可以主动告诉医生的信息

【个人体验】为了帮医生准确分型和鉴别，就诊前你可以整理这些：

- [ ] 我这辈子有没有过"特别兴奋、少睡、话多、效率爆表"的阶段？持续几天？
- [ ] 有没有过"连续几天几夜不睡、觉得自己无所不能、做出冲动决定"的经历？
- [ ] 我的抑郁发作，是嗜睡还是失眠？暴食还是食欲下降？
- [ ] 我的情绪波动是长期以来的性格，还是某段时间突然发作的？
- [ ] 我小时候有没有注意力不集中、多动的问题？
- [ ] 我有没有使用酒精、咖啡因过量、或其他物质？
- [ ] 我的一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女）有没有情绪问题或精神科就诊史？
- [ ] 症状和季节、月经、产后、睡眠紊乱有没有关系？

7.5 给患者的三句话

1. **你是哪一型，交给医生判断**——你不必自己纠结"我到底是 I 型还是 II 型"，你要做的是把完整病史告诉医生。
2. **被诊断为"单相抑郁"但治疗效果反复、偶尔转兴奋，要主动追问**——"我有没有可能是双相 II 型？"
3. **鉴别诊断是好事，不是坏事**——医生排查得越细，用药方向越准，你越少走弯路。

> 安全提示：首次出现剧烈胸痛、意识异常等躯体急症，请先拨打 120 排除躯体疾病。

参考来源

- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders（I/II 型、环性心境）
- 世界卫生组织：ICD-11 · 6A60 / 6A61 / 6A62 双相与环性心境障碍
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（诊断与鉴别）
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》分型与鉴别诊断章节
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页

模块 4

诱因与高危因素

1. 生物学因素

> 双相障碍不是"性格不好""想不开"，它有明确的生物学基础——遗传、神经内分泌、生物节律、脑功能调节系统都参与其中。但请记住：**这些因素只是"易感性"，不是"宿命"**——有家族史不等于一定会得病，没有家族史也可能得。了解它们，是为了减少自责，而不是给自己判死刑。

1.1 为什么要谈生物学因素

【临床共识】很多患者第一次就诊时会问："我是不是太脆弱、太作了？"了解生物学因素，是为了让你知道——双相障碍像高血压、糖尿病一样，是身体调节系统出了偏差，而不是道德或性格的缺陷。

1.2 遗传与家族史：风险升高，不是"遗传病"

【研究结论】双相障碍是**遗传度较高**的精神障碍之一：

问题	通俗答案
家里有人双相，我会不会一定得？	不会。家族史只是让患病风险**比普通人高**——一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女）的患病风险约为普通人群的数倍到十余倍，不是必然
双生子研究怎么说？	同卵双生子的同病率显著高于异卵双生子，提示遗传贡献大，但**远未达到"单基因决定"**——是许多微小基因效应叠加的结果
父母都没有，我怎么会得？	遗传不是唯一因素，环境、应激、睡眠紊乱同样重要；很多患者家族里没有明确患者
我有了双相，孩子会不会一定有？	不会。孩子继承的是"情绪调节偏敏感的气质"，不是"双相病"；后天的稳定作息、温暖养育、早期识别可以大大缓冲

【个人体验】知道"这不是我作出来的"，很多人第一反应是松了一口气——原来我的情绪调节系统天生就灵敏一点、脆弱一点，不丢人。

1.3 神经递质：不能简单说"某种递质多了/少了"

【临床共识】要特别提醒：网上常看到"躁狂是多巴胺太多、抑郁是血清素太少"这类说法，**过于简单化、并不准确。**

- 双相障碍涉及**多个神经递质系统**（多巴胺、5-羟色胺、去甲肾上腺素、谷氨酸等）的**调节失衡**，不是单一递质的"多"或"少"；
- 它更像是这些系统之间的**动态平衡**被打乱，而不是某个阀门开太大或关太小；
- 这也是为什么治疗药物作用于多个系统，而不是简单"补一种递质"。

【争议观点】神经递质的具体机制仍是研究前沿，没有任何一种"递质理论"能完整解释双相障碍。不必把网上的"化学失衡"科普当成定论。

1.4 神经内分泌：HPA 轴与甲状腺

系统	与双相的关系
HPA 轴（应激下丘脑-垂体-肾上腺轴）	慢性应激时，皮质醇等应激激素长期偏高，与情绪调节紊乱、抑郁、转相相关
甲状腺功能	甲状腺功能异常（尤其亚临床甲减）与**快速循环**、抑郁相相关——这是医生常查甲功的原因

【临床共识】这正是为什么双相患者复诊时常要抽血查甲功、肝肾功能——既监测药物安全性，也排查影响病程的躯体因素。

1.5 生物节律与睡眠中枢：双相的"生物钟"特别脆弱

【研究结论】这是双相障碍生物学里**最有临床意义**的一点：

> 双相患者的**昼夜节律系统**（掌管睡眠-觉醒、体温、激素分泌节律的生物钟）天生更脆弱、更容易被打乱。

- **睡眠剥夺、倒班、时差、熬夜**，是诱发转躁/轻躁狂最常见的生物学扳机；
- 反过来，**规律作息、稳定社会节律**，是最有效的非药物保护因素之一；
- 这也是为什么双相的心理治疗里有专门一种叫"人际与社会节律治疗（IPSRT）"——专门帮你把生物钟重新锚定。

【个人体验】很多康复者发现："我只要连续熬夜几天，就开始兴奋少睡、话多；只要固定作息一段时间，情绪就稳下来。"——这不是巧合，是生物钟在起作用。

1.6 脑结构与功能：谨慎表述

【研究结论】影像学研究提示，双相障碍患者在某些脑区（如杏仁核、前额叶皮质、纹状体等）的结构和功能活动上，与健康人存在**统计学差异**——例如杏仁核对情绪刺激的反应模式、前额叶的调控功能等。

【争议观点】但必须强调：

- 这些差异是**群体水平的统计趋势**，**不能用来给某个人做诊断**；
- 它们是**疾病的相关表现**，不是"病因本身"，也不是永久性的脑损伤；
- 不要把网上的"双相大脑不一样"渲染成"脑子坏了"——它是可调节、可治疗的。

1.7 一句话总结

生物学因素决定的是**你的"情绪调节体质"**——生物钟偏脆弱、应激反应偏敏感、家族易感性偏高。它解释了你为什么比别人更容易被点着，但点不点得着、着多大，很大程度上取决于后面要讲的心理习惯、环境压力，以及你能不能主动建立保护因素（规律作息、规范治疗、社会支持）。**风险不是判决书，是提示牌。**

参考来源

- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》病因学章节
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders

2. 心理因素

> 如果说生物学决定了"情绪调节系统有多敏感"，心理因素就决定了"这套系统在压力下怎么运转"——你的气质、认知模式、情绪调节能力、应对方式，都在影响你会不会转相、转多快。好消息是：**心理因素恰恰是心理治疗最能改变的部分。**

2.1 气质与性格：那些从小就有的"底色"

【研究结论】临床上发现，双相障碍患者在发病前，常带有某些**气质特征**，它们不是病，而是"易感底色"：

气质类型	通俗描述
情感旺盛型气质	天生精力充沛、热情、外向、情绪反应强、闲不住、爱社交
环性气质	从小情绪就容易在"偏高"和"偏低"之间来回晃，像情绪的背景杂音
抑郁气质	偏敏感、多虑、容易自责、追求完美

【个人体验】"我从小就是那个特别热情、特别精力旺盛、闲不住的孩子——大人都夸我活泼。直到后来我才明白，那份'活泼'的底色里，藏着日后双相的易感体质。"

【争议观点】谈气质不是给人贴标签——这些是**连续谱上的倾向**，多数有这些气质的人并不会发展成双相障碍。它们只是"易感性"，不是命运。

2.2 认知模式：看待世界的习惯

【研究结论】双相患者在认知模式上，常带有一些相似倾向：

认知倾向	内心独白举例
高目标、高抱负	"我要同时做好几件大事"
过度乐观/高估自己	"这次一定成，没问题"（轻躁狂期更明显）
完美主义	"做不到最好就等于失败"
反刍思维	低落时反复回想自己的过错、失败
情绪化决策	跟着当下的情绪走，而不是理性评估

【临床共识】认知行为治疗（CBT）用于双相，就是帮你**识别这些自动冒出来的念头，学会在情绪高涨时踩刹车、在低落时跳出反刍**——这是被研究证实有效的辅助手段。

2.3 情绪调节与应对方式

【临床共识】双相患者的情绪调节往往有这些特点：

- **情绪反应强、恢复慢**：一件小事就能引发强烈情绪，且平复需要更长时间；

- **冲动应对**：情绪上来时，倾向于立刻行动（挥霍、吵架、刷爆购物车），而不是先停一下；
- **压抑 vs 爆发**：有人习惯压抑，压到极限后突然崩溃；有人一点就着。

【个人体验】"我以前情绪一上来就跟着走——高兴就疯狂消费，生气就立刻回怼。后来学着'停 10 分钟再反应'，很多冲动就过去了。"

2.4 自尊与自我评价的波动

【个人体验】双相患者的自尊常随相别摆动：

- **躁狂/轻躁狂期**：自我评价异常膨胀，"我无所不能"；
- **抑郁期**：自我评价跌到谷底，"我一无是处"。

【临床共识】这种自尊的大幅摆动，让患者很难对自己形成一个稳定、现实的评价。心理治疗的一部分，就是帮你建立**不随相别剧烈波动的自我评价**——既不飘上天，也不踩到地。

2.5 早年创伤：过去的事，不会真的过去

创伤类型	与双相的关系
童年情感忽视/虐待	升高日后情绪障碍风险，影响情绪调节能力发展
童年被欺凌、长期被否定	容易形成"我不够好"的底色
重大创伤（丧失、暴力、事故）	可作为发病的应激扳机

【临床共识】如果你的病程里伴随着反复闪回、噩梦、过度警觉，要主动告诉医生——这会影响治疗方向（可能需要创伤聚焦的心理治疗）。**创伤不是"想开点"就能翻篇的。**

2.6 心理因素是"易感性/调节因素"，不是病因全部

【争议观点】必须强调：

- 这些心理因素**单独不导致**双相障碍——它是生物-心理-环境多因素叠加的结果；
- 谈它们不是为了"追责"你的性格或童年，而是为了**找到可以干预的着力点**；
- 气质和早年经历很难改变，但**认知模式、情绪调节、应对方式，是可以通过训练重新塑造的。**

2.7 这些心理因素能改变吗？——能

因素	能否被改变	通过什么
高目标/过度乐观	中等	CBT、决策前"冷静期"练习
完美主义/反刍	较易	CBT 思维记录、认知重构
冲动应对	较易	"停 10 分钟再反应"、延迟决策
情绪恢复慢	中等	情绪调节训练、正念/放松
早年创伤	可修复	创伤聚焦治疗（如 EMDR），需专业指导

【个人体验】康复者常说："念头还是会冒出来——'我要干一票大的'或者'我真没用'。但我现在认得它了：'哦，这是我那个老模式又来了。'认得它，它就没那么容易牵着我走。"

参考来源

- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》心理治疗与社会心理因素章节
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（心理治疗推荐）
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders

3. 环境因素

> 同样的"敏感体质"，放在安稳规律的环境里可能一辈子只是个"精力充沛、情绪化的人"；放在熬夜、变故、高压的环境里，就容易被点燃。环境因素往往是**压垮骆驼的最后那根稻草**——也是我们最能动一动的部分。**尤其要记住：睡眠剥夺和作息紊乱，是诱发转躁最常见的环境扳机。**

3.1 头号扳机：睡眠剥夺与作息紊乱

【临床共识】这是双相障碍环境因素里**最重要、最需要记住的一条**：

> **熬夜、倒班、时差、作息颠倒，是诱发躁狂/轻躁狂最常见的环境原因。**

情况	为什么危险
连续熬夜赶项目/打游戏/刷手机	睡眠需要被压缩，生物钟被打乱，容易"转上去"
倒班工作、跨时区出差	昼夜节律频繁重设，情绪调节系统承受压力
通宵聚会、通宵狂欢	短期兴奋后，常紧跟着一次躁狂发作或崩溃
周末赖床补觉、工作日早起	作息摇摆，像"时差"一样扰乱生物钟

【个人体验】"我发现自己只要连续几天只睡四五个小时，就开始兴奋少睡、话多、想买东西——那不是我'状态好'，是我的生物钟被打乱了。"

【临床共识】反过来，**固定起床时间、规律作息**，是最便宜也最有效的"防转相"手段。这也是为什么后面"保护因素"会把规律作息放在第一位。

3.2 重大生活事件：正负向都可能是扳机

【研究结论】和抑郁常由"负面事件"触发不同，**双相的转相扳机可以是好事，也可以是坏事**——因为关键不在事件好坏，而在它**打乱了你的生活节律和情绪平衡**：

类型	事件举例
正向事件	升职、结婚、恋爱、搬新家、考上学校、旅行、中了小奖
负向事件	失业、离婚、失恋、亲人离世、家人生病、财务损失、吵架
结构变化	换工作、搬家、开学、毕业、退休、当父母

【个人体验】"我那次躁狂发作，是在我刚升职、特别开心的时候开始的——不是坏事，反而是'好事'让我太兴奋、太熬夜庆祝，然后就收不住了。"

【临床共识】**重要的不是事件本身，而是它带来的作息紊乱和情绪激荡。** 所以遇到大喜大悲的事，更要刻意守住睡眠和日常节律。

3.3 慢性压力

场景	典型压力
工作	长期高压、996、人际关系紧张、怕失业
经济	负债、收入不稳、房贷/养家压力
照护	长期照顾老人、重病家人、年幼多孩
关系	长期冲突、冷战、压抑的亲密关系

【临床共识】这类压力没有明确的"结束点"，让神经系统长期泡在应激激素里，是情绪波动和转相的温床。

3.4 季节因素：你的"情绪钟"跟着光照走

【研究结论】相当一部分患者的发作有季节规律：

季节	常见倾向
春季（早春）	光照变长、气温回升，**躁狂/轻躁狂高发**
秋冬	光照减少，**抑郁相增多**
换季期	转相高发期

【个人体验】"我一到春天就容易'飘'，一到秋冬就往下沉。摸清这个规律后，我会在换季前特别注意睡眠和复诊。"

3.5 物质因素：容易被忽略的扳机

物质/行为	与双相的关系
酒精	短期放松，长期扰乱睡眠和情绪稳定，戒断时情绪波动
咖啡因过量（浓咖啡、能量饮料）	加重兴奋、焦虑、失眠，可能推高转躁
兴奋剂（可卡因、冰毒等）	可直接诱发躁狂样发作、偏执、冲动
突然停掉镇静/安眠类药物	失眠、焦虑反跳，情绪波动——必须在医生指导下调整

【临床共识】减少酒精和咖啡因、远离兴奋剂，是环境层面最实在的自我保护。

3.6 躯体因素：产后、甲亢等

情况	与双相的关系
产后	激素剧烈变化 + 睡眠剥夺，是双相发作（尤其混合/躁狂）的高发窗口；产后情绪问题必须尽快就医排查
甲状腺功能异常	甲亢可致兴奋、失眠、易激惹，像躁狂；甲减与抑郁、快速循环相关

情况	与双相的关系
其他躯体疾病/感染/手术	身体应激可诱发情绪波动

3.7 特别提示：抗抑郁药单药相关的转躁

【临床共识】这一点必须在环境/诱因里单独提醒：

> 在**双相障碍**中，**单用抗抑郁药（没有心境稳定剂保护）**可能诱发转躁、轻躁狂或快速循环。

- 如果你是双相 II 型、却一直被当单相抑郁**单用抗抑郁药**治疗，就要警惕"为什么我吃着抗抑郁药，反而越来越兴奋、转相越来越频繁"；
- **是否调整用药、是否加用心境稳定剂，必须由你的精神科医生判断**——不要因为怀疑转躁就自己停药或加药；
- 主动告诉医生："我吃这个药之后，有没有出现少睡、话多、兴奋、冲动的情况？"

3.8 环境诱因自查表（过去半年，符合打勾）

- [ ] 长期睡眠不足、作息不规律（熬夜/倒班/周末补觉）
- [ ] 最近经历重大生活事件（无论正负）
- [ ] 处于长期高压、慢性应激状态
- [ ] 处于季节转换期，感觉情绪跟着季节走
- [ ] 每天大量咖啡/浓茶/能量饮料，或靠酒助眠
- [ ] 使用过兴奋剂或有物质滥用问题
- [ ] 近期产后、或查出甲状腺等躯体问题
- [ ] 正在服用抗抑郁药，且出现少睡/话多/兴奋/冲动

【使用提示】勾中越多，说明你的"环境负荷"越重——这不是矫情，是身体在提醒你：该减负、该守住睡眠、该求助了。就诊时把这张表给医生看，很有帮助。

3.9 一句话总结

生物学是"柴火"，心理习惯是"引线"，**环境常常就是那把火。**我们未必能立刻换掉环境，但可以先做三件事：**守住睡眠和作息、减少酒精咖啡因、把这段时间的压力和变化理清楚告诉医生。**

参考来源

- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》诱发因素与复发预防章节
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（生活方式、睡眠规律、物质与抗抑郁药使用）
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders

4. 保护因素

> 高危因素解释"为什么会转相"，保护因素解释"为什么有的人同样敏感却稳住了"。**好消息是：双相的保护因素大多可以主动建设**——尤其"规律作息与社会节律"，几乎是为这个病量身定做的缓冲垫。你不需要天生拥有，从今天的小动作就能开始。

4.1 什么是保护因素

【临床共识】保护因素是一组能缓冲压力、**降低转相和复发风险、加快恢复**的条件与习惯。它们不能"治愈"已经发作的双相，但能显著减少发作次数、减轻严重程度、拉长缓解期。

4.2 双相核心保护因素清单（可对照自查）

保护因素	为什么对双相特别有用	现在可以做什么
规律作息与社会节律	双相生物钟天生脆弱，固定作息就是在给它"上锚"，是防转相第一抓手	**固定起床时间**，比"几点睡"更重要；三餐、活动时间尽量稳定
充足、稳定的睡眠	睡眠剥夺是转躁最常见扳机	避免熬夜、通宵、周末补觉；睡前 1 小时放下手机
规范治疗与随访	心境稳定剂是预防复发的核心药物，规律服药+定期复查是地基	遵医嘱服药、定期复诊、按要求抽血监测
早期识别前驱信号	在前驱期干预，常能把一次大发作掐在摇篮里	写情绪日记，识别自己的"早期信号"
社会支持	有人可说话、不孤独，是最强缓冲之一	让家人了解这个病，知道你的早期信号
稳定的关系与工作	生活结构稳定，减少节律被打乱	给自己设现实的目标，避免同时开太多战线
健康生活方式	减少身体层面的紊乱	适度运动；少咖啡因、不喝酒、远离兴奋剂
情绪与睡眠自我监测	让你和医生都看得见趋势	每天记一行情绪/睡眠，复诊时带过去

4.3 双相特有的"保护组合拳"

【临床共识】对双相来说，下面这套组合尤其有效：

```
固定作息（生物钟上锚）
    ＋
规范服药（心境稳定剂打底）
    ＋
情绪/睡眠日记（早期识别）
```

＋

家人支持（有人帮你看着信号）

↓

降低转相频率、拉长缓解期

4.4 从今天开始的小动作（不必全做，挑 1～2 个）

1. **固定起床时间**：哪怕前一晚没睡好、哪怕周末，也尽量同一时间起床——这是生物钟最重要的锚。
2. **守住睡眠底线**：不连续熬夜、不通宵狂欢；遇到大喜大悲的事，更要刻意守住睡觉时间。
3. **每天记一行情绪日记**：今天情绪（高/正常/低）、睡了几小时、有没有早期信号——复诊时这是金子般的数据。
4. **下午后不碰咖啡因**：咖啡、浓茶、可乐、能量饮料都算；不靠酒助眠。
5. **适度运动**：每天快走 20～30 分钟，微微出汗即可，帮助消耗精力、稳定情绪。
6. **告诉一个你信任的人**：把"我最近睡眠变少、有点兴奋"说出口——别等彻底发作才让人知道。
7. **按医嘱规律服药、定期复查**：不因为"现在状态好"就自行停药，不因为"低落"就自己加药。

【个人体验】康复者常说："真正帮我稳住的不是某一个大决定，而是几个小习惯——固定时间起床、每天记一行情绪日记、难受时给家人发条消息、按时复诊抽血。"

4.5 保护因素不是"自律考核"

【争议观点】特别提醒：不要把这张清单变成新的压力来源——"我怎么又没早睡、又没运动，我真失败"。

- **做到多少算多少，目标是缓冲，不是完美。**
- 如果你正处在抑郁发作、连起床都困难，那"按时吃饭、按时吃药"本身就是了不起的保护行动。
- 保护因素是给治疗**打底**的，不能替代药物和心理治疗。

4.6 保护因素与治疗的关系

【临床共识】保护因素和规范治疗是**配合关系**，不是二选一：

- 只靠治疗、不重建生活节律 → 复发风险高；
- 只靠"自律生活"、不规范服药 → 同样容易复发；
- **两者一起做，效果最好。**

4.7 给患者的三句话

1. **规律作息，是这个病最"对症"的自我照顾**——你不需要多么励志，只需要把生物钟稳稳锚住。
2. **写情绪日记、让家人懂你的信号，是最便宜的"复发预警系统"。**
3. **状态好的时候，恰恰是最该守住保护因素的时候**——别在"觉得自己没事"的时候熬夜、停药、放纵，那往往就是转相的起点。

> 安全提示：首次出现剧烈胸痛、意识异常等躯体急症，请先拨打 120 排除躯体疾病。

参考来源

- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》复发预防与康复章节
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management, CG185（复发预防、生活方式、IPSRT）
- 国家精神卫生研究院（NIMH）：Bipolar Disorder 科普页
- American Psychiatric Association：DSM-5 Bipolar and Related Disorders
- 世界卫生组织：ICD-11 · Bipolar disorders

模块 5

就医与诊断指南

1. 就诊触发信号

> 双相最耽误事的两种情况：一是躁狂期觉得"我好极了，根本没病"，拒绝就医；二是抑郁期觉得"我就这样了，看也没用"，硬扛。这一篇帮你和家人判断：**哪些变化说明该尽快约门诊，哪些情况必须立刻去急诊。**
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、双相最容易被忽略的一点：那不是"状态好"

【临床共识】双相情感障碍和单纯抑郁最大的区别，就是它有"上去"的那一段——躁狂或轻躁狂。而这一段**往往被本人当成好事**：精力旺盛、灵感爆棚、效率奇高、熬夜都不困。很多人拖了好几年才就医，不是因为没有症状，而是因为"那段时间我状态特别好"。

【个人体验】一位康复者回忆："我那段时间三天只睡几个小时，觉得自己思路特别快、要干一番大事，刷爆了三张卡。我妈说我不对劲，我骂她不懂。直到我在低谷躺了一个月，医生问我：'你以前有没有过一段，好得不正常？'我才反应过来——那不是好状态，是病的一半。"

所以本篇最重要的一句话：如果你（或家人）有过一段"异常地好、异常地能熬、异常地敢花钱"的时期，它和持续的低落一样，都是要看医生的信号。

二、该尽快预约精神科门诊的信号（不必急诊）

出现以下情况，建议尽快挂精神科/心境障碍门诊，不必等到"完全垮掉"：

信号	具体表现
睡得少却不困	连续几天只睡很少时间，白天却精力旺盛、不觉得缺觉（注意：这是"睡眠需要减少"，不是失眠痛苦）
话多、脑子转得快	话停不下来，别人插不上嘴；脑子里念头一个接一个、像在放快进
异常自信或夸大	觉得自己有超常能力、特殊使命；判断明显脱离现实
冲动行为明显增多	突然大额消费、盲目投资、鲁莽开车、高危性行为、停掉工作去"创业"
注意力随境转移	一点小事就被带跑，一件事没做完又扑向下一件
持续的情绪低落	心情低、兴趣减、疲乏、早醒、自我评价低，持续数周以上
情绪明显"两极摆"	一段时间亢奋、一段时间低落，交替出现或一起出现
家人朋友反复说"你不对劲"	旁观者清，尤其在躁狂期，本人往往丧失自知力
已经反复发作过	无论上次是轻是重，再次出现类似苗头
靠喝酒/熬夜/某些药才能"稳住"	开始用物质或极端作息自我调节

【临床共识】【研究结论】双相是一种发作性疾病，**早期识别、早期治疗能显著缩短发作时间、减少冲动造成的损失（金钱、关系、工作）**。躁狂期一次发作造成的财务和社交破坏，可能需要很多年才修复。

三、【最高优先级】出现这些情况，立即急诊/拨打急救

这是本篇最关键的分流，请和家人一起记住：

危险信号	为什么危险	行动
出现自伤、自杀念头或具体计划	抑郁相、尤其**混合相**（既躁又郁）时自杀风险最高	**立即急诊或拨打12356/120**，身边留人
激越、冲动、有伤人或毁物倾向	严重躁狂期可能出现攻击行为	**立即急诊或拨打110/120**，保证周围人安全
完全不吃不喝、彻夜不眠多日、话乱、幻觉妄想	重性躁狂/精神病性发作，身体可能快速衰竭	**立即急诊住院评估**
服药后高热、意识混乱、肌肉僵硬大汗	可能是5-羟色胺综合征等药物急症	**立即急诊**
首次剧烈胸痛、晕厥、意识异常	不是"情绪问题"，先排除躯体急症	**先打120、先救命**，不要当成躁狂或抑郁硬扛

【临床共识】**"首次剧烈胸痛/意识异常等，先排除躯体急症"**——双相患者也会得心脏病、甲亢急症、药物不良反应。不要因为"我有双相"就把所有身体不舒服都归因于情绪。

四、分流表：急诊 / 尽快门诊 / 先自我观察并记录

你的情况	建议行动
有自伤/自杀念头或计划、有伤人冲动、彻夜不眠多日伴幻觉	**立即急诊 / 拨打120或110**
首次剧烈胸痛、晕厥、意识异常	**立即打120，先排除躯体急症**
又出现以前发作过的苗头（异常亢奋或持续低落）	尽快预约门诊，不必等下次发作
睡眠/精力/情绪明显偏离常态，持续数日到数周	尽快门诊评估
家人反复说"你这段时间不太对"	认真对待，安排就诊
偶尔情绪波动、压力期明显，但休假后能恢复	先记录、自我观察，持续不缓解再就诊

五、为什么"家人觉得不对"很重要

【临床共识】躁狂/轻躁狂期，**本人的自知力（即"知道自己病了"的能力）常常受损。**你可能真心觉得自己状态绝佳，而身边人的观察往往更早、更准。

- 躁狂期最典型的家庭冲突：本人认为"我好得很"，家人觉得"你太夸张了"。
- 抑郁期则相反：本人自责"我就是懒"，家人看到的是"他快撑不住了"。

【个人体验】所以如果你读到这篇，而你其实是家属——请不要只听当事人一句"我没事"。可以用《模块9》里的沟通话术，温和而坚定地陪他去医院。很多双相患者第一次被确诊，都是被家人"押"去的。

六、自我调节多久没效，就该看医生

情况	建议观察期
情绪低落、睡眠变化，自己调整作息、运动、倾诉	1～2 周不缓解，或越来越重
已经出现"睡少却不困、话多、敢花钱"等轻躁狂苗头	**不必等时间，尽快就诊**——这类信号不是"自我调节"能压回去的
既往确诊过、又出现熟悉的发作感觉	直接联系主治医生，按既定方案复诊

【临床共识】**睡眠是双相最敏感的前哨**：一旦连续熬夜、作息紊乱，常常是转躁的前奏。发现自己"最近睡得特别少还特别精神"，不要当成好事，这是最该就诊的信号之一。

七、一句话记住

"好得不正常"和"糟得提不起劲"，是同一枚硬币的两面——都要看医生。有自伤/伤人念头、彻夜不眠伴胡言乱语、首次剧烈胸痛晕厥，先打120；其余的，尽快挂精神科或心境障碍门诊，别硬扛。

参考来源

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- APA（美国精神医学学会）：*DSM-5 双相及相关障碍诊断标准*. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 世界卫生组织（WHO）：*ICD-11 双相及相关障碍（6A60–6A62）*. https://icd.who.int/en
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 国家卫生健康委员会心理援助热线 **12356**（24小时免费；核实日期 2026-10-20，号码可能调整，以当地官方公布为准）。

2. 就诊科室与专业人员

> 双相是一种**需要长期用药管理**的疾病，所以第一次就诊最关键的一件事，是找到一位能给你做诊断、开精神科药物的医生——而不是只找一个能陪你聊天的咨询师。这一篇把医院的门牌号和各类人员的分工讲清楚，免得你排错队、走弯路。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、双相该挂哪个科

科室名称	适合情况	能不能开药
精神科/心境障碍专科门诊	**首选。**专门看双相、抑郁、焦虑等心境问题，经验丰富	能
精神专科医院/精神卫生中心	科室最全、可住院、可做MECT等物理治疗，适合症状较重、需要系统治疗者	能
综合医院精神科/心理科	同时有躯体不适、想在普通医院看、减少病耻感者	出诊医生能
心身医学科	以躯体不适为主（心慌、肠胃不适）、查不出器质性问题者	能
临床心理科/心理咨询机构	已确诊后配合谈话治疗	**不能诊断、不能开药**

【临床共识】第一次看双相，**优先挂"精神科"或"心境障碍/情感障碍专科门诊"。**如果当地有精神卫生中心的心境障碍专科，是最好的选择。**不建议把心理咨询机构作为第一站**——因为双相的诊断和用药必须由精神科执业医师完成。

二、几类专业人员，别搞混

角色	能做什么	不能做什么
精神科医生（执业医师）	面诊、下诊断（如双相I型/II型）、开心境稳定剂等药物处方、安排化验监测、决定是否住院/物理治疗	——（医学决策的核心）
心理治疗师/心理咨询师	心理教育、CBT、IPSRT、FFT 等谈话治疗、情绪支持	**不能做医学诊断、不能开精神科药物、不能决定住院**
精神专科护士	用药指导、血药浓度随访、复发监测、健康教育	不开药、不诊断
社工/个案管理员	资源链接、家属支持、社区康复、医保/就业相关协助	不开药、不诊断

【临床共识】双相是一个"团队病"：精神科医生管诊断和药，心理治疗师管作息节律、认知和家庭关系，护士管随访监测，社工管资源。**但诊断和用药的方向盘，始终在精神科医生手里。**

【个人体验】很多人一开始不好意思去"精神病院"，先去了心理咨询。咨询师聊了几次，觉得"你这个可能不只是情绪问题，得去精神科看看"——这不是咨询师不专业，而是他守好了边界。双相患者最好的路径，

往往是先在精神科把诊断和药立住，再在这个基础上配合心理治疗。

三、国内就诊路径怎么走

1. **综合医院精神科/心理科**：适合第一次看、想减少病耻感、同时有身体不适者。首次就诊做初步评估，必要时转诊到精神专科医院。
2. **精神专科医院/精神卫生中心**：科室全、心境障碍专病经验多，能住院、能做MECT、能规律监测血药浓度。**反复发作、需要系统治疗者优先。**
3. **心境障碍/双相专病门诊**：很多省级精神卫生中心设有专门门诊，医生对双相分型、药物、监测更熟，值得优先选择。
4. **社区卫生服务中心**：老患者随访、开药续方、初步识别转诊。
5. **互联网医院**：**只建议老患者复诊续方、查报告。**首诊、症状波动大、有冲动或自伤风险时，必须线下面诊。

四、医院精神科 vs 私立心理咨询，怎么选

维度	医院精神科	私立心理咨询机构
强项	诊断、开药、血药监测、住院、物理治疗	谈话时间充裕、CBT/IPSRT/FFT 更深入
局限	门诊时间短，心理治疗资源有限	鱼龙混杂，不能诊断、不能开药
适合	**第一次看、不确定分型、可能需要药**	已确诊、想在药物基础上配合心理治疗

鉴别正规与否的要点：
- 医生/治疗师是否有可查的执业资质（精神科医师执业证书、中国心理学会注册系统等）；
- 机构是否尊重边界——**好的咨询师发现你可能是双相时，会建议你先去精神科**，而不是自己硬留着你"聊好"；
- **警惕"包好""几次根治""中药无副作用永不复发"这类话术**——双相是可治疗、可管理的，但正规治疗不会承诺"断根"，更不会让你随便停掉心境稳定剂。

五、急诊和住院路径

【临床共识】双相需要急诊/住院的情况主要有：严重躁狂彻夜不眠、冲动伤人、重度抑郁伴自伤自杀、混合状态、拒食木僵、药物不良反应（如高热、意识混乱）。

- **急诊**：直接去有精神科急诊的医院（精神卫生中心通常24小时有）；情况紧急先拨120或110。
- **住院**：医生评估后决定。急性期住院是为了快速控制发作、保障安全，**这不是"被关起来"，而是帮你和家人度过最危险的一段。**
- **家属送医**：如果本人躁狂期坚决认为"我没病"、拒诊且有风险，家属可联系医院和精神科急诊，了解当地非自愿住院/送医的法定流程（具体以当地规定为准）。

【个人体验】很多康复者第一次住院是被家属送来的，当时觉得"丢人"，出院后却承认："那段时间如果不住院，我可能已经把房子卖了、把家作没了。"

六、就诊当天的几个小提示

- 带身份证、医保卡、既往病历和**正在吃的所有药盒**（尤其如果以前吃过抗抑郁药、安眠药）；
- 一个人紧张可以请家属陪同——**躁狂/抑郁的发作史、起止时间，家属的补充往往非常关键**；
- 涉及内心感受、自伤念头，建议自己对医生说；不方便当着家属说的，可以请医生安排单独谈话；
- **录音前先征得医生同意**："我怕记不住，可以录下来吗？"多数医生会同意；
- 没听懂就追问："您刚才说的，我理解是双相……对吗？""这个药需要监测什么？"——这是你的权利。

七、一句话记住

双相先找精神科医生把诊断和药立住，心理治疗在药物基础上配合；急诊住院找精神卫生中心，互联网医院只用于老患者复诊。第一次不要只靠心理咨询——它不能诊断双相，也不能开药。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（就诊路径与多学科团队）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 世界卫生组织（WHO）：*mhGAP Intervention Guide*（精神、神经和物质使用障碍的精神卫生决策）. https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 美国精神医学学会（APA）：*Practice Guideline for the Treatment of Patients with Bipolar Disorder*.
- 中国心理学会临床心理学注册工作委员会（注册心理师体系参考）。

3. 就诊前准备清单

> 双相的诊断非常依赖"病史"——而病史最关键的部分，恰恰是你和家人**回忆起以前那些"好得不正常"或"糟得不正常"的阶段**。门诊时间短，靠临场回忆最容易漏掉躁狂期。这一篇是**可以直接打印、照抄填写的模板**，带它去诊室，医生几分钟就能抓住重点。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、为什么双相就诊尤其要提前写下来

【临床共识】医生诊断双相，最需要的信息是：**有没有过躁狂/轻躁狂发作、抑郁发作多久、发作怎么交替、对生活影响多大、有没有躯体疾病和用药史**。而躁狂期的本人常常不觉得那是病——这正是很多双相被误诊为"单相抑郁"的原因。你提前把"以前那段时间"写下来，直接决定了医生能不能一次看对。

你不需要写得像病历，大白话、举例子、写日期就够。

二、本次最想解决的问题

- 这次最想解决的 1～3 个困扰：
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 大概从什么时候开始明显（日期/几周前）：_ _ _ _ _ _
- 是慢慢出现的，还是某一段时间突然"变了个人"：_ _ _ _ _ _

三、【核心】情绪波动时间线：把"上去"和"下去"都记下来

这是双相就诊最关键的一张表。请尽量回忆**过去一两年（甚至更久）**的情绪起伏，哪怕只是模糊印象。

大致时间段	状态是"上去"还是"下去"	具体表现（写例子）	持续了多久
例：2025年3–5月	上去（亢奋）	每天只睡3–4小时还精神，辞职创业，花掉几万块	约2个月
例：2025年6–9月	下去（低落）	躺床上起不来，不想见人，觉得没希望	约3个月
_ _ _ _	|	|	|
_ _ _ _	|	|	|
_ _ _ _	|	|	|
_ _ _ _	|	|	|

> 【个人体验】很多人写这张表时自己先愣住了："原来我不是一直脾气差、也不是一直懒，而是一段一段的。"把它递给医生，比你说"我就是情绪不好"有用一百倍。

四、"上去"那段的自查（躁狂/轻躁狂信号，勾选）

请回忆自己**状态异常好/异常亢奋**的那段时间，有没有出现：

- [ ] 明显觉得睡得少却不困（比如连续几天只睡很少，白天照样精神）
- [ ] 话变多、说话快、别人插不上嘴
- [ ] 脑子里念头特别多、转得特别快
- [ ] 注意力很容易被无关的东西带走
- [ ] 异常自信、觉得自己特别厉害、有特别计划
- [ ] 花钱大手大脚、盲目投资、买一堆没用的东西
- [ ] 鲁莽开车、高危性行为、停学/辞职去"干大事"
- [ ] 脾气变得特别容易被激惹、和人吵架打架
- [ ] 活动量明显变大（同时开很多件事、忙个不停）

> 这些只是给你回忆用的提示，**不是诊断标准**。有没有、严重到什么程度，由医生判断。

五、"下去"那段的自查（抑郁信号，勾选）

- [ ] 情绪低落、开心不起来　[ ] 对以前喜欢的事没兴趣
- [ ] 疲乏、没力气　[ ] 自我评价低、自责
- [ ] 入睡困难/早醒/睡不解乏　[ ] 食欲和体重明显变化
- [ ] 注意力、做事效率下降　[ ] 反复想到死、或有自伤念头

六、症状频率与强度（最近两周）

症状	有/无	一周大约几天	最严重时打分(0–10)
情绪低落			
异常兴奋/话多/精力过盛			
睡眠不好（入睡/早醒/睡得少却不困）			
容易发脾气			
冲动消费/冒险行为			
焦虑、紧张			
疲乏、没力气			
自伤/自杀念头			

> 0 = 完全没有困扰，10 = 最严重、几乎无法忍受。**自伤念头这一栏，无论打几分，都要当面告诉医生。**

七、已经做过的身体检查（带报告或拍照）

检查项目	时间	结果（正常/异常，异常写什么）
甲状腺功能（甲功）		
血常规		
肝肾功能		
血糖		
心电图		
其他		

【临床共识】双相初诊常查甲功等——因为**甲亢**可以表现出心慌、兴奋、消瘦，酷似躁狂；某些躯体疾病也会伪装成情绪波动。把已有报告带上，能避免重复抽血。

八、既往史、用药史与家族史

- 以前看过精神/心理科吗？**诊断过什么？**（尤其：是否被诊断过"抑郁症"？）
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 以前吃过什么精神类药物？（抗抑郁药？安眠药？）**效果和副作用如何？**
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- 有没有住过院、做过手术：_ _ _ _ _ _
- 有没有甲状腺、心脏、肝脏、肾脏、高血压、糖尿病等慢性病：_ _ _ _ _ _
- **父母、亲兄弟姐妹、子女有没有双相、抑郁、长期失眠、酗酒、自杀**（家族史对双相非常重要）：_ _ _ _ _ _

九、用药与物质使用清单（带药盒或手机拍照）

名称	每天大致怎么吃	吃了多久	谁开的

- 包括：处方药、中药、中成药、保健品、避孕药、激素。
- 酒精：每周喝几次、每次多少？_ _ _ _ _ _
- **咖啡因**：每天几杯咖啡/浓茶？（对睡眠和情绪有影响）_ _ _ _ _ _
- 吸烟、大麻、兴奋剂、其他物质情况：_ _ _ _ _ _

> 注意：不要自己要求医生开某种药；把清单如实交给医生判断即可。

十、近期生活事件（过去半年到一年）

- 工作/学业变化（加班、失业、考试、离职创业）：＿＿＿＿＿＿
- 家庭/关系变化（分手、离婚、家人重病、离世）：＿＿＿＿＿＿
- **作息变化**：有没有最近熬夜、倒班、长途时差？（睡眠紊乱是转躁常见诱因）＿＿＿＿＿＿
- 经济压力：＿＿＿＿＿＿

十一、想问医生的问题清单（提前写 3～5 个）

参考问题，挑你最关心的：

1. 我这种情况，是双相吗？是I型还是II型？依据是什么？
2. 需不需要做甲功、心电图这些检查？为什么？
3. 如果需要吃药，常见副作用有哪些？需不需要定期抽血监测？
4. 我以前被当成"抑郁症"吃过抗抑郁药，现在方案会有什么不同？
5. 大概要治疗多久？能不能自己停药？
6. 生活上（睡眠、咖啡、饮酒、作息）我最该注意什么？
7. 下次什么时候复诊？出现什么情况要立刻回来？

你的问题：

- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、就诊当天要带的东西（出门前对照）

- [ ] 身份证、医保卡
- [ ] 这本填好的"就诊前准备清单"（尤其那张情绪波动时间线）
- [ ] 既往病历本、出院小结、所有检查报告
- [ ] 正在吃的所有药的药盒（或手机拍照）
- [ ] 一位了解你多年状态的**家属或老朋友**一起去——躁狂期的病史，他们往往记得比你清楚
- [ ] 一支笔、一张纸（记医生说的要点）
- [ ] 如有强烈自伤念头或身体极度不适，请家属陪同，必要时直接挂急诊

十三、就诊当天的小提醒

- **说具体事，别只下诊断**：别说"我觉得我是双相"，说"过去两年我有过两次连续熬夜还特别精神、疯狂花钱的时期，中间还躺了一个多月"。
- **该说的别瞒**：喝酒、熬夜、冲动消费、自伤念头、以前吃过的药——当着家属不好说，可以请医生单独谈话。
- **没听清就问**："这个病要监测什么？多久抽一次血？什么情况要立刻回来？"

【个人体验】很多人第一次被确诊双相时，反而有一种如释重负的感觉："原来我那些忽上忽下、花钱失控的年头，不是我人品差、不是我懒，是一种有名字、有办法的病。"

十四、一句话总结

双相的病史，一半在抑郁期的记忆里，一半在家人的眼睛里。花十分钟把"情绪波动时间线"填好，再带个了解你的人去，这一次就诊的价值会大很多。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（病史采集与知情同意流程）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 世界卫生组织（WHO）：*mhGAP Intervention Guide*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240084278
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- APA：*DSM-5 双相及相关障碍诊断标准*. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。

4. 诊断流程与评估量表

> 双相没有"拍个片子就知道"的仪器，它是**临床诊断**——靠精神检查、完整病史（本人+家属）、排除躯体疾病，再对照诊断标准。量表（MDQ、HCL-32、YMRS、PHQ-9 等）只是**筛查和监测工具，不能单独确诊**。双相还常常需要观察几次发作、经过一段时间才能把分型定准。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、医生是怎么诊断的（五步）

步骤	内容	你需要做的
1. 精神检查	医生面对面观察你的情绪、言语、思维、行为，询问症状	照实说、举例子
2. 病史采集（本人）	情绪波动史、发作起止、诱因、既往用药、家族史	带上《就诊前准备清单》
3. 病史补充（家属）	躁狂期你自己往往不自知，家属观察非常关键	带了解你的家属一起
4. 躯体与实验室排查	甲功、血常规、肝肾功能、血糖、心电图等，排除甲亢等"伪装成双相"的病	按医嘱抽血、做检查
5. 对照诊断标准	结合 DSM-5 / ICD-11 判断是I型、II型、环性心境，是否共病	由医生下结论

【临床共识】为什么医生总要你先查甲功？因为**甲状腺功能亢进**会心慌、兴奋、消瘦、失眠，看上去很像躁狂；某些药物、物质、脑部疾病也会造成类似情绪波动。把这些排除掉，双相的诊断才干净。

【临床共识】ICD-11 里双相及相关障碍的编码是：**6A60 双相I型障碍、6A61 双相II型障碍、6A62 环性心境障碍**（以 WHO ICD-11 浏览器实际查询为准）。DSM-5 对应"Bipolar and Related Disorders"一章。你不需要自己对号入座，但可以在病历上看到这些编号。

二、为什么双相常常"一时半会儿定不了型"

【临床共识】这是双相诊断最特殊的一点：

- 很多人第一次就诊时，正处在**抑郁发作**里，医生眼前的你"就是个抑郁症"；
- 而区分"单相抑郁"和"双相抑郁"的关键——**你以前有没有过躁狂/轻躁狂**——你自己可能不记得、或不觉得那是病；
- 所以相当一部分患者最初被诊断为"抑郁"，**直到某次治疗中出现了转躁、或家属补充了病史，才修正为双相。**

【个人体验】这不是医生水平差，而是双相本身就藏在抑郁的表象下面。所以：**如果你有过"好得不正常"的时期，一定要主动说**——这一句话可能直接改变你的诊断和治疗方向。

三、几个常用量表是干什么的（了解即可）

> 【重要声明】**以下所有量表仅用于筛查和辅助评估，不能据此确诊，也不能用来判断要不要吃药、要不要停药。** 它们是"体温枪"，不是"诊断书"。

量表	查什么	谁来评	用途
MDQ 心境障碍问卷	既往有没有过躁狂/轻躁狂的一群症状	自评	**筛查双相**，尤其在抑郁患者中找出"藏着的双相"
HCL-32 轻躁狂症状清单	轻躁狂的典型表现（精力、社交、性欲、消费等）	自评	辅助识别双相II型（轻躁狂较轻、更易被忽略）
YMRS 杨氏躁狂量表	当前躁狂症状的严重程度	**医生/他评**	躁狂发作时评估轻重、随访疗效；**你不需要自己填**
PHQ-9	抑郁症状的程度（9题）	自评	评估抑郁相、监测变化；**第9题自伤念头≥1分要立即告诉医生**
GAD-7	焦虑程度	自评	双常常合并焦虑，一起填
HAMD / MADRS	抑郁严重程度	**他评**	医生用，你不用自己打分

【临床共识】**MDQ 和 HCL-32 是给"抑郁背后可能藏着轻躁狂"的人用的筛查工具。**它的意义在于提醒医生："这个人可能不只是抑郁"——但分数高低都不直接等于"是双相"，最终仍靠完整病史和医生判断。

四、MDQ 大致问哪些（示意，不是让你自测确诊）

MDQ 通常围绕你**一生中**是否出现过这样一段时期：比平时更开心/更易怒、精力更旺、睡得更少、话更多、想法更快、更爱社交/更爱花钱/性欲更强、同时开很多件事、更容易冲动。这些症状是否在**同一段时间**一起出现、造成了什么问题（工作、家庭、花钱、法律麻烦）。

- 它筛的是"**有没有过那样一段时期**"，不是"你现在严不严重"；
- **分数提示风险，不代替诊断**；
- 把结果拿给医生看，比你自己在网上对答案有用。

五、量表的正确用法（务必记住）

1. **按真实感受填**，不要为了"想确诊"或"想显得轻"改答案。
2. **不要天天测。**一周最多一次；分数本身的涨跌不该成为新的焦虑源。
3. 用**同一份量表、同一回顾周期**前后比较，别今天 MDQ、明天换个网上的"双相测试"。
4. 把分数和日期记下来，**复诊时带给医生看**——比你说"好像好一点"更有用。
5. **分数下降 ≠ 可以停药；分数升高也不必恐慌**，要结合"能不能上班、能不能管住冲动、睡得好不好"一起判断。
6. 网上各种"三分钟测双相"小程序鱼龙混杂，**以 MDQ、HCL-32、PHQ-9 等标准化工具为准，并交给医生解读。**

六、医生可能怎么排除"看着像双相"的其他病

容易混淆的情况	怎么区分
甲亢	查甲功；心慌兴奋伴消瘦、手抖
物质/药物引起的情绪波动	酒精、兴奋剂、激素、某些药物可诱发亢奋；靠病史和物质使用史区分
精神分裂症	双相在发作间期通常社会功能可恢复；精神病性症状与心境发作是否同步出现
ADHD	注意力问题从小就有、长期稳定，不是"发作性"的高低起伏
边缘型人格障碍	情绪波动多与人际关系被抛弃感相关，不是数周数月的躁狂/抑郁发作
单相抑郁	关键看**从无躁狂/轻躁狂**——这也是为什么要主动回忆"好得不正常"的时期

【临床共识】**双相与单相抑郁的鉴别，直接决定治疗方向**：如果是双相却长期只吃抗抑郁药，可能诱发转躁、快速循环（详见《模块6·药物治疗》）。这就是为什么医生对"你以前有没有过亢奋期"这个问题格外较真。

七、一句话记住

诊断靠精神检查 + 本人和家属一起回忆的完整病史 + 排除甲亢等躯体疾病 + 对照标准；量表是温度计，不是判决书。双相常常要观察几次发作才能定准型——所以"主动说出那段好得不正常的日子"，比任何量表都重要。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（评估与鉴别诊断）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- APA：*DSM-5 双相及相关障碍（Bipolar and Related Disorders）*. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 世界卫生组织（WHO）：*ICD-11 双相及相关障碍（6A60–6A62）*. https://icd.who.int/en
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- MDQ（心境障碍问卷）：Hirschfeld RMA 等关于双相筛查工具的原始文献；HCL-32（轻躁狂症状清单）：Angst J 等。
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。

5. 常见共病

> 双相很少"孤零零"地来。焦虑、酒精/物质问题、ADHD、人格困扰、进食障碍、甲状腺疾病……常常和它手拉手出现。共病不是"你问题特别多"，而是这个谱系本身容易互相叠加。**就诊时一次说全，医生才能给你一张完整的地图。**
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、什么是"共病"

共病（comorbidity）指同一个人同时存在两种或更多疾病/问题。【临床共识】双相障碍的共病非常普遍，研究中相当比例的双相患者终生共病一种以上其他疾病。这不是"治不好"，而是治疗时需要统筹兼顾。

二、双相 + 焦虑障碍：最常见的一对

维度	躁狂/轻躁狂	焦虑
核心感受	异常兴奋、话多、睡少却不困	过度担心、紧张、坐不住
时间指向	觉得自己无所不能	担心还没发生的事

【研究结论】双相与焦虑障碍（惊恐、广泛性焦虑、社交焦虑）高度共病。焦虑常出现在抑郁相、或发作间期。共病焦虑会让双相更难识别、更易残留症状。

【临床共识】所以医生常让你同时填 **PHQ-9（查抑郁）和 GAD-7（查焦虑）**。只要 PHQ-9 第9题（自伤念头）得分≥1，无论总分多少，都要立即告诉医生。

三、双相 + 酒精/物质使用（非常重要）

- **酒精**：抑郁相时借酒浇愁，躁狂期又容易豪饮；短期放松，长期加重情绪不稳、破坏睡眠、与药物叠加危险；
- **兴奋剂/大麻等**：可能诱发或加重躁狂，混淆症状，让医生更难判断；
- **镇静类药物**：自行长期服用易依赖，突然停用反跳性失眠焦虑。

【临床共识】如果你开始靠喝酒、靠某种物质才能睡好觉或"压住"情绪，**一定如实告诉医生**——这本身就是需要处理的问题。隐瞒会让治疗方案严重偏掉：物质引起的情绪波动，和双相本身的波动，治疗方向完全不同。

四、双相 + ADHD（注意鉴别）

问题	典型表现	与双相的区别
ADHD 注意缺陷多动	从小就坐不住、粗心、分心、拖延	**长期、稳定**，从童年持续存在，不是发作性高低起伏
双相	一段段亢奋/低落交替	**发作性**，有明显的起止和波动

【临床共识】两者都可能"注意力不集中、话多、闲不住"，但 ADHD 是一辈子的特质，双相是一阵一阵的病。**关键鉴别点：这些问题是从小就有，还是最近几年才一阵一阵出现？** 两者也可能真的共病，由医生综合判断。

五、双相 + 边缘型人格/人际敏感

【临床共识】双相的情绪波动和边缘型人格特质的情绪不稳有时会被混淆。一个简单的区分思路：

- **双相**的情绪高涨/低落通常持续**数天到数周以上**，是发作性的；
- **人格相关的情绪不稳**更多由**人际关系中的被抛弃感**触发，波动往往以**小时到天**计。

两者可以共病，治疗上也可能互相影响。就诊时如实描述"我情绪一波动，通常是因为什么事、持续多久"，会直接帮助医生判断。

六、双相 + 进食障碍

【研究结论】双相与进食障碍（尤其贪食、暴食）有一定共病。抑郁相的情绪性暴食、躁狂期的冲动性进食行为，都可能出现。如果你有反复暴食、催吐、极端节食，就诊时主动说——它会影响营养、体重和药物选择。

七、双相 + 躯体疾病（尤其甲状腺）

躯体疾病	与双相的关系
甲状腺功能异常（甲亢/甲减）	**甲亢**酷似躁狂（心慌、兴奋、消瘦）；**甲减**可加重抑郁、也是快速循环的相关因素之一。初诊常查甲功，锂盐治疗期间也要监测甲状腺
心血管疾病	躁狂期激越、高脂高糖、部分药物影响代谢
代谢/体重问题	部分心境稳定剂、抗精神病药可影响食欲、体重、血糖血脂，需监测
多囊卵巢（育龄女性）	与部分药物、育龄期女性相关，需医生评估

【临床共识】这就是为什么初诊要查甲功、肝肾功能、心电图——把"身体能解释的"先排除，双相的诊断和用药才安全。

八、共病如何影响识别与治疗

1. **就诊时一次说全**：焦虑、喝酒、注意力差、暴食、甲状腺问题——都讲，别只挑最难受的那一段。
2. **治疗常需统筹**：双相的用药（心境稳定剂）要在前面，再考虑其他共病的处理；**如果只是双相的抑郁相，单独长期用抗抑郁药要非常谨慎**（详见《模块6·药物治疗》）。
3. **不要只治一半**：只处理情绪、不管酒精，或只顾吃药、不管焦虑和作息，都容易反复。
4. **耐心一点**：共病意味着评估和调整期更长，不是"药没用"。

【个人体验】有患者说："原来我不是'又双相又焦虑又喝酒又甲状腺不好'四个事，而是一套互相牵着的东西。医生统筹着治，比我分头跑好几个科清楚多了。"

九、一句话记住

共病不等于病得更重，而是更需要一次说清楚。 把焦虑、酒精/物质、注意力问题、进食、甲状腺和既往用药，在就诊时一次讲全，医生才能给你一张完整的地图，而不是按下葫芦浮起瓢。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（双相共病的评估与管理）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- APA：*DSM-5 双相及相关障碍、焦虑障碍、物质相关障碍*. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 世界卫生组织（WHO）：*ICD-11*. https://icd.who.int/en
- 双相与物质使用、ADHD、进食障碍共病的流行病学研究：见 CANMAT/ISBD 双相障碍管理指南关于共病的章节。
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。

模块 6

治疗方案

1. 药物治疗

> 双相是一种需要**长期心境稳定**的疾病，药物是治疗的基石——它不是"快乐药"，也不是吃了立刻不波动的开关。本页只介绍药物类别、代表通用名、起效规律、常见副作用与监测原则，**不涉及任何具体剂量、疗程天数与换药方案**——你吃哪种、吃多少、怎么停，必须由精神科医生根据你的情况决定。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、先建立几个正确预期

【临床共识】双相情感障碍有明确的生物学基础：大脑调节情绪稳定性的系统（涉及神经递质、生物节律等）出了问题，导致情绪在"过高"和"过低"之间摆。治疗的核心目标，不是把你变成没有情绪的人，而是**把情绪的摆幅压回到正常范围。**

- 药物针对的是**疾病本身**，不是你的性格；
- 多数人需要"药物 + 心理/作息管理 + 生活调整"的组合；
- 【研究结论】规范使用心境稳定剂，能显著减少躁狂和抑郁发作的频率与强度。即使第一种药效果不理想，也有换用、联合等多条路，不要因为一次效果不好就认定"药对我没用"。

【个人体验】很多人第一次拿到药盒会紧张："我是不是一辈子都要吃药了？""锂是不是有毒？"——后面"用药常见顾虑"一节会客观回答。

二、双相的三类核心药物（类别与通用名）

下面只列**类别和通用名**，帮你看懂医生处方和说明书，不代表你应自行选用。

类别	代表通用名	大致特点与提示
经典心境稳定剂	**碳酸锂、丙戊酸钠（丙戊酸）、卡马西平**	双相治疗的基石，尤其用于控制和预防躁狂发作、稳定情绪。具体选哪种由医生根据发作类型、性别、年龄、躯体情况决定
第二代（非典型）抗精神病药	如喹硫平、奥氮平、利培酮、阿立哌唑、齐拉西酮、鲁拉西酮等	既可用于急性躁狂/混合发作，部分也用于双相抑郁和维持稳定；不同药的副作用谱（嗜睡、体重、代谢）差异较大
抗抑郁药	各种 SSRI/SNRI	**在双相中地位特殊**——见下文专节，通常不单独长期使用

【临床共识】双相治疗与单相抑郁最大的区别在于：**以心境稳定剂（或有心境稳定作用的抗精神病药）为基础**，而不是像抑郁症那样以抗抑郁药为主。方向搞反，后果会很糟。

三、抗抑郁药：双相中最容易踩的坑

【临床共识】这是本篇必须单独讲清楚的一点：

- 在**双相**患者中，长期**单独使用**抗抑郁药（没有心境稳定剂打底），可能诱发**躁狂/轻躁狂发作**、诱发**快速循环**（一年发作≥4次）、让情绪摆得更厉害；

- 所以双相抑郁相的治疗，通常优先考虑心境稳定剂/有抗抑郁作用的心境稳定药物；**是否加用、何时加用抗抑郁药，必须由精神科医生在心境稳定基础上评估**；
- 这也是为什么如果你以前被误诊为"单相抑郁"、吃了抗抑郁药后变得异常兴奋——那可能不是"药起效了"，而是**被诱发的躁狂**，是一条重要的诊断线索。

【个人体验】很多双相康复者都有过这样的经历："之前光吃抗抑郁药，越吃越觉得自己飘、睡很少还特别精神、疯狂花钱。"现在回头看，那就是单药抗抑郁诱发的转躁。**所以，如果你正在吃抗抑郁药，又出现了"睡得少却不困、话多、敢花钱"，尽快复诊告诉医生，不要自己加量。**

四、起效规律：最容易半途而废的一关

时间窗	通常发生的变化	你的正确做法
服药最初几天～1～2周	可能几乎感觉不到情绪变稳；反而出现恶心、手抖、犯困、头晕等适应反应	**不要急着停药。**这是身体在适应
约1～2周～数周	急性躁狂/激越可能先开始被压下来；情绪的稳定往往滞后	坚持按医嘱服药，记录反应
约数周～更久	才能较充分地评估这一种药是否帮你稳住情绪、减少发作	复诊，由医生判断疗效

【临床共识】心境稳定剂**不是吃了立刻平静的药**，它需要时间达到稳定状态，而且"稳住"的感觉往往不像"变好"那么鲜明——你可能只是发现"这个月我没再大起大落"。"吃了一两周没感觉就停"是最常见、也最可惜的做法。

五、各类药物的常见副作用与监测原则

副作用个体差异很大，**多数早期不适会在数周内逐渐适应**，不要因轻微反应自行停药。但你要能分清"忍一忍会过去"和"必须尽快告诉医生"。

A. 碳酸锂（锂盐）——最需要规律监测的药

【临床共识】碳酸锂是经典、证据充分的心境稳定剂，但它的治疗窗较窄，**必须规律监测**：

- **定期查血药浓度**（抽血时间有讲究，由医生/护士安排）——浓度太低可能不够稳，太高可能中毒；
- **定期查肾功能**（锂主要经肾脏排出）；
- **定期查甲状腺功能**（锂可能影响甲状腺）；
- **注意补液和盐摄入稳定**：大量出汗、腹泻、脱水、突然少盐都可能让体内锂浓度升高、增加中毒风险；**不要自行突然大幅改变喝水量或吃盐量**；
- 常见早期反应：恶心、轻微手抖、尿频、口渴——多在适应后减轻，但要告诉医生。

> **锂中毒的警示信号**：明显的手抖加重、恶心呕吐、腹泻、困倦、说话含糊、走路不稳、意识模糊——**一旦出现，立即停药并尽快就医/急诊**（具体应急以医生事先交代和当地急救为准）。

B. 丙戊酸钠 / 卡马西平——育龄女性尤其要知情

【临床共识】

- 这类药常见反应：恶心、头晕、嗜睡、手抖、体重变化（丙戊酸较明显）、肝功能影响、血小板影响等，需按医嘱监测血常规、肝功能等；
- **【最高优先级警示】丙戊酸、卡马西平等有明确的致畸风险**：育龄期女性、备孕、妊娠期使用可能对胎儿造成严重危害。**如果你是育龄女性且有生育计划，或发现自己怀孕，务必在用药前/尽快告知医生**，与医生共同权衡；**在治疗期间应采取可靠避孕，并由医生指导，不要自行怀孕、也不要自行停药。**

C. 第二代抗精神病药

- 常见反应：嗜睡、头晕、体位性低血压、口干、便秘；
- 部分药可能影响**食欲、体重、血糖、血脂**，需要定期监测体重、代谢指标；
- 少数人可能出现锥体外系反应（手抖、僵硬、坐不住）、泌乳素变化等——出现了告诉医生，是可以处理的。

D. 需要尽快告诉医生/急诊的危险信号

反应	典型表现	行动
锂中毒	手抖骤增、呕吐腹泻、嗜睡、说话含糊、走路不稳、意识模糊	**立即就医/急诊**
5-羟色胺综合征	高热、意识混乱、明显激越、肌肉僵硬抽动、大汗、心跳快	**立即急诊**
皮疹、发热	服药后新发皮疹尤其伴发热（卡马西平等有严重皮疹风险）	**尽快就医/急诊**
黄疸、严重恶心、出血倾向	可能是肝功能/血液系统问题	尽快就医
诱发躁狂/轻躁狂	突然异常兴奋、睡少却不困、冲动消费	**立即复诊**

六、用药总原则：规律、不擅自加停、不漏服

1. 为什么不能自行加药、减药、停药

【临床共识】这是双相用药最核心的纪律：

- **自行加药**（觉得情绪低就多吃点、觉得兴奋就自己加量）可能导致过量、中毒，或打乱医生正在摸索的稳定方案；
- **自行停药**是复发最常见的人为原因之一——突然停掉心境稳定剂，**撤药后复发风险显著升高**，而且复发往往来势更猛；
- 很多人"一感觉好就自己停药"，结果几个月内再次躁狂或抑郁发作，而每复发一次，未来复发的风险、治疗难度都可能上升。

【临床共识】停药必须在医生指导下**缓慢、逐步、有计划地减量**，并在减量期间密切观察情绪和睡眠变化。哪怕你已经决定要停，也要先和医生约好节奏。

2. 漏服了怎么办

- **不要下次自己加倍补吃**——尤其锂盐，加倍有中毒风险；
- 想起来时若离下次服药还久，按医嘱补服一次；若已接近下次服药时间，跳过这次、按原计划继续；
- 记不清、拿不准时，问开药医生或药师，而不是凭感觉加倍。

3. 为什么要"规律作息、不熬夜"

【临床共识】**睡眠剥夺和作息紊乱是转躁的常见诱因**，也是药物是否管用的重要前提。再稳的心境稳定剂，也架不住长期熬夜、倒时差、昼夜颠倒。把睡觉和起床时间固定住，本身就是治疗的一部分（详见《模块7》IPSRT 节律管理）。

七、特殊情况

- **妊娠、备孕、哺乳**：这是医生与患者共同权衡的决策——不治疗的中重度双相本身对母亲和胎儿也有风险。**如果你在备孕或已怀孕，不要自行停药，尽快告知医生**；育龄女性务必留意丙戊酸/卡马西平的致畸警示。
- **饮酒与物质**：酒精破坏睡眠、加重情绪不稳、与药物叠加镇静风险，应尽量避免；兴奋剂、大麻可能诱发躁狂。
- **老年、肝肾功能不全**：药物代谢不同，监测更重要。
- **正在服用的其他药、保健品、中成药**：都要告诉医生，包括避孕药、感冒药、止痛药——很多会相互作用（如锂盐与某些降压药、非甾体抗炎药）。

八、用药常见顾虑答疑

你的担心	客观说明
"锂是不是有毒？是不是在吃毒药？"	碳酸锂是成熟、用了几十年的心境稳定剂，**关键在规律监测血药浓度和肝肾甲状腺**。在医生监测下使用是安全的；擅自乱服、脱水、漏查血药浓度才危险。
"会不会一辈子戒不掉？"	双相本身容易复发，长期维持用药是为了**降低复发风险**，像高血压长期吃药一样，不是"成瘾"。是否能减、何时减，由医生根据你的发作次数和稳定情况决定。
"吃了会不会变傻、反应变慢？"	少数人初期会犯困、略钝，多在适应后缓解；**躁狂和抑郁本身才是让注意力、记忆力下降的原因**。规范治疗后，很多人反而觉得情绪稳了、脑子更清楚。
"我靠自己调整作息行不行，不想吃药？"	轻躁狂/缓解期的作息管理是重要辅助；但中重度、反复发作时，硬扛会错过最佳干预期，药物能帮你先把摆幅压下来，再谈自我管理。
"网上说这药副作用特别吓人？"	【争议观点】网上把药说得极可怕或极无害都不真实：它确实有副作用和需要监测的风险，但在医生指导下规范使用是安全、成熟的治疗手段。

九、一张表看懂用药全过程

阶段	时间感	重点任务	复诊/监测节奏
启动期	头1–2周	适应副作用、不漏服、不熬夜	按医嘱，有危险信号随时就医
起效/调定期	数周内	观察情绪摆幅、睡眠变化，记录反应	复诊，按医嘱查血药浓度/肝肾甲功
稳定评估期	数月	判断疗效，不擅自加减	规律复诊
巩固期	症状稳定后数月	不擅自减停，配合节律管理	规律复诊+定期监测
维持期	反复发作人群	长期管理，与医生商定维持时长	定期复诊+定期化验

十、你可以现在就做的三件事

1. 把正在吃/准备吃的药名（通用名）记在手机里，复诊时主动告诉医生身体反应；
2. 告诉一位你信任的家人你在治疗中，让他在你"想自行停药/加药"时提醒你先问医生；
3. 把开药医生、医院和最近一次血药浓度/化验的时间存好，并记住"手抖骤增、呕吐腹泻、嗜睡迷糊"是要立刻就医的警示。

> **再次提醒**：本页用于帮你理解治疗、更好地和医生沟通。**具体用药、剂量、加减停，必须由精神科面诊医生决定。** 如果你此刻正处在强烈的抑郁/混合状态、有自伤冲动，请直接参阅《模块8》的危机识别与求助。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（药物治疗与监测）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 加拿大情绪和焦虑治疗网络（CANMAT）/ 国际双相障碍学会（ISBD）双相障碍管理指南（心境稳定剂、抗精神病药、抗抑郁药使用原则）。
- APA：*Practice Guideline for the Treatment of Patients with Bipolar Disorder*.
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 锂盐血药浓度监测、甲状腺/肾功能监测及丙戊酸/卡马西平致畸警示：参见各国双相障碍指南与药品说明书。

2. 心理治疗

> 双相的心理治疗不是"想开点"，而是一套有证据的专业干预——它的核心任务是：**帮你认出复发的苗头、把作息节律稳住、把家庭关系理顺**。在双相中，心理治疗是药物治疗的**辅助**而不是替代；单用谈话通常压不住急性躁狂，但它能显著减少复发、帮你稳住长期生活。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、先理解：双相为什么需要心理治疗

【临床共识】双相是"生物 + 心理 + 社会节律"共同作用的病。药把情绪的摆幅压下来，但以下这些事药替你做不了：

- 认出自己快要转躁/转郁的早期信号；
- 把睡眠、起床、吃饭、社交的时间固定住（**作息紊乱本身就是转躁诱因**）；
- 处理躁狂期留下的烂摊子（挥霍的钱、破裂的关系、辞掉的工作）；
- 让家人懂得怎么支持你，而不是和你对吵。

【个人体验】康复者常说："药让我不那么大起大落了，但真正让我不再反复栽跟头的，是我学会了看自己睡眠和脾气的变化，知道该提前找医生。"

二、双相常用的几种心理治疗

疗法	核心理念与做法	适合阶段	大致形式
心理教育（Psychoeducation）	系统了解这个病：发作长什么样、药怎么用、睡眠多重要、复发信号有哪些	**各阶段都适用，是基础**	个体或团体，几次到十几次
CBT 认知行为治疗	识别并调整对疾病的负性认知（"我完了"）、纠正躁狂期的夸大想法、建立规律作息和应对技巧	缓解期、抑郁相、防复发	结构化，有作业
IPSRT 人际社会节律治疗	**稳定日常作息与社会接触节律**：把起床、睡觉、吃饭、见人的时间固定，减少"作息被打乱→转躁"	**双相特色、证据较强**，尤其伴睡眠/人际混乱者	结构化，记录节律
FFT 家庭焦点治疗	降低家庭中的高情感表达（频繁指责、过度卷入），改善沟通和解决冲突方式	家庭矛盾突出、反复发作	含家属参与，十几次
同伴支持	由康复者带领/陪伴，分享经验、互相提醒、减少病耻感	各阶段的辅助	团体/社群

【临床共识】综合 NICE、CANMAT 等指南：**心理教育、IPSRT、FFT、CBT** 是双相中证据较好的心理治疗，通常作为**药物治疗的辅助**，能帮助减少复发、提高坚持用药和规律作息的依从性。

三、IPSRT：双相里最有特色的一种

【研究结论】IPSRT（Interpersonal and Social Rhythm Therapy，人际与社会节律治疗）的核心观察是：**双相患者的情绪节律，对"作息和社会节律被打乱"特别敏感**——熬夜、倒时差、加班、通宵聚会、生活中大变动，都可能成为转躁的扳机。

它做的事很朴素：

- 帮你建立并维持**稳定的日常节律**：固定起床时间、睡眠时间、吃饭时间、白天的活动安排；
- 帮你处理**扰乱节律的人际事件**（冲突、离别、新环境），减少它们对作息的冲击；
- 用一张"**社会节律记录表**"每天打勾，观察作息变化。

【个人体验】对很多康复者来说，"固定起床时间"是性价比最高的一条：不管前一晚几点睡，尽量在差不多的时间起床、晒晒太阳，情绪的波动会小很多。具体记录表见《模块7》。

四、心理治疗在什么阶段做最合适

阶段	适不适合做心理治疗
急性躁狂/激越期	**不适合**——此时话多、冲动、不觉得自己病了，谈话谈不进去，先靠药物/住院把急性症状压下来
急性重度抑郁期	先药物稳定；可做支持性陪伴，但高强度的认知练习要等力气恢复
巩固/缓解期	**黄金期**——认知治疗、IPSRT、FFT 都适合在这时深入做，重点是防复发
维持期	定期、按需做，维持节律、处理生活事件

【临床共识】所以不要在躁狂期逼自己"做通心理治疗"。先把急性症状稳住，再谈心理工作——顺序反了，事倍功半。

五、心理治疗 vs 药物：怎么配合

【临床共识】

- **不能单用心理治疗替代药物**处理中重度、反复发作的双相；
- 单用药物而不做心理/节律管理，容易因为熬夜、停药、家庭冲突而复发；
- 最佳状态是**药物稳住摆幅 + 心理治疗教会你长期自我管理。**

【个人体验】常见的两个极端："只吃药不管自己作息"（一熬夜就转躁），和"坚决不吃药、光靠冥想和想开点"（急性发作时硬扛不住）。康复得好的人，往往是两者都做。

六、谁是精神科医生，谁是心理治疗师（再提醒一次）

	精神科医师	心理治疗师/咨询师
能否诊断、开药	能	不能
主要工作	药物、安全、住院、物理治疗	谈话、CBT/IPSRT/FFT、节律与家庭工作

【个人体验】你最好的状态是一个"团队"：医生管药，治疗师带你做节律和认知，家属在 FFT 里学会怎么支持。如果有人只聊几次就劝你"别吃药了、光聊天就能好"，请多问一句、换正规机构核实。

七、如何选择合格的治疗师

- 有正规受训背景，明确做过双相相关心理治疗（CBT/IPSRT/FFT），属于可查证的专业体系；
- 发现你处于急性发作或有安全风险时，会**建议你同时看精神科**，而不是硬留在咨询里；
- 遵守伦理边界、保密原则，会事先说明保密的例外（自伤伤人时需突破）；
- 会给你具体工具（作息记录、复发预警清单），而不只是倾听。

八、线上/团体心理治疗

形式	特点
个体面对面	最经典，适合深入做认知、家庭工作
团体心理教育	同类人一起学习，减少病耻感、互相提醒，性价比高
线上视频	方便可及，对出行不便者友好；结构化内容线上同样有效
自助APP/书籍	可作热身和补充，但**急性发作、有安全风险时不能只靠它**

> **提醒**：心理治疗有效，但它是药物的辅助，也需要你状态好一些时再深入做。如果你此刻正处在急性躁狂或重度抑郁，请先就医稳定状态。配合《模块7》的自我调节，会事半功倍。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（心理治疗推荐）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- IPSRT（人际与社会节律治疗）：Frank E 等关于双相障碍节律治疗的研究与著作。
- FFT（家庭焦点治疗）：Miklowitz DJ 等双相家庭干预研究。
- CANMAT/ISBD 双相障碍管理指南（心理治疗部分）。
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。

3. 物理治疗

> "电休克"是双相患者最害怕、也最被误解的词之一。它和老电影里那种"电刑"完全不同，是在麻醉下进行的成熟医疗操作，在**严重躁狂、重度抑郁、混合状态、紧张症、难治性病例**中甚至能救命。本页帮你看懂这些方法是什么、什么时候用、常见反应，以及哪些说法要警惕。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行确诊。

一、一句话先定位

【临床共识】双相的一线治疗永远是：**心境稳定剂/抗精神病药（±心理治疗与节律管理）**。物理治疗是在急性症状严重、药物效果不足、或需要快速控制时，由医生评估加用的手段——它不是"更高级的首选"，而是工具箱里特定情况下的一把利器。

二、无抽搐电休克治疗（MECT）

这是双相物理治疗中最常被讨论、也最"名声吓人"的一种，需要重点讲清楚。

它用于什么情况

【临床共识】以下情况，医生常会考虑 MECT：

- **严重躁狂**：彻夜不眠、极度兴奋、冲动攻击、拒食、药物短期难以控制；
- **重度抑郁**伴强烈、反复的自杀念头或行为；
- **混合状态**：既躁狂又抑郁，激越且有强烈自伤风险（混合相自杀风险尤其高）；
- **紧张症**（木僵、不动、不进食，身体有衰竭风险）；
- **难治性病例**：多种规范药物治疗后效果仍不理想；
- 患者对药物不能耐受，或躯体状况不适合用药时。

大致过程

- 在**全身麻醉 + 肌肉松弛剂**下进行，你全程无意识、无痛苦；
- 通过短暂、可控的大脑刺激诱发一次治疗所需的发作，现代技术下肌肉几乎不动，所以叫"无抽搐"；
- 通常一个疗程由多次治疗组成，之后由团队评估是否需要维持治疗。

常见不良反应

- 治疗后短期内可能有**近事记忆下降**、头痛、恶心；
- 多数记忆问题会随时间逐渐恢复，个体差异存在；
- 麻醉相关风险由麻醉团队评估把关。

【争议观点】关于 MECT 对记忆的长期影响，研究结果不完全一致，但它在**严重、危急情况下的快速控制价值**是被公认的。重要的是**知情同意**：做之前，医生会向你和家属讲清收益、风险和替代方案。

【个人体验】很多人是在"药物已经压不住、人已经很危险"时才接受 MECT，事后回忆它帮自己跨过了最难的那道坎。不必被旧印象吓退，但也不必把它神化为"一次就好"。

三、重复经颅磁刺激（rTMS）

- **是什么**：用磁场无创刺激大脑特定皮层区域，你全程清醒、坐着即可，不需要麻醉；治疗时能听到"哒哒"声、头皮有轻敲感。
- **适用与证据**：【研究结论】rTMS 在**难治性抑郁**中证据较充分；在双相中可作为双相抑郁、或药物效果不佳时的辅助选择，需在**心境稳定基础上**由医生评估——因为单纯抑郁相时也要警惕转躁。
- **疗程体感**：通常需要多次、按疗程进行（具体次数频率由医生设定），多数人耐受较好，常见轻微头皮不适、头痛；**有癫痫史、颅内金属植入物、心脏起搏器者需提前告知医生。**

【个人体验】如果你看到"做几次磁疗根治双相"，要警惕——rTMS 是需要医生评估、按疗程进行的医疗手段，不是美容院式的保养项目。

四、其他较少展开的方法

- **tDCS（经颅直流电刺激）**：证据相对弱、仍在研究；
- **睡眠/节律相关干预**：在 IPSRT 框架下的作息稳定，虽不是"物理治疗"，但对双相转躁预防至关重要；
- **光照治疗**：主要针对季节性情绪波动，需医生评估时段。

五、对照表：物理治疗怎么选

治疗	适用人群	大致过程	常见反应	你可以问医生的问题
MECT	严重躁狂/重度抑郁/混合/紧张症/难治性/药物不耐受	全麻下多次治疗，住院或日间	短期近事记忆下降、头痛恶心，多逐渐恢复	我为什么适合？疗程几次？记忆影响多久？替代方案是什么？
rTMS	药物效果不佳的双相抑郁等辅助	门诊、清醒、按疗程	头皮不适、轻头痛	我需要做多少次？和我的药物怎么配合？

六、关于物理治疗的几个事实

1. **它不是惩罚。** 它和开药一样，是为了帮你恢复，由你知情同意后进行；
2. **它不是万能。** 多数人仍需要后续的药物维持和节律管理；
3. **决定权在专业团队。** 不要因为"听说谁做过"就主动要求，也不要因为旧印象就坚决拒绝——和医生充分讨论利弊；
4. **家属的角色**是陪伴、协助知情同意、观察治疗后状态，而不是代替你做所有决定。

七、警惕这些营销话术

话术	真相
"电疗/磁疗根治双相，做几次断根"	物理治疗是辅助、需疗程、需医生评估，不存在"一次断根"

话术	真相
"电休克会把人电傻、伤脑"	现代 MECT 是麻醉下进行，短期近事记忆问题多可恢复；它在危急时的价值是公认的
"不用吃药、不用管作息，光做理疗就行"	违背双相一线治疗原则，药与节律管理才是主体

> **提醒**：本页用于消除误解、帮你与医生沟通。是否进行物理治疗、采用哪种，必须由精神科团队面诊评估。如果你此刻有强烈的自伤/自杀冲动或彻夜不眠伴胡言乱语，请直接参阅《模块8》的危机识别与求助。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（电休克等物理治疗适应证）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Brain Stimulation Therapies / Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- APA：*Practice Guideline for the Treatment of Patients with Bipolar Disorder*（含 MECT 推荐）。
- CANMAT/ISBD 双相障碍管理指南（物理治疗部分）。
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- rTMS 双相抑郁应用：相关临床指南与系统综述。

4. 治疗预期与目标

> 双相的治疗不是"吃几天药就根治"，而是一个**分阶段、有波动、需要你长期参与**的过程。最现实的目标不是"永不再情绪波动"，而是"发作越来越少、越来越轻、你恢复得越来越快、能正常生活"。本页帮你建立现实的时间感和评价标准，避免因为"没立刻好"而放弃，或因为"刚好一点"就自行停药。
> 本资料仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、先纠正一个最大的误解

【临床共识】治疗双相，目标**不是把情绪这种东西彻底消灭**——人本来就会高兴、会难过。我们要做的是：

- 把情绪的**摆幅压回正常范围**，不再"飘到天上"或"沉到谷底"；
- 把发作对**睡眠、工作、人际、钱财安全**的破坏降到最小；
- 让你重新获得"能正常生活、能对自己负责"的能力。

【个人体验】康复者常说："我还是会开心、会难过，但开心到想辞职创业、难受到不想活——那种极端，越来越少了。"这就是真实的、值得追求的目标。

二、治疗的三个阶段

阶段	大致目标	你需要知道的
急性期	控制当前这一次发作（躁狂/抑郁/混合），把极度兴奋或极度低落压下来，恢复基本安全和生活	通常需要数周；药要吃够、急性症状重时可能需住院
巩固期	防止这次发作刚好转就反弹，把刚稳定的状态巩固住	症状消失后**仍需继续治疗一段时间**——"感觉好了"不等于"病好了"
维持期/预防复发	降低未来再次发作的频率和强度	反复发作、有家族史者，维持治疗很重要；这一阶段你已掌握节律和预警工具

【临床共识】**过早自行停药，是双相复发最常见的人为原因之一。** 每复发一次，未来复发的风险就升高一截。

三、现实的康复曲线：进两步，退一步

【临床共识】康复几乎从来不是一条向上的直线，而是**整体波动、长期看摆幅越来越小**：

- 可能这两个月很稳，下个月因为熬夜加班、换季、生活大变动又糟糕一点；
- 可能一次小的应激就让情绪摆一下；
- 但拉长时间看（数月到数年）：发作的**频率在下降、强度在下降、你从发作里恢复得越来越快。**

【个人体验】"退一步"不等于前功尽弃。判断有没有进步，不要看某一天的状态，而要看**这一年比上一年**：发作是不是少了？是不是没以前那么极端了？是不是能更早察觉、更早找医生了？

四、怎么判断"到底有没有效"

【临床共识】疗效不能只凭"感觉"，要看两个维度：

1. **症状维度**：医生会用标准化工具（如 YMRS 评躁狂、PHQ-9 评抑郁）定期评估。**这些工具只是随访监测，不能单独用来确诊或断药**——作用是让变化可量化。
2. **功能维度**（更重要）：
   - 我还能不能正常上班/上学、完成基本事务？
   - 我睡觉是不是规律、稳定？
   - 我有没有再出现冲动消费、鲁莽决策？
   - 我和家人的关系怎么样？情绪是不是没那么极端了？

很多人躁狂分数降下来了，但作息还乱、药还在漏服、家里还在冲突——说明还没到收尾的时候。

五、给你的时间预期轴（大致，个体差异大）

时间点	大致可以期待的变化
治疗第1个月	可能还在适应药物、或急性症状刚开始被控制；睡眠、激越可能先松动。**这一阶段最容易因"没感觉/副作用"而放弃，请坚持复诊。**
治疗第3个月	多数人能看到摆幅明显变小：不再大起大落、作息开始稳定、冲动行为减少。心理治疗和节律管理开始见效。
治疗第6个月及以后	进入巩固/维持，重点转向"不反弹"和"长期自我管理"：你已经能认出自己的复发预警信号、知道怎么稳住睡眠、知道什么时候该找医生。

【争议观点】有人追求"半年彻底断根、一辈子不发作"，这不现实；也有人觉得"反正会反复，治了也白治"，这也不对。**规范治疗能显著降低发作频率和强度，让你过上接近正常的生活——这才是可达成的现实目标。**

六、最常见的四个治疗误区

误区	为什么错	正确做法
"吃了一两周没效就停药/加药"	心境稳定剂需数周才能评估；太早或自己加量可能中毒、打乱方案	给足评估时间，复诊听医生判断
"状态一好就自己停药"	巩固/维持期就是用来防复发的；自行停药复发风险高、复发更猛	在医生指导下缓慢、有计划减量
"只靠药，不管作息和心理"	熬夜、家庭冲突、漏服是转躁诱因；药降摆幅，自我管理防复发	药物 + 节律/心理治疗联合
"坚决不吃药，光靠冥想想开点"	中重度、反复发作时硬扛会错过干预期，急性发作时尤其危险	中重度建议药物为主，听医生权衡

七、治疗旅程：患者可以做的配合

1. **规律吃药、不擅自加减停**——这是你能做的最重要的一件事；

2. **稳定作息**：固定起床/睡觉时间，不熬夜、不睡懒觉、不乱倒时差（详见《模块7》）；
3. **记情绪与睡眠日记**：一两句即可，复诊时比"感觉好一点"有用得多；
4. **认出自己的复发预警信号**：比如"我开始睡得少还特别精神、开始乱花钱"——一出现就提前找医生，别等发作成型；
5. **控制冲动**：躁狂期大额消费、投资、高危行为，提前和家人商量好"财务保护"安排（见《模块9》）；
6. **按约定复诊、按医嘱化验**（尤其用锂盐者）；
7. **管理酒精和物质**：不借酒、不乱用兴奋剂。

八、什么时候要主动联系医生/复诊

- 按约定时间复诊（启动期更密，稳定后拉长间隔）；
- 出现《药物治疗》一页列的危险信号（锂中毒、5-羟色胺综合征、皮疹发热等）；
- 又出现熟悉的发作苗头（异常亢奋或持续低落）；
- 你在认真考虑自行减药/停药——**先约医生，不要自己先动手。**

> **一句话总结**：双相是可治疗、可康复、可长期管理的，但它需要时间、需要组合、需要你参与。把目标设成"摆幅越来越小、生活越来越稳"，而不是"立刻彻底根治"，你会走得更稳。配合《模块7》的自我调节工具，会让这段路好走很多。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (CG185)*（治疗阶段、随访与复发预防）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- CANMAT/ISBD 双相障碍管理指南（治疗目标与维持治疗）。
- APA：*Practice Guideline for the Treatment of Patients with Bipolar Disorder*.
- 《双相障碍防治指南》，中华医学会精神医学分会。
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental disorders / bipolar disorders* 相关科普。https://www.who.int

模块 7

自我调节与日常康复实操

1. 急性躁狂与轻躁狂期应对方法

> **先摆正位置：躁狂/轻躁狂发作时，自我调节只能起"缓冲"作用，不能替代药物和就医。** 而且躁狂期有一个很特别的麻烦——**自知力会下降**：你往往不觉得自己病了，反而觉得"我现在状态特别好、脑子特别快"。所以这一页的真正主角，很多时候是你身边的家人。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、先搞清楚：躁狂期"自我感觉良好"恰恰是病

【临床共识】双相障碍最容易被耽误的一段，就是轻躁狂/躁狂早期。它不像抑郁那样痛苦、让人想求助，反而让人觉得：

- "我最近状态太好了，效率特别高！"
- "我怎么睡三四个小时就够了，白天还精力爆棚？"
- "我突然想通了很多事，我要干一番大事业。"
- "我话特别多，跟谁都能聊，人缘怎么这么好。"

【个人体验】很多康复者事后回忆："那时候我真的觉得自己好了、甚至比没病的时候还强，是家人硬拉我去医院的。"——**"我觉得我特别正常、特别行"，这句话本身就需要警惕。**

所以这一页有两条核心原则：

1. **你自己要学会"半信半疑"地对待这种"好状态"**——哪怕你感觉棒极了，只要它和平时不一样、和医生说过的早期信号对上了，就要警觉。
2. **提前和信任的家人约定："如果你觉得我不对了，哪怕我反对，也要陪我联系医生。"** 这不是被控制，是你在清醒时为未来那个"不清醒的自己"预留的安全网。

二、躁狂/轻躁狂期，最该立刻踩刹车的几件事

【临床共识】躁狂发作期间，大脑的"刹车系统"（前额叶的抑制功能）明显变弱，冲动会在几秒内变成无法挽回的后果。以下这些事，**在你自觉"状态很好"的时候，就要提前给自己立规矩**，而不是等真发作了才想起：

领域	高风险行为	为什么危险	提前的保护安排
金钱	大额消费、盲目投资、网贷、给人转账、跟风创业	轻躁狂期挥霍是最常见、后果最持久的损害之一，可能几年都还不清	提前把大额支付权限交给家人保管；信用卡/网贷APP设置限额或暂时关闭；超过一定金额的支出"过夜再决定"
决策	冲动辞职、离婚、闪婚、签合同、做重大人生决定	躁狂期做的决定，事后九成会后悔	和自己约定："任何重大决定，至少推迟72小时，并和信任的人商量"

领域	高风险行为	为什么危险	提前的保护安排
人际关系	与人争执、到处提意见、过度社交、冲动表白/绝交	易激惹会把小摩擦升级成大冲突	感觉自己"话多、容易烦"时，主动减少社交和争论
性行为	高危性行为、一夜情、轻率开始/结束关系	后果包括意外怀孕、性病、情感创伤	提前给自己定底线；发作期尽量避免独自饮酒、深夜赴约
物质	咖啡、能量饮料、酒精、尼古丁，甚至自行加药	这些会进一步剥夺睡眠、加重兴奋、诱发更重的躁狂或快速循环	发作期一律不碰；药必须按医嘱，绝不能因为"我觉得还不够劲"自己加
作息	通宵工作、打游戏、追剧、聚会	**睡眠剥夺是转躁最常见的诱因之一**，也是把轻躁狂推向躁狂的推手	不管多有精力，到点上床，哪怕躺着不睡

> **核心口诀：状态越好、越想干大事的时候，越要慢下来、越不要做决定。**

三、"当下照做清单"：感觉开始不对时，今天就做这些

下面这张清单，建议你在状态好的时候就存在手机里。一旦发现自己开始出现早期信号（详见《5. 复发预警信号》），照做：

☐ 1. 立刻给信任的家人/朋友发消息："我最近可能有点飘，麻烦你留意我，如果我突然乱花钱/做决定，帮我拦住。"
☐ 2. 主动降低刺激：关掉工作群消息提醒、取消非必要的聚会和承诺。
☐ 3. 不要和人争论——感觉自己"道理一大堆、压不住火"时，立刻离开现场，去散步或独处。
☐ 4. 所有大额支出、投资、转账、签合同——全部推迟到72小时以后，并和一个你信任的人商量。
☐ 5. 咖啡因、酒精、能量饮料——今天起停掉。
☐ 6. 今晚无论多有精力，按平时的时间上床，关灯躺着；睡不着也不要起来刷手机。
☐ 7. 按医嘱服药，一顿都不漏；不要自行加药、停药。
☐ 8. 今天就给医生/医院发消息或打电话，预约提前复诊——不要等"更严重了"才去。
☐ 9. 如果已经连续几天睡得很少却依然精力旺盛、话多、觉得自己特别行——今天就要联系医生，不要拖。

四、为什么这些技巧"压不住"真正的躁狂

【临床共识】需要非常诚实地说清楚一件事：

- 轻躁狂早期，上面这些"减速、保睡眠、少做决定"的做法，**确实可以帮你争取时间、减少损失**；

- 但如果已经进入**明确的躁狂发作**（持续≥1周、明显影响工作社交、出现夸大妄想、整夜不眠、行为失控），**自我调节是无法把它"压回去"的。**这时候需要的是精神科医生调整治疗（通常是心境稳定剂/抗精神病药方案），必要时短期住院。

【个人体验】很多人在躁狂期最抗拒的就是"去医院"，因为自觉太好。这时候家人的作用就无比关键——**由家人带着、把药吃上、睡好觉、几天到几周后，那个"上头"的状态会慢慢退下去。**回头看，你会感谢当时那个坚持带你去医院的人。

五、给家人/陪伴者的提示

如果你是陪在患者身边的人，请记住：

- **不要和躁狂期的他争论"你是不是有病"**——他此刻的自知力是下降的，争论只会激化易激惹。
- **平静、简短、直接**地说事实："你已经连续三天只睡两三个小时了，我们去医院看一下吧。"用具体事实（睡眠、花钱、行为），而不是评判。
- **保护好财务和重要物品**：发作期患者容易挥霍、转账、签文件，家人应提前掌握银行卡、证件、手机支付的备用权限。
- **如果他出现激越、伤人毁物、幻觉妄想、完全不眠不食**，不要独自硬扛，按《模块8》的危险信号处理，必要时拨打 120/110 送精神科急诊。
- 不要说"你就是想太多""你控制点不就行了"——躁狂不是"想开点"能解决的。

六、几个常见误区

误区	事实
"我睡很少还特别精神，说明我身体好/好了。"	【临床共识】**"睡眠需要减少"是躁狂的核心症状之一**，不是好事；它往往是发作开始的信号。
"我现在思路清晰、效率高，趁状态好多做点事。"	这种"高效"常常伴随冲动、虎头蛇尾和人际关系代价；重大工作项目最好放在稳定期推进。
"我觉得药没用，是我自己调整好的。"	停药/漏服后复发风险显著升高；哪怕状态好，维持期用药和复诊也不能自作主张停。
"喝点酒能让我冷静下来睡觉。"	酒精会破坏睡眠结构、加重情绪不稳，还可能和药物相互作用，发作期严禁。

> **最后提醒**：躁狂期最危险的不是"你难受"，而是"你觉得一点都不难受"。所以这一页的核心不是教你"怎么靠自己扛过去"，而是教你**提前布好安全网（家人、财务保护、72小时决定延迟、规律睡眠、按时服药、尽早联系医生）**，让那个"上头"的你少闯祸、早就诊。

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders

- NICE（英国国家卫生与临床优化研究所）：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大多学科双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：双相障碍急性躁狂期管理与复发预防原则。
- 美国精神病学协会（APA）：*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Bipolar and Related Disorders 章节。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

2. 情绪与睡眠监测

> **双相障碍的管理，从"看不见"变成"看得见"开始。** 情绪和睡眠不是凭感觉猜的，而是可以像记体温一样记下来的。坚持记几周，你会第一次看清自己的"过山车"长什么样，也能在转躁/转抑郁的最早期就抓到信号。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、为什么双相患者必须记"情绪日记"

【临床共识】双相障碍的特点是情绪在**两个方向**上摆动：躁狂/轻躁狂一端，抑郁一端，甚至混合。单靠"我今天心情不好"这种模糊感觉，你很难分辨自己是在"正常波动"还是"开始转相"。而医生在门诊只有十几分钟，他需要你提供过去几周的客观记录，才能判断：

- 你现在处于哪个相？
- 睡眠变化是不是转躁的早期信号？
- 药物起效了吗？副作用是什么？
- 复发苗头出现在哪一天？

【个人体验】很多康复者说："记日记之前，我觉得自己情绪是随机乱变的；记了一个月才发现——原来每次'睡少了'之后三四天，我就开始话多、乱花钱。"**规律一旦被看见，你就不再被它牵着走。**

二、最核心的一个信号：不是"失眠"，是"睡眠需要减少"

【临床共识】双相有一个和普通失眠完全不同、却最容易被误读的信号：

> **"我明明只睡了三四个小时，白天却一点都不困、精力反而很旺。"**

这叫**"睡眠需要减少"（decreased need for sleep）**，它是躁狂/轻躁狂发作的核心症状之一，和"想睡睡不着"的普通失眠完全两回事：

	普通失眠	双相的"睡眠需要减少"
主观感受	痛苦、想睡睡不了	**不困、甚至觉得"少睡反而更精神"**
白天状态	疲惫、难受	精力旺盛、话多、脑子转得快
常见意义	焦虑、睡眠障碍	**转躁的早期信号，要高度警惕**

【临床共识】所以你记睡眠的时候，**不能只记"睡了几小时"，还要记"白天精力够不够、困不困"**。连续几天"睡得少 + 不困 + 精力旺"，是必须尽快联系医生的信号。

三、可抄写模板一：每日情绪睡眠记录表

建议用手机备忘录、Excel 或笔记本，每天晚上花 2 分钟填一行。**关键是坚持，不是完美。**

日期	上床时间	起床时间	实际睡眠时长	夜醒次数	白天困不困(0-10)	情绪打分(-5~+5)	精力打分(-5~+5)	话多不多	今天主要事件/诱因	服药是否按时	备注
例 10/20	23:30	7:00	7.5h	0	3	+1	+1	一般	上班正常，下午和同事小争执	✅	平稳
例 10/21	1:00	5:30	4.5h	0	0(不困!)	+3	+4	话多	加班赶项目，喝了两杯咖啡	✅	⚠️睡得少却很精神

打分说明（自己定一个固定标准，别每天换）：

- **情绪打分 -5 ~ +5**：-5 = 极度抑郁/绝望，0 = 平稳，+5 = 极度高涨/易激惹；
- **精力打分 -5 ~ +5**：-5 = 连床都起不来，0 = 正常，+5 = 精力爆棚、停不下来；
- **白天困意 0~10**：0 = 完全不困，10 = 困得睁不开眼。

> 【个人体验】建议在日历上把每天的分数点连成线。你会亲眼看到那条曲线是怎么慢慢往上飘（转躁）或往下掉（转抑郁）的——**视觉化的趋势，比任何感觉都诚实。**

四、可抄写模板二：情绪发作自查表

当你感觉"今天好像不太对劲"，花 1 分钟自查，对照下面两组信号打勾：

🟠 往躁狂/轻躁狂方向飘

- [ ] 最近睡得比平时明显少，白天却不困、精力更旺
- [ ] 话变多、语速变快，别人插不上嘴
- [ ] 脑子转得特别快，一个念头接一个念头，停不下来
- [ ] 容易烦躁、没耐心，一点小事就想发火
- [ ] 想买东西、想投资、想花钱的冲动变强
- [ ] 觉得自己特别行、特别有本事、有很多计划要做
- [ ] 注意力很容易被新鲜事吸引，一件事做一半就换下一件
- [ ] 社交变多、深夜还在约人、不想睡觉

🔵 往抑郁方向掉

- [ ] 对以前喜欢的事提不起兴趣
- [ ] 早上醒得特别早，醒了就再也睡不着
- [ ] 整天乏力、动一下都觉得累
- [ ] 不想说话、不想见人、想躲起来

- [ ] 出现消极念头："没意思""是个负担""不想撑了"
- [ ] 吃饭明显变少或变多，体重短期内波动
- [ ] 注意力没法集中，脑子像灌了浆糊

> **打勾越多、持续越久，越要早点联系医生。** 哪怕只中两三条，也别等。

五、可抄写模板三：睡眠记录表（更细的版本）

如果你正在被睡眠问题困扰，可以用这张更细的表记两周：

日期	上床时间	试图入睡用时	夜醒次数/时长	起床时间	总睡眠时长	午睡(时长)	咖啡/酒精	白天精力

【临床共识】双相患者尤其要警惕：**连续几天睡眠被压缩（熬夜、加班、倒时差、节假日狂欢），是诱发躁狂/快速循环最常见的扳机之一。** 记睡眠记录的意义，就是在"睡得少却不困"刚出现的头几天就抓住它。

六、怎么把记录坚持下来

【个人体验】记日记最容易失败的原因，是"记太复杂、三天就放弃"。几个实用技巧：

- **固定时间记**：把它绑在一个每天必做的动作上，比如"刷完牙躺床上就填一行"。
- **只要一行，不要小作文**：手机备忘录一行 5 个数字就够。
- **允许断更**：漏记两三天没关系，接着记就行，不要有"打卡羞耻"。
- **每周回看一次**：周末花 5 分钟看一眼这一周的曲线，你自己就能发现规律。
- **复诊时带给医生看**：这是你门诊时最有价值的东西，比"我感觉好点了"有用十倍。

七、关于自评量表：只能筛查，不能确诊

【临床共识】门诊和科普里常用几个量表辅助你和医生了解状态，**注意：它们只是筛查工具，不能用来自我诊断或自行调药**：

量表	用途	提醒
MDQ 心境障碍问卷	筛查你有没有"轻躁狂/躁狂史"，帮助区分单相抑郁和双相	阳性不等于确诊，需医生面诊
HCL-32 轻躁狂症状清单	自查近几天有没有轻躁狂倾向	同上
PHQ-9	评估抑郁症状严重程度	分数变化可给医生参考
YMRS 杨氏躁狂量表	由医生/专业人员评定躁狂严重程度	不建议自己打分自己下结论

> 量表打出来只是个"提示"，真正的判断永远是医生结合你的病史、病程、社会功能后做出的。

> **最后提醒**：情绪和睡眠监测不是为了把自己变成病人，而是为了把"复发"这种大事，拆成"这几天睡少了、话多了"这些你能亲手干预的小事。早看见几天，就能少闯很多祸。

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大多学科双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：心境监测、睡眠规律与复发预防的推荐。
- DSM-5（APA）：双相障碍诊断标准中"睡眠需要减少"作为躁狂发作症状之一。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

3. 人际社会节律与规律作息

> **对双相障碍来说，"规律"本身就是一种治疗。** 这一页讲的是国际上专门为双相发展出来的一种心理治疗思路——人际与社会节律治疗（IPSRT）：不靠意志力硬扛情绪，而是通过把每天的生活节奏固定下来，稳住那个容易"晃荡"的生物钟。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、为什么"作息乱"对双相患者特别危险

【临床共识】普通人熬个夜、倒个时差，顶多难受两天；但对双相患者，作息紊乱可能直接成为**转躁或转抑郁的扳机**。原因是双相患者的生物节律（睡眠-觉醒、体温、激素分泌）本身就比普通人脆弱，而：

- **熬夜、通宵、倒时差、节假日狂欢** → 睡眠被剥夺 → 容易诱发躁狂/轻躁狂；
- **连续几天躺床、不见人、三餐不定** → 社会节律被打乱 → 容易滑向抑郁；
- **人际冲突、关系破裂** → 情绪应激 + 节律打乱 → 双重打击。

【研究结论】IPSRT（Interpersonal and Social Rhythm Therapy）正是针对这一点设计的：研究显示，在药物治疗基础上加入节律管理，能显著降低双相障碍的复发率。它的核心不是"教你怎么开心"，而是"教你怎么把日子过得有节奏"。

二、什么是"社会节律"：不止是睡觉

很多人以为规律作息就是"几点睡几点起"。IPSRT 的关键在于：**一天中那些固定发生的"社会事件"，一起在给生物钟上发条。**

比如：

- 起床时间
- 第一顿饭的时间
- 开始工作/学习的时间
- 午休/社交的时间
- 服药时间
- 晚饭时间
- 睡前放松、上床时间

【个人体验】你会发现，真正把生物钟稳住的，往往不是"几点睡"，而是"**几点起、几点吃第一顿饭、几点开始一天的事**"。哪怕你前一晚晚睡了，只要第二天同一时间起、同一时间吃早饭，节律就不会崩。

三、可打印模板：每日社会节律表

建议给自己定一张"基准时间表"，在状态好的时候定下来，然后尽量每天照这个节奏走：

时段	固定事项	我的时间（自己填）
起床	固定时间起床、拉开窗帘见自然光	例：7:00
早餐	起床后1小时内吃第一顿饭	例：7:30
服药	固定时间服药（和吃饭/起床绑定）	例：7:30
开始一天	出门/开始工作学习	例：8:30
午餐	固定时间午饭	例：12:00
下午活动	出门走动/轻度运动	例：17:30散步20分钟
晚餐	固定时间晚饭	例：18:30
减速	睡前1小时放下手机、调暗灯光	例：22:30
上床	固定时间上床（哪怕睡不着也躺着）	例：23:00

> **核心原则：起床时间比入睡时间更重要。** 每天同一时间起来，周末也不要差太多（上下浮动最好别超过1小时）。

四、特殊场景：节律被打乱时怎么保护自己

【临床共识】以下场景是双相患者复发的高发时刻，提前知道、提前保护：

场景	风险	保护做法
熬夜加班/赶项目	睡眠剥夺诱发转躁	设"无论多忙都要睡几小时"的底线；连续熬夜超过2天就要警觉、联系医生
旅行/倒时差	节律骤变	到达后按当地时间尽快安排第一次进食和起床；带够药
节假日、春节聚会	晚睡、喝酒、见人多、兴奋	假期里也尽量守住起床和服药时间；酒精能不喝就不喝
换工作/搬家/开学	生活节奏大改	新环境里先把"起床—早饭—服药"这三件事固定下来，其他慢慢适应
失恋、家人冲突、失业	情绪应激 + 节律紊乱	情绪越乱，越要死死守住吃饭、睡觉、服药这三件小事
失眠一晚	不要第二天补觉补到中午	照常时间起床，白天可以短午睡（20–30分钟），不要长时间躺床

【个人体验】很多康复者的经验是：**遇到情绪大波动，不指望立刻"想通"，先把三顿饭吃了、药吃了、觉睡了。** 节律稳了，情绪往往会跟着稳一点。

五、人际部分：关系也是节律的一部分

IPSRT 的另一半是"人际"——因为双相患者的情绪波动常常和人际关系事件纠缠在一起：

- **和重要他人反复冲突** → 情绪剧烈波动 → 睡眠紊乱 → 发作；

- **社会隔离**（谁也不见、门也不出）→ 节律崩塌 → 抑郁加重；
- **过度社交**（躁狂期到处赴约、深夜长谈）→ 睡眠被掏空 → 转躁加重。

可操作的做法：

- **维持最低剂量的社交**：哪怕状态不好，每天至少和一个人说几句话（家人、邻居、网友都行）；完全断联是抑郁的温床。
- **重要关系里提前"交底"**：和伴侣/家人约定，当你状态不对时，怎么沟通、谁来提醒你睡觉、谁帮你拦住大额消费（见《模块9》）。
- **学会给社交"设边界"**：状态不好时不必勉强自己应酬，但也不要彻底消失；一句"我这阵子状态一般，晚点再约"就够。
- **重大关系决定，等稳定期再做**：分手、结婚、辞职、搬家这类大事，不在情绪波动期拍板。

六、每周节律自检表

每周日花 2 分钟打勾，看看这周节律稳不稳：

项目	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
起床时间偏差<1小时							
三顿饭基本按时							
按医嘱服药（不漏服）							
有出门/活动							
上床时间偏差<1小时							
当天没喝酒/没大量咖啡							
至少联系一个人							

> 【个人体验】不要求七天全做到。**做到五六天，这周就算稳住了。** 双相的管理是"平均数游戏"，不是"完美打卡"。

七、几个常见问题

- **问：周末睡懒觉也不行吗？**
  答：【临床共识】偶尔晚起一两个小时问题不大，但长期周末和工作日差三四个小时，等于每周"迷你倒时差"，对节律敏感的人会有影响。尽量把浮动控制在1小时内。
- **问：我失眠了，第二天可以白天多睡补回来吗？**
  答：不建议长时间补觉。白天可短午睡20–30分钟，下午3点后不要再睡；坚持按时起床，当晚的生物钟会自己回来。
- **问：规律作息这么无聊，能坚持吗？**
  答：【个人体验】一开始确实会觉得"像老年人生活"。但坚持几周后你会发现：情绪的"过山车"幅度真的变小了。**对双相来说，"无聊"恰恰是稳定的同义词。**

> **最后提醒**：IPSRT 是心理治疗的一种，最好在有经验的心理治疗师指导下学习，但它的核心思想——**固定起床、吃饭、服药、社交、睡觉的时间**——你今天就可以开始用。规律不是束缚，是给那个容易晃荡的自己，搭一个不会塌的底座。

参考来源

- Frank E, et al. *Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT)*：针对双相障碍的节律心理治疗经典文献。
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大多学科双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：心理治疗与社会节律干预推荐。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

4. 长期自我管理

> **双相障碍是一场"马拉松"，不是几次急性发作就结束了。** 长期管理做得好的人，往往不是靠某次神药，而是靠把"规律服药、规律作息、管住物质、盯紧信号、安排好后路"这几件平淡的事，日复一日地做下去。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、治疗的"基本功"：规律服药与随访，永远排第一

【临床共识】这是双相长期管理中最重要、也最容易被忽视的一条：

- **双相障碍是高复发性疾病**，发作间期即使感觉"完全好了"，大脑的易感性依然存在；
- **维持期坚持服药、定期复诊，是目前证据最充分的防复发手段**；
- 很多复发不是因为药不好，而是因为**感觉好了就自行减药、停药、漏服。**

> 【个人体验】很多康复者都有过这个阶段："我都好几个月没发作了，是不是可以停药了？"——这个念头很正常，但**要不要停、怎么停，必须由医生根据你的病程、稳定时长、复发风险来决定**。自行停药后短期内复发率显著升高，而且再次治疗往往更费劲。

长期用药上要记住的几件事：

- 药要**规律吃，不漏服**；偶尔漏服怎么办，提前问清楚医生，不要自己加倍补。
- 用**锂盐**的患者，需要按医嘱定期复查血药浓度、肾功能、甲状腺——这不是走形式，是保证安全和疗效。
- **育龄女性**用丙戊酸钠/卡马西平等药物时，必须知道其致畸风险、做好避孕规划，备孕一定要提前和医生商量。
- 出现新的明显副作用（皮疹、持续手抖、严重头晕、发胖等），不要硬扛也不要自己停药，记录下来复诊时告诉医生。

二、运动：被低估的"情绪稳定剂"

【研究结论】规律有氧运动对双相障碍有明确的辅助作用：改善情绪、改善睡眠、减轻焦虑和易怒，长期坚持有助于降低复发风险。

- **怎么做**：循序渐进，目标每周累计约150分钟中等强度有氧（快走、慢跑、骑车、游泳），分多次完成；
- **从最小目标开始**："今天下楼走10分钟"就值得肯定；
- **注意**：躁狂期本身精力过剩，不必再加量高强度训练；抑郁期动不起来时，"穿上鞋出门站一站"也算数；
- 有躯体疾病或正在服药者，开始新运动计划前先问医生。

三、饮食、体重与代谢

第二代抗精神病药、心境稳定剂常伴随食欲增加、体重上升、血糖血脂变化，长期管理不能不管：

- **规律三餐、少高糖饮料和精制零食**，稳住血糖本身就有助于情绪平稳；
- **定期测体重、腰围**，按医嘱定期复查血糖、血脂、肝功能；
- 不要盲目节食减肥——和医生一起制定方案；
- 没有任何单一食物/保健品能"治好双相"，补剂不能替代药物。

四、咖啡因、酒精、物质：三个复发推手

物质	对双相的影响	建议
咖啡因（咖啡、浓茶、能量饮料、可乐）	刺激神经系统、影响睡眠，可能诱发兴奋、失眠	【临床共识】发作期及易转躁者建议明显减少，下午以后不喝
酒精	短期放松，破坏睡眠结构、加重情绪波动，与药物叠加抑制中枢，且常被用来"助眠/解压"形成依赖	不应用酒精调节情绪；服药期间尤其避免
尼古丁/其他物质	干扰睡眠和药效，使用违禁物质会显著增加发作和冲动风险	戒烟/戒物质对整体康复是净收益，可请医生帮助

【个人体验】很多人的某次躁狂发作，回溯起来是从"连续熬夜 + 大量咖啡/酒"开始的。记几个月日记后，你会看到自己的扳机长什么样。

五、压力管理：不是消灭压力，是学会不被它点着

双相患者对压力的耐受力更脆，同样的事别人扛得住，你可能就被点着了。所以要主动给生活"减负"：

- **任务拆小**：不要想"做完整个项目"，只想"现在打开文档写第一句"。
- **学会说不**：过度承诺→压力爆炸→节律乱→发作。温和而清楚地拒绝，是在保护治疗。
- **信息节食**：睡前少刷手机、少被群消息追着跑。
- **每天留一段"放空时间"**：散步、洗澡、听音乐、撸猫——不做任何"有用"的事。
- **重大生活事件提前打招呼**：结婚、换工作、搬家、亲人离世前后，主动提前联系医生，很多时候预防性的随访就能拦住一次发作。

六、财务与关系：提前布好"防躁狂期冲动"的后路

【临床共识】躁狂期的冲动消费、盲目投资、鲁莽决定，是双相患者长期社会功能受损的重要原因。清醒时就该把保护安排好：

- **财务保护**：把大额支付权限、信用卡、网贷APP限额提前交给信任的家人；约定"超过X元的支出必须商量、过夜再决定"。
- **关系保护**：和伴侣/家人约定"早期信号暗号"——当你说出某句话、或出现某些行为时，他们有权提醒你就医。
- **法律文件**：稳定期可以提前和信任的人讨论医疗委托、重要证件保管，避免发作期做出无法挽回的决定。

- **备份病历**：病历、用药记录、检查结果拍照存云盘；换城市、换医生时用得上。

七、每周自检清单（可打印）

每周日晚上花3分钟，给自己这周打个勾：

☐ 1. 这周有没有漏服药？（0次最好）
☐ 2. 这周睡眠规律吗？（起床时间偏差大吗？）
☐ 3. 有没有连续熬夜/喝酒/大量咖啡？
☐ 4. 这周出门活动/运动了吗？
☐ 5. 有没有出现《复发预警信号》里的信号？
☐ 6. 有没有冲动消费/冲动做决定？
☐ 7. 这周至少和人正常联系了几次？
☐ 8. 情绪日记记了几天？
☐ 9. 距离下次复诊，药还够不够吃？
☐ 10. 有没有需要提前联系医生的情况？

> 【个人体验】这张表的意义不是"打分考核自己"，而是让你在每周固定一次的时间，像医生一样客观地看自己一眼。**哪一项连续两周出问题，就主动联系医生，不要等它变成一次大发作。**

八、康复是一个"和疾病长期共处"的过程

- 双相障碍目前不能"断根"，但**规范治疗 + 良好自我管理下，绝大多数患者可以拥有充实的工作、亲密的关系和稳定的生活。**
- 不要因为一次复发就觉得"全完了"——复发是疾病的一部分，不是你失败了。关键是复发后更快地回到治疗轨道。
- 也不要追求"我要永远情绪没有波动"——正常人也会有起伏，目标是**把过山车的幅度控制在不伤人、不闯祸、能正常生活的范围里。**

> **最后提醒**：长期自我管理听起来都是" boring 的小事"——吃药、睡觉、走路、少喝咖啡、记日记。但正是这些小事，构成了双相患者最可靠的康复底座。真正的"高手"不是某次扛过了大发作，而是几百个平淡日子里，稳稳地把这些事做下来。

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大多学科双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：维持治疗、复发预防、生活方式干预推荐。
- 运动对双相障碍的辅助疗效：相关系统综述与Meta分析。

- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

5. 复发预警信号

> **双相复发最值钱的窗口，是发作刚冒头的那几天。** 这时候症状还轻、自知力还在、家人还能沟通，一个电话、一次提前复诊，往往就能把一次大发作拦下来。这一页教你识别自己的"早期信号"，并在第一时间联系医生和家人。本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

一、为什么"早期信号"对双相特别重要

【临床共识】双相障碍的发作很少是"突然一下就崩了"，大多有一个**几天到几周的渐进过程**：

- **转躁方向**：从"睡得少却不困"开始，几天内话越来越多、花钱越来越冲、觉得自己越来越行；
- **转抑郁方向**：从"提不起劲、不想见人"开始，慢慢滑向早醒、消极、回避。

如果你和家人能在这个阶段就识别出来、联系医生，很多时候只需要门诊调整一下治疗、睡好觉，就能避免一次住院。**这就是所谓的"早期间断"——在复发刚冒头时就介入。**

> 【个人体验】很多康复者回头看，才发现每次大发作前，自己其实早几天就"不对了"，只是当时没把它当回事。这一页就是帮你把这些"不对"提前列出来。

二、转躁/轻躁狂的早期信号

【临床共识】以下信号出现时，往往是"正在往上飘"，越早干预越好：

睡眠与精力

- [ ] **开始睡得比以前少，白天却不困、精力更旺**（这是最核心的早期信号）
- [ ] 早上醒得异常早，醒了再也躺不住
- [ ] 觉得"睡三四个小时就够了"，还为此得意

思维与言语

- [ ] 话变多、语速变快，别人插不上嘴
- [ ] 脑子里念头一个接一个，停不下来，计划越列越大
- [ ] 注意力特别容易被新鲜事带走，一件事做一半就换
- [ ] 觉得自己脑子特别快、特别聪明、想通了很多大事

情绪与行为

- [ ] 容易烦躁、没耐心，一点小事就想发火、想争论
- [ ] 购物、花钱、投资、刷礼物的冲动变强
- [ ] 社交突然变多，深夜还在约人、不想回家

- [ ] 开始觉得自己"特别行、要干一番大事业"，做重大决定（辞职、投资、闪婚闪离）
- [ ] 咖啡因、酒精喝得越来越多

> **以上信号只要连续几天出现两三条，就不要再观察了——今天就联系医生或家人。**

三、转抑郁的早期信号

【临床共识】以下信号出现时，往往是"正在往下掉"：

情绪与想法

- [ ] 对以前喜欢的事突然提不起兴趣
- [ ] 变得不想说话、不想见人、想一个人躲起来
- [ ] 脑子里开始出现消极的话："没意思""我是个负担""不想撑了"
- [ ] 自我评价变低，觉得自己什么都做不好

精力与身体

- [ ] 整天乏力，起床都费劲
- [ ] **早上醒得特别早，醒了就再也睡不着**（和转躁的早醒不一样，这里是伴随疲惫和绝望）
- [ ] 吃饭明显变少或变多，体重短时间波动
- [ ] 注意力没法集中，工作学习效率明显下降

行为

- [ ] 开始回避社交、推掉约定
- [ ] 个人卫生开始忽略
- [ ] 药物开始漏服、懒得复诊

> **只要"消极念头"开始反复出现，就不要等，立刻联系医生和信任的人——抑郁相和混合相的自杀风险，是双相管理中最需要警惕的事。**

四、混合状态：特别要警惕的一种"中间地带"

【临床共识】双相还有一种很凶险的情况叫**混合特征/混合发作**：同一时间里，躁狂和抑郁的症状缠在一起——

- 脑子里转得飞快、停不下来，却又觉得绝望、空虚；
- 精力很旺、坐不住，却又被强烈的无价值感和消极念头笼罩；
- 可能烦躁、易激惹，甚至出现伤害自己的冲动。

> **混合状态的自杀风险尤其高**——因为它既有抑郁的绝望，又有躁狂带来的冲动和行动力。一旦出现"又烦又绝望、脑子转得快却停不下来"的组合，不要拖，立即就医。

五、我的个人预警信号清单（模板）

每个人的早期信号都不一样。**请在你现在状态平稳的时候，花10分钟，凭自己历次发作的经验，把下面这张表填出来**，存在手机里，给信任的家人也存一份：

```
==============================
   我的双相预警信号清单
==============================
填写日期：_____

【我开始往上飘（转躁/轻躁狂）的信号】
1. _____
2. _____
3. _____
（例：连续2天只睡5小时却不困；
      开始想买大件；话特别多；
      觉得自己要创业……）

【我开始往下掉（转抑郁）的信号】
1. _____
2. _____
3. _____
（例：不想见人；早醒；
      反复说"没意思"……）

【我这次最可能的扳机（诱因）】
□ 熬夜/睡眠被打乱
□ 喝酒/大量咖啡
□ 人际冲突/失恋/家庭矛盾
□ 工作压力/换环境
□ 自行漏服/停药
□ 重大生活事件

【发现这些信号后，我要做的事】
第1步：联系信任的人：_____（电话：_____）
第2步：联系医生/医院：_____（电话：_____）
第3步：按医嘱服药，不漏服
第4步：今晚无论如何按时上床、保证睡眠
第5步：暂停一切大额支出和重大决定
==============================
```

六、发现信号后：怎么"早期间断"

【临床共识】识别出信号后，具体怎么做：

1. **不要硬扛、不要"再观察几天看看"**——越早期介入，代价越小。
2. **今天就联系医生**：打门诊电话/线上问诊，说明"我最近出现了XX信号，担心要复发"，很多医生会让你提前复诊。
3. **告诉一个信任的家人/朋友**：把上面那张"预警信号清单"给他看，说"如果我出现这些，麻烦你提醒我、陪我去医院"。
4. **立刻守住三件事**：按时服药、按时睡觉、不碰酒精咖啡。
5. **暂停一切重大决策和大额支出**（参考《1. 急性躁狂与轻躁狂期应对方法》）。
6. 如果已经出现消极念头、自伤冲动、激越失控，不要等门诊号——直接按《模块8》走急诊/热线。

七、给家人：怎么识别"他自己没意识到的早期信号"

患者早期往往自知力下降，这就需要家人做"第二双眼睛"：

- **观察睡眠**：他是不是最近睡得越来越少、却说自己特别精神？
- **观察花钱和行为**：有没有突然大手笔消费、做以前不会做的冲动决定？
- **观察情绪**：是不是变得特别话多、特别易激惹、特别"自信"？
- **不要争论"你是不是病了"**，用具体事实说："你已经连续好几天只睡三四小时了，我有点担心，我们去医生那里看看好不好。"
- **提前约定授权**：清醒时和患者说好——"如果你开始出现这些信号，哪怕我反对，你也帮我联系医生。"

> **最后提醒**：复发不是失败，它是这种病的常态。真正决定预后的，不是"你会不会复发"，而是"复发后你多快能被接住"。把这张预警清单填好、存好、给家人一份——你就是在给未来那个可能"上头"或"下坠"的自己，提前留好了一只伸过来的手。

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大多学科双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：复发早期识别、心理教育与个人行动计划推荐。
- DSM-5（APA）：混合特征、快速循环等双相谱系概念。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

模块 8

危机识别与求助资源

1. 需要紧急就医的危险信号

> **如果你此刻正被强烈的痛苦抓住，或身体出现从未有过的剧烈不适，请先看这一页最上面的求助方式——不必读完再行动。**
>
> 在中国大陆：**全国统一心理援助热线 12356**（24小时、免费）；医疗急救 **120**；报警 **110**。
> 本页只讲如何识别危险信号、如何求助、如何让自己和身边的人安全。**它不描述任何伤害自己的方法**——这一页唯一的目的，是帮你或你身边的人被接住。
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

〇、先记住最重要的两句话

1. **双相的危险在"两个方向"上都可能出现**——躁狂相的冲动闯祸，抑郁相/混合相的自伤自杀。任何一头失控，都需要紧急求助。
2. **求助不是给人添麻烦，是这个世界上最值得做的事。** 哪怕你觉得"我不值得被救"，这个念头本身就是疾病在说话，不要相信它。

一、先排除躯体急症：别把身体问题当成"情绪问题"硬扛

【临床共识】双相障碍患者在发作期可能连续不眠不食、大量饮酒、自行加药，这些都可能带来躯体急症。**首次出现以下情况，先打 120 或去急诊，不要硬归给"情绪"：**

红旗信号	为什么不能硬扛	该怎么做
首次出现的剧烈胸痛、胸闷、压迫感，尤其向左肩、左臂、下颌、后背放射，伴冷汗	需排除心脏急症	立即拨 120，静坐/半卧等待，不要自己开车
突然晕厥、意识不清、抽搐、说话含糊、肢体无力	需排除脑卒中、癫痫、药物严重不良反应	立即拨 120
高热（≥38.5℃）+ 肌肉僵硬 + 大汗 + 意识混乱，尤其在用药/换药后	警惕严重药物反应（如恶性综合征等），可能危及生命	立即拨 120/急诊，带上正在吃的所有药盒
连续多日完全无法入睡、无法进食饮水、身体明显衰竭脱水	脱水、电解质紊乱、免疫力崩溃	24 小时内就医，必要时急诊
误服/大量吞服药物、药物过量	药物中毒	立即拨 120，带上药盒，不要自行催吐

> 【临床共识】**首次剧烈胸痛、意识异常等，先排除躯体急症。** 宁可虚惊一场跑一趟急诊，也不要把真正的身体问题当成"又是情绪问题"扛过去。

二、躁狂/轻躁狂相的危险信号

【临床共识】躁狂期的危险不在于"你难受"，而在于**冲动在短时间内造成无法挽回的后果。**出现以下情况，需要紧急或尽快就医：

冲动与行为失控

- **大额挥霍、盲目投资、网贷、给陌生人转账**，一天能花掉数月薪水，拦都拦不住；
- **高危性行为**、轻率的关系决定，事后可能造成性病、意外怀孕、情感破裂；
- **激越、易激惹到和人冲突、动手、砸东西**，甚至有伤害他人的倾向；
- **完全不眠多日**（连续几天几乎不睡），却仍精力旺盛、不停忙碌，身体开始衰竭；
- **脱离现实**：出现夸大妄想（坚信自己有超能力、巨大财富、特殊使命）、幻觉、被跟踪感等精神病性症状；
- **肇事肇祸风险**：开危险的车、冲动辞职/离婚/签巨额合同、在公共场合做出失控行为。

> 【个人体验】躁狂期的人往往自己完全不觉得有问题，反而觉得"我状态好极了"。所以这时候**最关键的是身边人识别出来、协助就医**——必要时按法律程序送医。

三、抑郁相 / 混合相的危险信号：自伤自杀风险

【临床共识】双相的自杀风险，在**抑郁相和混合相**时尤其要高度警惕——尤其**混合状态**（既有躁狂的冲动行动力、又有抑郁的绝望），自杀风险是各相中最高的。

需要高度警惕的信号

- 反复说出或写出："活着没意思""不想撑了""没有希望了""我是个负担"；
- **开始安排后事**：把心爱的东西送人、写告别话、向人道别、整理重要事务；
- **长期低落之后，突然异常平静、"放下了"**——这往往不是真的好了，而是可能已经做出决定，非常危险；
- 开始囤积药物、打听"怎么结束"相关的事（出现准备行为）；
- 过去有过自杀尝试——这是最强的风险预测因素之一；
- 混合状态下：情绪烦躁绝望 + 脑子转得快、坐不住 + 出现自伤冲动。

> **只要出现主动的、具体的自伤/自杀念头或准备行为，不要等，立即按下面的分级行动。**

四、风险分级与对应行动

级别	典型表现	立刻要做的事
🔴 **一级：即刻危险**	已经/正在发生自伤行为；有具体自杀计划且可能立刻执行；躁狂期激越伤人、肇事肇祸；药物过量；胸痛晕厥等躯体急症	**立即拨打 120 / 110**；让身边人 24 小时不离；不要独处

级别	典型表现	立刻要做的事
🟠 **二级：24 小时内就医**	出现主动自伤念头但暂无计划；连续数日不眠不食、明显衰竭；躁狂期挥霍冲动已失控；伴幻觉妄想；怀疑药物严重不良反应	**24 小时内**到精神科急诊/门诊；联系主治医生；告诉信任的人不要让自己独处
🟡 **三级：尽快预约门诊**	出现复发早期信号（见《5. 复发预警信号》）、睡眠骤减、情绪波动加大、药物副作用明显、被动的"活着没意思"想法	**本周内**预约复诊；拨打 12356 先聊；不要自行调药

> **任何一级，只要你心里没底，都可以直接往上一级行动。** 宁可反应过度，不要追悔莫及。

五、环境安全：让危险变得不容易发生

【临床共识】当你或身边人处于危机中，一个重要的事是**在专业人员或信任的人协助下，降低"立刻能伤害到自己/他人"的机会**：

- 让信任的家人帮忙，把药物、利器、危险物品等**收管起来**（具体怎么整理听医生/专业人员的，不必自己研究细节）；
- 躁狂期把银行卡、手机支付、证件交给家人临时保管，防止冲动挥霍、转账；
- 不要让有风险的人独处——安排人陪伴；
- 不要饮酒、不要自行加药/停药。

> **这一页不提供任何伤害方法的细节，也不建议你自己研究"怎么防"。环境整理请交给专业人员和信任的家人。**

六、可以直接照抄的求助话术

发给家人 / 伴侣

> "我现在状态很差，（可能躁狂发作/出现了不想活的念头），我不想一个人扛了。能不能今天陪我去一趟急诊/医院？具体情况路上我说。"

发给朋友

> "有件事我认真地跟你说：我这几天很不对，（乱花钱/睡不着/不想活了），我现在需要你在我身边。你不用会劝我，陪着我、帮我联系医生就好。"

打 120 / 110 时

> "我（或我身边的人）现在 [连续几天不睡/有伤害自己的念头/行为失控伤人]，地址是 ____，请问我现在该怎么办？"

打 12356 时

> "我是双相障碍患者，现在（情绪很高很冲动/情绪很低不想活），我想求助，请问我现在该怎么办？"

七、身边的人：该做与不该做

✅ 该做	❌ 不该做
平静、直接地问："你是不是有过不想活的念头？有没有计划？"	回避不谈、假装没事
躁狂期不要争辩"你有病"，用具体事实："你已经三天没睡了，去医院吧"	说"你就是太飘了""至于吗"
陪着他，不让他独处；帮他管住银行卡、药物	让他一个人"静静"
帮他拨 120/110/12356、联系医生、去急诊	承诺"我替你保密"（安全比保密重要）
在专业人员指导下整理环境、收管危险物品	指责、羞辱、和他争吵激惹

> 你不需要"会心理辅导"。**在场、稳定、不评判、帮他联系人、该叫救护车时立刻叫**——就已经是极大的帮助。

> **最后，请记住：** 双相会在你状态差的时候骗你，说"没有希望了""你是个负担"；也会在你状态好得过头时骗你，说"你无所不能、现在就该干票大的"。这两种都是病的声音。真正的事实是——**这种病是可以治的，此刻的失控不会永远持续，只要你愿意打一个电话，就有人来接你。**
>
> 现在，如果你正需要：**12356（24小时）、120、110。**

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet* 与 *Suicide fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：急性发作管理与自杀风险识别。
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

2. 国内心理危机热线与求助渠道

> **不知道打给谁、不知道哪个渠道靠谱，是很多人在最难的时候卡住的原因。这一页把国内能用的求助渠道按"首选—补充—医院"整理好，存进手机备忘录，希望你永远用不上，但一定要有。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。
>
> **核实日期：2026-10-20。热线号码可能随时间调整，拨打前以当地官方公布为准。**

一、首选：全国统一心理援助热线 12356

【临床共识】**12356 是目前国内最优先、最该存的心理援助号码。**

项目	内容
号码	**12356**
服务时间	**24 小时**
费用	**免费**（按市话/套餐计费，无额外服务费）
开通时间	**2025 年 5 月 1 日起**全国统一使用
主办	国家卫生健康委员会统一部署，各地精神卫生中心/定点机构承接
能解决什么	情绪困扰倾诉、心理危机干预、就医指导、转介建议

> 号码里没有"4"，寓意"要爱我了"，是国家层面设计的暖心号码。
>
> 【核实依据】国家卫健委 2024 年底发文设置、2025 年 5 月起全国统一使用，各地原有心理援助热线逐步并入。

双相患者什么时候打 12356：

- 你开始出现转躁/转抑郁的早期信号，拿不准要不要去医院；
- 你出现了"活着没意思""不想撑了"之类的念头，想先聊一聊评估风险；
- 躁狂期冲动得控制不住，想找人帮你"踩一脚刹车"、提醒你联系医生；
- 你是家属，看到患者状态不对、不知道怎么劝他就医。

> 你不需要"够严重"才配打这个电话。任何让你不安的状态，都值得一个电话。

二、紧急：医疗急救 120、报警 110

渠道	号码	什么时候用
医疗急救	**120**	胸痛、晕厥、呼吸困难、药物过量、自伤行为发生、连续不眠不食衰竭、意识不清
报警	**110**	躁狂期激越伤人、毁物、肇事肇祸，现场有现实人身安全威胁、需要警力到场

打 120 时，调度员通常会问：地址、发生了什么、患者现在的状态、年龄性别、既往病史、正在吃什么药。**照实说就好，不要因为"不确定是不是小题大做"而不打。**

三、对口机构：当地精神卫生中心 / 精神专科医院急诊

双相急性发作最对口的线下去处，是**当地精神卫生中心（或精神专科医院）的急诊/门诊**，以及开设精神科的三甲综合医院。

怎么找：
1. 打开手机地图（高德/百度/腾讯地图），搜索"**精神卫生中心**""**精神科急诊**"；
2. 看导航里有没有标注"24 小时急诊"；
3. 去之前先打医院公开电话确认急诊是否开放；
4. 如果是躁狂发作、患者本人不愿去，家属可按当地精神卫生法规协助送医。

> 【个人体验】很多城市的精神卫生中心同时就是 12356 的本地承接单位，接线员判断你需要线下就诊时，会直接建议对口机构。

四、补充渠道：北京心理危机研究与干预中心热线

作为 12356 之外的补充，北京回龙观医院主办的这条热线已稳定运行二十余年：

项目	号码
手机 / IP 用户拨打	**010-82951332**
固定电话（座机）拨打	**800-810-1117**
服务时间	24 小时，一年 365 天
性质	公益、免费，设在北京回龙观医院

> 这条热线面向全国。**它不是 12356 的替代品，而是补充**——如果 12356 占线，可以拨这条试试。

五、打热线会发生什么：流程与保密原则

第一次打心理热线的人，常常紧张得不知道说什么。了解一下流程就不慌了：

1. **接通**：接线员自报家门，比如"您好，这里是 12356 心理援助热线"。
2. **倾听与评估**：你说，接线员听；他们会问几个简单问题——你现在在哪里、身边有没有人、最近睡得怎么样、有没有伤害自己的念头——用来判断风险。
3. **一起想办法**：根据状态，接线员会建议你：先做几次深呼吸、联系家人、马上去急诊、或转介到本地精神卫生资源。
4. **结束**：你可以随时挂电话；危机状态下，接线员可能多聊一会儿、确认你安全后再结束。

你可以说什么：
- 不用组织语言，想到哪说到哪；

- 可以哭、可以沉默、可以说"我也不知道怎么说"；
- 不必报真实姓名。

关于保密：
- 心理热线通常**遵守保密原则**，不会把你的话告诉单位、家人。
- **例外**：当接线员判断你（或身边人）有即刻生命危险时，会按规范联系紧急救援——这不是"告密"，是救命。

六、打热线时怎么说（话术模板）

不知道开口说什么时，照着说：

> "您好，我是双相障碍患者。我最近（连续几天睡得很少却特别精神/情绪很低落不想活/控制不住想乱花钱），我有点担心自己要发作了，请问我现在该怎么办？需要去急诊吗？"

如果你是替家人求助：

> "我家人是双相障碍患者，他最近（三天没睡、乱花钱、说不想活），我们劝不动他去医院，请问这种情况我该怎么办？可以直接送精神科急诊吗？"

七、如何判断一个渠道靠不靠谱

✅ 优先选	❌ 谨慎/避开
公立医院、政府卫生部门主办	个人自媒体、商业培训机构
有明确主办单位、地址、电话	只留微信号、"加老师咨询"
内容是科普、就医指导	内容是"七天根治双相""停药不复发"
不主动诱导你买课/买药	反复劝你买课、买产品、加付费群

> 网上大量"心理疏导""情感挽回"类商业热线，不是危机干预资源，真遇到危机优先打上面列的公立/公益号码。

八、紧急联系卡（可抄到手机备忘录 / 打印放钱包）

```
==============================
   双相情感障碍 • 紧急联系卡
==============================
本人姓名：_____________
主治医院/科室：_____________
主治医生/电话：_____________
正在使用药物（不要自行停）：
   _____________________
```

```
【24小时心理援助】12356
【医疗急救】          120
【公安】              110
【北京心理危机热线（手机）】010-82951332
【北京心理危机热线（座机）】800-810-1117

信任的人：
  姓名：_____ 电话：_____
  姓名：_____ 电话：_____

最近的有精神科急诊的医院：
  名称：_____
  地址：_____
  电话：_____

【我的早期信号：连续几天睡得少却不困/
  话多冲动花钱/不想活——
  出现这些立即联系医生，不要等。】
==============================
```

> 把这张卡**同时存在本人手机、信任的人手机里**。希望你永远用不上，但一定要有。

> **最后，请记住：** 一个人扛着的时候，很容易觉得"没人能帮我"。但这个国家从 2025 年起，专门为你留了一条 24 小时不收费的电话线——**12356**。拿起手机，你不需要准备好台词。

参考来源

- 国家卫生健康委员会：2025 年全国统一心理援助热线（12356）相关发布会与通知，http://www.nhc.gov.cn/
- 国家心理健康和精神卫生防治中心（原国家精神卫生项目办）：https://ncmhc.org.cn/
- 北京心理危机研究与干预中心（回龙观医院）：北京市心理援助热线介绍，https://www.crisis.org.cn/
- 世界卫生组织（WHO）：*Suicide fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 《中华人民共和国精神卫生法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）。

3. 复诊时机与住院时机

> **双相障碍治疗失败，很多时候不是药不对，而是"该复诊的时候没去、该住院的时候硬扛在家"。这一页讲清楚：什么时候该提前复诊、什么时候医生会建议住院、以及——住院不是惩罚，是保护。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。所有用药与剂量调整，请遵你的主治医生医嘱。

一、固定复诊节奏：跟着"稳不稳"走

【临床共识】双相障碍的复诊频率，越早期、越调整期看得越勤；越稳定，间隔越长。下面是常见节奏，**具体以你的医生安排为准**：

阶段	常见复诊间隔	这个阶段医生在看什么
急性发作期（刚住院/刚门诊启动治疗）	1–2 周一次	药物耐受、早期副作用、症状变化趋势
巩固期（发作刚控制住）	2–4 周一次	疗效是否稳固、副作用、社会功能恢复
维持期（长期稳定）	1–3 个月一次	维持疗效、预防复发、必要的化验监测
讨论减停期（连续稳定很久后）	4–8 周一次，逐步拉长	撤药复发风险、复发迹象

> 【个人体验】很多人觉得"我好得差不多了，就不去了"。恰恰相反——**维持期复诊是为了不让你重新掉回去**。对双相来说，一次复发的代价（住院、失业、挥霍、关系破裂），远比坚持复诊贵得多。

二、必须提前/临时联系医生的情况

以下情况**不要等到预约的复诊日**，应主动联系医生（门诊加号、线上问诊，必要时急诊）：

情况	为什么不能等
出现转躁早期信号：连续几天睡得少却不困、话变多、易烦、想花钱、觉得自己特别行	这是发作刚冒头的"黄金窗口"，早期干预常能拦住一次大发作
出现转抑郁早期信号：兴趣下降、早醒、不想见人、消极念头	抑郁相/混合相自杀风险升高，需尽早评估
睡眠骤减或作息明显紊乱：熬夜、倒时差、加班后连续失眠	睡眠剥夺是转躁最常见的扳机
出现新的明显副作用：皮疹、持续手抖、严重头晕、明显发胖、性功能受影响	可能需要调整方案，硬扛只会让你自行停药
情绪波动明显加大：一天内高低起伏剧烈、混合状态的烦躁绝望	需要医生评估方案是否需要调整
漏服/停药几天了	撤药可能诱发快速循环/复发，不要自己"加倍补回来"，联系医生问怎么恢复

情况	为什么不能等
遇到重大生活事件：亲人离世、分手、失业、搬家、家庭冲突	应激是复发诱因，医生可能要预防性安排
育龄女性打算怀孕/备孕	部分心境稳定剂有致畸风险，必须提前个体化评估，不要自己突然停药

> 【临床共识】**任何让你"心里不踏实"的变化，都值得打一个电话问医生。** 医生宁愿你多问，也不愿你自己猜着猜着就复发了。

三、什么时候该住院：住院指征

【临床共识】在以下情况，医生通常会建议**住院**：

- **严重的急性发作**：躁狂/抑郁/混合发作已经明显失控，门诊药物来不及控制；
- **存在即刻的自伤/自杀风险**：尤其混合相、有具体计划、既往有自杀尝试；
- **有伤人、毁物、肇事肇祸风险**：躁狂期激越、冲动行为在家无法控制；
- **基本生活不能自理**：连续不眠不食、拒食拒饮、身体衰竭；
- **伴有精神病性症状**：幻觉、妄想，现实检验能力丧失；
- **在家无法保证安全**：缺乏可靠照护，或需要密切观察疗效和副作用。

> 【个人体验】很多人一听"住院"就害怕，觉得是"被关起来"。换个角度想——**住院是在你最无力的时候，医院给你提供一个 24 小时有人看护、能安心睡觉、稳定用药、有人盯着的安全环境。**它把你从"要同时应付治病和应付生活"的双重压力里解放出来，让你专心治病。

四、把住院讲成"保护"，而不是"惩罚"

- **住院不是失败，也不是丢脸。**它和骨折了打石膏、肺炎了输液住院是一个道理——病到这个程度，就需要这个级别的医疗支持。
- 住院期间通常会做的事：规律用药、观察疗效和副作用、必要的化验检查、心理教育、出院计划。
- **早住院不等于住很久**：很多双相患者急性住院两三周左右就能稳定出院，然后转门诊维持治疗。
- 出院后记得按医嘱衔接门诊随访，不要一出院就觉得"好了"又断药。

五、非自愿就医：了解一下，不恐慌

【临床共识】有一种情况你需要知道：当一个人**有即刻危险（自伤、伤人、严重发作），却因为自知力下降而拒绝就医时**，家属和专业人员会按照《中华人民共和国精神卫生法》规定的程序，协助送医。

- 这不是"被绑架"，而是法律为保护患者生命安全设立的程序；
- 具体的诊断、送医、复核流程，由具备资质的精神卫生医疗机构和专业人员依法进行；
- 作为家属/患者本人，你有权了解相关规定，有疑问可咨询医院医务部门或当地精神卫生机构。

> 【个人体验】很多躁狂期被家人"强行"送医的人，事后回想都会说："那时候我根本不觉得自己有病，是他们救了我。"理解这个程序，不是为了对抗它，而是为了在需要的时候，配合它救命。

六、复诊时怎么高效沟通：带上这三样

精神科门诊通常只有 10–20 分钟，准备得越充分，拿到的判断越准：

1. **情绪睡眠日记**（见《2. 情绪与睡眠监测》）：按天记关键词——睡了几小时、困不困、情绪几分、有没有花钱冲动、有没有消极念头；
2. **用药记录**：现在吃哪几种药、几点吃、有没有漏服、出现了什么副作用；
3. **复发信号对照**：把《5. 复发预警信号》里自己中了哪几条，直接告诉医生。

可以直接问医生的问题：
- "我最近这些变化，算正常波动还是需要调方案？"
- "我出现了XX副作用，是该忍一忍、还是要调？"
- "大概什么时候可以讨论减量？"
- "出差/回老家，药怎么带、复诊怎么衔接？"

七、医生联系不上时的替代路径

打医生电话没接、线上问诊没人回、号挂满了——不要就此放弃：

1. **医院门诊/导诊台**：说明"正在服用精神科药物，有症状变化/副作用，需要加号"；
2. **同科室其他医生**：主治不在时，值班医生也能看你的病历；
3. **12356 心理援助热线**：先聊一聊，让接线员帮你判断紧急程度；
4. **急诊**：如果出现自伤念头、严重不眠不食、行为失控、药物严重不良反应，不要等预约号——直接去有精神科急诊的医院。

> 联系不上医生 ≠ 没人管你。医院、热线、急诊，都是你的后路。

> **最后提醒**：双相管理的精髓，是"小问题早处理，不拖成大问题"。出现早期信号就打个电话，比将来住院一个月划算得多；真到了需要住院那一步，也别害怕——那是医院在用最系统的方式保护你。主动联系医生、该住院就住院，不是你脆弱，恰恰说明你在认真对自己的生命负责。

参考来源

- 世界卫生组织（WHO）：*Bipolar disorders fact sheet*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorders
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG256)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng256
- 加拿大多学科双相障碍治疗指南（CANMAT/ISBD）：急性住院指征、维持治疗与复发管理。

- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 《中华人民共和国精神卫生法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）。
- 《中国双相障碍防治指南》（中华医学会精神医学分会）。

模块 9

生活与社会支持

1. 与家人亲友沟通

> **双相最让家人崩溃的地方，是它"来回摆"——昨天还亢奋得像打了鸡血，今天就跌到谷底。他们没见过这种病，很容易把它当成"你脾气差""你意志薄弱""你一阵一阵的"。这一页给你准备好话术、"该说/不该说"对照表和具体的求助清单，让你不必每次都从零解释。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断。

一、先理解：双相为什么沟通起来特别难

【个人体验】双相患者在沟通中常遇到几种典型困境：

- **"我躁狂的时候觉得自己特别正常，是他们大惊小怪"**——可等你回到抑郁相，才发现自己上次冲动花掉了三个月工资、跟人吵翻了关系。
- **"他们只看到我砸东西、乱花钱，不看我痛苦的时候"**——家人被躁狂相吓到，往往只记得"你发病时多可怕"。
- **"我不想让父母担心，结果瞒着瞒着，漏服了药、熬夜了也没人提醒"**。
- **病耻感**：怕被单位知道、怕被催婚时被议论、怕谈恋爱被嫌弃。

这些感受都很真实。但【临床共识】研究告诉我们：**家人的理解、规律作息的共同维持、对早期复发信号的观察，是双相患者预防复发最重要的保护因素之一。** 问题不是"要不要说"，而是"对谁说、说多少、怎么说"。

二、三个版本的"解释话术"

不必对所有人和盘托出。下面是按对象分的三个版本，直接照抄也行。

对父母（尤其老一辈，最容易说"你就是脾气怪"）

> "爸、妈，我这段时间去医院查了，医生说是**双相情感障碍**——你们可能听过老名字叫'躁郁症'。这不是我性格有问题，是大脑里管情绪的那个'开关'出了毛病：有时候会莫名其妙地兴奋好几天、睡得特别少也不困、话特别多、控制不住地想花钱；有时候又会突然跌到谷底，什么都不想干。
>
> 它是有生物学基础的病，跟高血压糖尿病一样需要长期吃药和复诊，不是我'作'、也不是我'意志不坚定'。我现在在认真治，会慢慢稳住的。
>
> 你们不用劝我'想开点'，也不用专门盯着我。你们能帮我的，是：发现我连着几天睡得特别少还特别兴奋、或者突然闷头不说话很久的时候，提醒我一句'你最近睡得不好，要不要跟医生说一声'。"
>
> 如果父母还是半信半疑：让他们陪你去一次复诊，让医生当面说。**医生一句话，顶你说十句。**

对伴侣（同住、朝夕相处的人）

> "我想认真跟你说一下我的情况。我被诊断为双相情感障碍，在长期吃药和复诊。

> 这个病的特点是情绪会像坐过山车一样来回摆。我可能有一阵子突然特别兴奋、话多、不想睡觉、看什么都看不顺眼容易发火；也可能有一阵子整个人缩起来，不想说话、不想动，觉得什么都没意思。**这不是针对你，也不是我变心了，是病在波动。**
>
> 我需要你做的，不是劝我开心或者劝我别生气，而是：
> 1. 我连着两三点才睡、还精神得很的时候，问我一句'你今天睡够了吗'；
> 2. 我乱花钱、乱承诺什么大事的时候，先别急着跟着做，等我两三天再商量；
> 3. 我低落的时候，不用讲大道理，陪我待着就行；
> 4. 提醒我按时吃药、按时复诊，但别翻我包检查。
>
> 我也会尽量把我的状态告诉你，不让你猜。"

对朋友 / 同事（不需要深入，只要不误解）

> "跟你说个事：我这段时间在应对一个情绪方面的问题，在治疗中。可能有时候我突然特别能聊、特别有精力安排一堆事，有时候又推掉聚会、回消息慢、不想说话——**这不是忽冷忽热针对你，是我在治病。** 你愿意的话，偶尔约我散散步、正常跟我来往，就帮大忙了。"

三、"该说 / 不该说"对照表

双相家属和朋友最容易说错的话，往往不是恶意，而是不了解。下面这张表，你可以直接转发给家人：

家人/朋友典型反应	背后可能是	你可以怎么应对
"你就是脾气差 / 性格有问题"	把疾病当成性格缺陷	不争论，"医生说是大脑里管情绪的地方出了问题，跟脾气是两码事。"
"你就是闲的，忙起来就好了"	不了解双相的生物学基础	"忙反而是我转躁的诱因之一，我现在最需要的是规律作息。"
"你上次不是挺好的吗？怎么又这样了"	不知道双相是波动病程	"双相就是会波动的，跟感冒好了也会再感冒一样，不是我故意反复。"
"你兴奋的时候不是挺正常的吗，装的吧"	只看到轻躁狂期"状态好"	轻躁狂期看起来像"打了鸡血"，但那是病理状态，不是真正的好状态。
"别吃那些药了，是药三分毒"	出于关心但不懂	"药的副作用我会跟医生说，自行停药复发的代价大得多。"
"你怎么又乱花钱 / 又乱发脾气了"	被躁狂相伤到	等你状态平稳后再谈，不要在躁狂高峰期争论；先把大额支出拦住。
"为了这个家你也要振作"	想鼓励但变成压力	低落期听到这种话只会更内疚，内疚是抑郁和混合相的燃料。
"你看谁家谁谁不是也好好的"	不了解个体差异	微笑着不接话，把科普发给他。
过度保护：什么都不让你做、天天盯着	担心，但方式让你窒息	"我知道你担心我，但我也需要慢慢恢复自己做事。"
反复问"你什么时候能彻底好"	焦虑和不确定	"医生说双相是长期管理的病，像高血压一样要长期稳住，我会定期复诊。"

> 【争议观点】有些家人确实长期不理解、甚至贬低你。**你没有义务把每个人都教育成合格的支持者。**把精力留给真正愿意听的人。

四、提出"具体可操作"的帮助请求

你越具体，对方越容易帮到你：

模糊的求助	更具体、对方更好接的版本
"我可能要发病了"	"我连着三天只睡了三四个小时还特别精神，你陪我明天去复诊好吗？"
"帮我看着点钱"	"这个月如果我要刷信用卡买超过 2000 块的东西，你先拦我一下，等我两天再说。"
"我好难受"	"我今天什么都不想干，你陪我在家待着，各看各的手机也行。"
"提醒我吃药"	"你晚上九点给我发个消息问'药吃了吗'就行，不用盯着我吃。"
"我睡不着"	"我今晚又睡不着，你别跟我聊大事，陪我把灯关了躺一会儿。"

双相患者特别适合请家人做的几件小事：

- 观察并记录：最近睡眠是不是变少了？是不是突然话特别多、特别易怒？是不是开始大手笔花钱？这些是复发早期信号；
- 提醒服药、提醒复诊，但不要翻包检查；
- 周末一起维持规律作息——按时吃饭、晚上一起散步 10 分钟，不催促，只同行；
- 在你躁狂高峰期，**陪你把大额支出、大额承诺先放一放**，等两三天再决定；
- 复诊时陪诊，帮你记医嘱（躁狂期和抑郁期注意力都差，回家就忘）。

五、一段可直接转发给家人的科普

> "双相情感障碍（旧称躁郁症）不是'脾气差'，也不是'矫情'。它是大脑里调节情绪的系统出了故障——就像一个温度自动控制坏了的空调，不是制冷就是制热，很少停在舒适区。它有明确的生物学基础和遗传倾向，是需要长期服药、规律作息、定期复诊的慢性病，和高血压、糖尿病需要长期管理是一个道理。
>
> 正在吃药的人，请不要劝他'是药三分毒别吃了'——双相自行停药后复发的风险很高，而且复发一次，治疗难度可能就上一个台阶。
>
> 你能做的最好的事：
> 1. 不评判、不说'想开点'；
> 2. 注意他的睡眠——**睡得突然变少却不困、话变多、花钱变冲，这是要复发的信号，第一时间告诉他的医生**；
> 3. 在他情绪平稳的时候，和他一起把作息稳住；
> 4. 如果他说'不想活了'，不要替他保密，帮他打 12356 或送医。"

六、不同对象的特别边界

和伴侣：
- 躁狂期你可能特别易怒、特别爱说话、特别想花钱/社交/做决定，**那不是伴侣做错了什么**；抑郁期你可能不想亲热、不想说话，那也不是对伴侣没感情。提前说清楚。
- 关系里的大事（钱、工作、要不要孩子、分手离婚），**尽量在你状态平稳时讨论，别在躁狂高峰或抑郁谷底做决定**——躁狂期做的决定，事后往往要还很久。
- 不要把"你必须陪我熬过去"变成控制；也不要把伴侣的疲惫当成"他不爱我了"。

和父母 / 成年子女：
- 如果你是患者本人：告诉父母"我在治疗，不需要你们全天候盯着"，把边界讲清楚。
- 如果你是青少年双相患者的家长：**不要把孩子的情绪起伏当成"青春期叛逆"**——持续几天的极度亢奋、睡得极少还不困、挥霍、易怒毁物，是要就医的信号，不是"中二病"。
- 不要在孩子面前反复说"都是我们害了你"——内疚会加重病情。

和朋友：
- 你有权只告诉"需要知道的人"，不必对全朋友圈公开。
- 双相康复者社群（正规医院组织的家属/病友团体）往往比普通朋友更懂你，可以同时建立。

七、一张表：你的支持系统地图

类别	我可以找谁	能提供什么	联系方式
能倾诉情绪的人	（朋友/家人）	听我说、不评判	
能观察我状态的人	（同住家人）	注意睡眠/情绪/花钱变化，提醒我	
能帮我拦住大额支出的人	（伴侣/父母）	我冲动消费时先拦一下，等两天	
能陪诊的人	（家人）	陪复诊、帮记医嘱	
专业支持	（医生/治疗师/热线）	诊断、治疗、危机干预	医生电话：____；12356

> 如果某几栏是空的，没关系——这正是你接下来可以慢慢搭建的。

> **最后，请记住：** 你不需要一次让所有人都理解你。先找到一个人，告诉他。双相是个漫长的病，**你身边那个愿意陪你规律睡觉、陪你复诊、在你乱花钱时拦你一下的人，就是你最重要的保护因素。**

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG185)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental health of adults fact sheet*. https://www.who.int/
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》。

- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/

2. 工作学习场景应对

> **双相对工作学习最大的威胁，不是某一次发作，而是"在轻躁狂期硬撑着连轴转，然后突然跌到谷底瘫很久"。这一页给你一套节奏管理方案：发作期怎么办、维持期怎么稳、复工复学怎么爬坡、怎么设隐私边界。核心原则只有一句——先稳定，再谈效率。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断。涉及具体劳动权益与学籍政策，以你所在单位/学校和当地法规为准。

一、双相患者在工作学习中的特殊难点

【临床共识】双相在职业场景里有几个和焦虑/抑郁不一样的特点，你要心里有数：

- **轻躁狂期的"假性高效"**：你可能连续一周每天只睡 4 小时，通宵写方案、主动接三个项目、觉得自己无所不能——这时候同事还觉得你"状态真好"。但这种透支几乎一定以一次重度抑郁或激越爆发收场。**轻躁狂期的效率，是要还的。**
- **抑郁期的"断崖式掉线"**：前一天还能开会，第二天起床连穿衣服都费劲。这种断崖和"懒"没关系。
- **混合状态的在职煎熬**：人坐在工位上，脑子转得飞快却一个字写不出来，烦躁、坐立不安、想摔东西又有自杀念头——这是最难受也最容易被误解的在职状态。
- **冲动决策**：躁狂高峰期冲动辞职、跟老板拍桌子、裸辞创业、网上骂客户——这些决定事后通常要付出很大代价。

> 【个人体验】很多康复者最大的教训是：**把轻躁狂期的"我状态特别好"当成可以一直持续的常态，于是拼命接活、拼命熬夜，最后把自己作到住院。** 学会在"状态特别好"的时候警觉，而不是兴奋，是职业管理的第一课。

二、要不要告诉单位 / 学校

这是一个**隐私选择**，不是义务。判断原则：

告诉的好处	不告诉的理由
可以申请弹性时间、减少高压任务、考试安排调整	担心被贴标签、影响晋升/评优
发作时有人知道怎么帮你	病情尚未稳定、自己还没准备好
定期复诊需要请假，有合理理由	病情已经很稳定、不影响工作学习
万一躁狂期做了冲动决定，有个信任的人能拉你一下	单位文化对精神疾病不友好

常见做法是"有限披露"：告诉直接相关的一两个人（你的直属领导、一个信任的同事/辅导员），而不是全公司/全班公开。你有权只说"健康原因"，不必说"双相"这两个字。

告诉谁、怎么说

对领导 / HR（按需）：

> "我最近因为健康原因在接受长期治疗，需要固定时间复诊。工作上我会尽量安排好，不影响交付。如果某些时候状态不好，我可能需要临时调整一下节奏，或者把任务拆小一点，谢谢你的理解。"

对辅导员 / 班主任：

> "我最近在医院诊断出情绪方面的问题，在长期治疗中。可能需要偶尔请假复诊；如果考试期间我状态特别差，希望学校能有合理的缓考/调整安排。"
>
> 【临床共识】**病历和就诊记录受隐私保护。**单位/学校无权要求你出示诊断证明；但如果你要申请病假、考试缓考、岗位调整，通常需要医院开具的病假建议书——这是你自愿提供的。

三、双相特别适用的工作节奏管理

【临床共识】对双相患者来说，**稳定的节律比突击高效重要得多。**这就是 IPSRT（人际与社会节律治疗）的核心思想：睡眠、起床、吃饭、社交时间的规律，本身就是治疗的一部分。

日常节奏	怎么做
固定起床时间	不管前一晚几点睡，早上固定时间起——这是稳定情绪钟的关键。周末也不赖床补觉超过 1 小时。
工作时间有边界	设定明确的下班时间，不把工作带回家；加班偶尔可以，**连续一周熬夜是转躁红线。**
任务拆小	把大任务拆成半天能完成的小块，每完成一块就休息。躁狂期不要主动接三个新项目。
午睡控制	午睡 20–30 分钟可以；一下睡两三个小时会打乱夜间睡眠，要避免。
咖啡因	每天不超过 1–2 杯，下午 2 点后不喝。**咖啡因和睡眠剥夺是双相转躁的两大诱因。**
酒精	尽量不喝。酒精破坏睡眠结构，酒后的睡眠是浅睡眠，第二天情绪更容易波动。
重大决策冷静期	辞职、裸辞创业、大额投资、跟重要的人翻脸——任何重大决定，**至少等 48 小时、在你睡眠正常的时候再做。**

四、发作期与维持期的不同策略

抑郁发作期

- **不要硬撑到崩盘才请假**：早期短期请假/调整，往往比拖到必须长休便宜。
- **把任务降到最小**：跟领导说"这段时间我先把这一件事做完"，只接一件事。
- **不要做"我是不是该辞职"这种决定**：抑郁期对未来的判断是扭曲的，等你好了再想。
- **复工/复学不要一步到位**：和医生、单位/学校商量，从半天、少量任务开始，逐步恢复全职。

躁狂 / 轻躁狂发作期（这是双相特有的）

- **这时候你觉得自己状态特别好——恰恰要警惕。**告诉自己一句口诀："**我现在感觉越好，越可能是在躁狂，越不能做大决定。**"
- 主动减少刺激：不安排通宵加班、不答应新的大项目、不参加密集的社交活动。
- 让一个信任的人（家人/同事）知道你最近睡得少了，请他帮你"踩刹车"。
- 如果已经明显话多、易怒、挥霍，尽快联系医生提前复诊，不要等"它自己过去"。

混合状态

- 这时候人在工位上是最难受的：脑子快但情绪糟，坐立不安。**不要逼自己出活**，尽快就医调整。
- 混合状态自杀风险高，如果你同时有"不想活"的念头，按危机流程处理（见模块8）。

五、学生场景：课堂、考试、宿舍

场景	应对
考试周突击熬夜	双相学生最大的坑就是考前通宵——一次通宵追剧/备考就可能诱发一次轻躁狂或抑郁转相。**宁可少考几分，不要通宵。**
课堂上突然烦躁坐不住	这可能是混合状态的信号。提前和老师说一声，允许自己出去走 5 分钟，不要硬坐在教室里熬。
宿舍作息互相干扰	熬夜打游戏的室友对你是高危环境。必要时申请调宿舍、或买好耳塞眼罩，把自己的睡眠守住。
和同学冲突后	急性躁狂/混合期不要发长消息解释、不要做"以后再也不理谁"的决定；睡一觉、等状态平稳再处理。
评奖/保研/求职高压期	提前一两个月和医生沟通，把复诊安排好；高压期不要叠加新的刺激（比如同时考证+实习+恋爱）。

> 【个人体验】学生时期双相最容易被当成"你就是作息乱""你就是情绪化"。如果你已经连续几天只睡三四小时还特别精神、特别能花钱、特别爱跟人吵架，**这不是你自律性差，是要找医生的信号。**

六、职业选择与压力管理

【临床共识】双相患者不是不能拼，而是要**选对节奏、选对岗位。**一些康复者的共同经验：

- **适合的岗位特点**：节律相对固定、任务可预期、不需要频繁倒班/跨时区出差、不需要长期 996。
- **要谨慎的岗位**：夜班/倒班（打乱生物节律）、高压销售（业绩压力+应酬喝酒）、需要连续通宵赶项目的高强度创业期。
- **不是不能做创造性工作**：很多康复者在创意、写作、技术岗位做得很好——关键是**自己给自己设边界**，而不是等公司逼你。
- **不要在轻躁狂期做职业豪赌**：裸辞创业、借钱加盟、突然转行——这些决定几乎都要等你情绪平稳后再评估。

> 【争议观点】要不要因为病换工作？没有标准答案。原则是：**先把病稳住，再谈职业发展；不要在发病高峰期做职业大变动。**

七、权益提示

- 根据《精神卫生法》《劳动合同法》及地方规定，精神疾病患者在医疗期内享有相应保护；单位不能仅凭"你有精神疾病"就直接辞退。具体条款拿不准，可以打 **12333**（人社咨询）或 **12348**（法律援助）问。
- **不要把病历主动广而告之**：病假条只给需要审批的人，不给八卦的同事。
- 学生的缓考、休学、复学流程，凭医生诊断和病假建议向学校教务/学工部门申请。

八、一张表：我的职场/校园双相节律管理卡

```
==============================
  我的双相工作/学习节律卡
==============================
固定起床时间：_______ 点
下班/停止工作时间：_______ 点
我本周不答应的事（躁狂期刹车）：
  _____________________
任何大额/重大决定，等 48 小时再做。

信任的同事/同学：_______ 电话：_______
我的"转躁早期信号"（我自己列）：
  - 最近睡得特别少还不困
  - 话变多、脑子转得停不下来
  - 开始想买大东西/想做大项目
  出现以上任一：本周联系医生。

医生电话：_______  热线：12356
==============================
```

> 存手机里。**状态好的时候把这张卡写好，状态差的时候它替你做决定。**

> **最后，请记住：** 双相患者在职场/校园拼的不是谁更能熬，而是谁更能**稳得住节律、守得住睡眠、不在躁狂期做大决定**。允许自己慢一点、允许自己申请调整——这不是软弱，是长期主义。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG185)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng185

- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 世界卫生组织（WHO）：*Mental health in the workplace*. https://www.who.int/
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》（IPSRT 人际与社会节律治疗相关内容）。
- 《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国劳动合同法》（国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）。

3. 婚姻与生育

> **双相患者能不能结婚、能不能要孩子，是被问得最多也最容易被自己吓住的问题。答案是：能结婚、能生育，但需要比普通人更早规划——尤其是女性患者，孕期和产后是复发高发期，而部分心境稳定剂对胎儿有明确风险。这一页只讲原则和沟通，不讲具体用药调整，具体方案必须由你的精神科医生 + 产科医生一起定。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生与产科医生的联合面诊。所有用药调整必须遵医嘱，本文不提供任何换药、停药、调量方案。

一、亲密关系中的双相：先把病说在前面

【临床共识】双相对亲密关系的挑战，不在"病本身"，而在它的**波动**：

- 躁狂期：你可能特别需要关注、特别易怒、花钱大手大脚、对伴侣挑刺、甚至出现冲动的婚外情感；
- 抑郁期：你可能完全不想亲热、不想说话、觉得自己是累赘；
- 混合期：你可能一边烦躁想吵架、一边又有活着没意思的念头——这对伴侣是最大的消耗。

给关系的几条实操建议：

1. **恋爱初期/婚前，找个双方都平静的时机说清楚**："我有一个情绪方面的长期问题，叫双相情感障碍，在规律治疗。它的特点是会波动，我不是故意忽冷忽热。我想和你一起看看，我们能不能一起应对。"——拖到躁狂期爆发才说，信任会崩得更彻底。
2. **约定"刹车信号"**：和伴侣约定一个词，比如"节律"，任何一方说出这个词，就意味着"现在情绪上头了，这件事今天不吵了，明天再说"。
3. **重大决定不在情绪高峰做**：结婚、买房、离婚、分手、要不要孩子——这些决定必须在你连续几周状态平稳时讨论。
4. **不要把"你必须陪我熬过去"变成控制**：伴侣也有累的时候，允许他/她有自己的喘息时间。
5. **给伴侣的"使用说明"**：把你"该说/不该说"对照表（见模块9第1篇、可选模块家属附录）发给他，比你每次生气再解释省力得多。

> 【个人体验】很多康复者的婚姻不是被病打败的，是被"发病高峰期做的那些决定"打败的——躁狂期冲动离婚、挥霍共同财产、跟家人断绝关系，等自己好了，关系已经碎了。**记住：情绪高峰不做关系决定。**

二、会不会遗传给孩子

【临床共识】双相有一定的遗传倾向——如果父母一方有双相，子女患病风险比一般人群高，但**这不是"注定会遗传"**：

- 一般人群中双相的患病率约 1%–2%；
- 父母一方患病，子女风险大约在 10%–20% 这个量级（具体数字因研究而异）；

- 也就是说，**大多数双相患者的孩子并不会得这个病**；即使遗传易感性存在，环境（稳定的家庭节律、良好的教养）也是重要的保护因素。

你能做的：
- 自己规律治疗、保持情绪稳定——**你的稳定，就是孩子最好的保护**；
- 不在孩子面前剧烈吵架、不把孩子当情绪容器；
- 孩子长大过程中，如果发现他有"连续几天极度亢奋/睡得极少不困"或"长期情绪低落"，早就医评估，不要当成"青春期叛逆"。

三、备孕：最重要的一件事是"提前规划"

【临床共识】**双相女性计划怀孕，最忌讳的是"意外怀孕后慌慌张张停药"。** 正确做法是：

1. **至少提前几个月**（通常建议 3–6 个月以上）就告诉精神科医生："我计划怀孕。"
2. 由精神科医生和产科/优生优育医生一起，重新评估你的用药方案。这个过程需要时间，不是"发现怀孕了再商量"。
3. **不要自己突然停药**——自行停药导致孕期复发，对孕妇和胎儿的风险，往往比在医生指导下用相对安全的药物还大。

> 【安全红线】本文不写具体哪个药"能吃"、哪个药"不能吃"、怎么减、怎么换——这必须由医生根据你的具体病程、复发史、当前用药来个体化决定。你要做的只有一件事：**计划怀孕，提前告诉医生。**

育龄女性必须知道的关键警示

【临床共识】有两类常用心境稳定剂，对胎儿有明确风险，**育龄期女性必须心里有数**：

- **丙戊酸（丙戊酸钠/丙戊酸镁）**：与胎儿神经管畸形等不良结局风险明确相关。**正在服用丙戊酸的育龄女性，必须采取可靠避孕措施；如果计划怀孕，必须提前和精神科医生讨论换药方案。**
- **卡马西平**：同样有一定致畸风险，计划怀孕前必须由医生重新评估。

> 这不是说"吃了这两个药就不能要孩子"——而是说：**如果你在吃这两个药，又打算要孩子，这件事必须在怀孕发生之前就和医生谈好，不能等怀上了再说。** 如果你是男性患者，生育前的用药同样建议和医生谈一次。

四、孕期：复发风险与监测

【临床共识】关于孕期和产后，你需要知道这几条：

- **孕期不是"天然保护期"**：激素变化、停药/减药、睡眠减少都可能诱发复发。整个孕期都要和精神科医生保持随访。
- **产后是双相复发的最高危窗口之一**：产后激素剧烈波动、长期睡眠剥夺、照护压力——很多女性是在产后第一次出现躁狂/轻躁狂或明显情绪波动。**产后 3 个月内尤其要警惕。**
- 即使孕期一切平稳，产后也不能自行停药；是否继续用药、用哪种，由医生权衡母乳喂养和复发风险后决定。

产后要警惕的信号（告诉家人也留意）

- 连着几天睡得很少却不觉得困、夜里照顾完宝宝还精神得很、话特别多、特别兴奋或特别易怒；
- 情绪大起大落，一会儿觉得"我是全世界最好的妈妈"，一会儿又觉得"我连孩子都带不好"；
- 对宝宝过度焦虑、或者相反——对宝宝异常淡漠、觉得"这个孩子不是我的"（**这一条要立即就医，可能是产后精神病性症状，需要紧急处理**）；
- 出现"不想活"或"伤害宝宝"的念头——**这不是你坏，是急症，立刻就医/打 120。**

> 【临床共识】产后出现情绪剧烈波动或精神病性症状，不是"你不爱孩子"，也不是"你矫情"，是需要紧急医疗干预的状态。越早处理，母婴结局越好。

五、母乳喂养

【临床共识】部分精神科药物有少量进入乳汁，但**不是所有用药都必须断奶。**是否哺乳、用哪种药、怎么安排服药和哺乳时间，由医生根据药物种类、婴儿情况、你的复发风险共同决定。你不需要在"吃药"和"喂奶"之间自己二选一——把问题交给医生。

六、给伴侣的话（可转发）

> "如果你身边的人是双相患者，并且你们准备要孩子：
> 1. 这件事不是她一个人的事，是你们两个人提前几个月一起去看医生；
> 2. 孕期和产后，她复发的风险比平时高很多，**产后夜里带娃、分担家务、守住她的睡眠，是你能做的最重要的事**；
> 3. 产后她如果突然变得异常亢奋/易怒/低落/对孩子没感觉，不要说'你是不是太紧张了'，陪她去医院；
> 4. 不要在孕期/产后劝她'为了孩子把药停了'——复发的代价远大于药物可能的影响，具体听医生的。"

七、一张表：生育规划时间线

阶段	你要做的事
计划怀孕前 3–6 个月	告诉精神科医生"我计划怀孕"，和医生一起评估用药；同时做一次孕前检查；**开始可靠避孕，直到医生说可以备孕**
备孕期间	规律复诊、稳定情绪、不要在这段时间叠加重大生活变动（搬家/换工作/考研）
意外发现怀孕	**当天/尽快联系精神科医生**，不要自己停药，也不要慌，由医生评估
孕期	精神科 + 产科双线随访；监测睡眠；出现情绪波动/睡眠骤减及时就诊
产后 3 个月内	最高危窗口。家人帮着守睡眠；出现亢奋/易怒/低落/对宝宝异常立即就诊
哺乳期	和医生讨论哺乳与用药安排；不要自行停药

> 【个人体验】很多双相妈妈最终都顺利生养了孩子，秘诀不是"硬扛"，而是**提前规划、双线随访、家人帮着守睡眠。**你不是一个人在扛这件事。

> **最后，请记住：** 双相不等于不能结婚、不能当父母。它只要求你比普通人**早一点规划、多找几个医生一起商量、在产后这段最危险的时间里让家人帮你把睡眠守住**。具体怎么用药、要不要怀孕，永远听你的精神科医生和产科医生的，不要听网上的"过来人经验"。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG185)*（孕期、产后与用药章节）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 美国精神医学学会（APA）：*Depression During & After Pregnancy* 相关患者教育（产后情绪危机识别）. https://www.psychiatry.org/
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》（育龄女性与生育相关章节）。
- 世界卫生组织（WHO）：*Maternal mental health*. https://www.who.int/
- 国家药品监督管理局药品提醒：丙戊酸类药物育龄期女性风险提示（以官方最新公告为准）。

4. 财务与冲动消费

> **双相躁狂期最现实的后果之一，不是情绪崩溃，而是钱——一夜之间花光积蓄、盲目投资、借高利贷、给主播打赏、替人担保、冲动借贷给朋友，等回到现实才发现窟窿已经补不上了。这一篇是给你和家人的"财务防弹衣"：在你状态好的时候，提前把防护搭好；真的冲动起来，让制度替你踩刹车。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不替代专业金融、法律建议。涉及具体合同与债务问题，请咨询正规金融机构/律师（法律援助可拨 12348）。

一、为什么双相患者特别容易在钱上出事

【临床共识】挥霍、冲动消费、盲目投资、轻率的大额财务承诺，本身就是躁狂/轻躁狂的**诊断症状之一**（"过度参与有明显痛苦后果的高风险活动：无节制购物、轻率的性行为、盲目投资、鲁莽驾驶"）。也就是说——

- 你躁狂期刷爆信用卡时，**不是"我管不住手"，是病在发作**；
- 你那时候觉得"我马上要赚大钱了""这钱花出去会十倍回来"，**那种笃定感是病造成的，不是真的商业判断**；
- 等你回到抑郁相，才看到账单——那时候你连起床都费劲，更别说处理债务。

> 【个人体验】很多康复者回忆起自己的躁狂期，用的词是"被一股力量推着"——根本停不下来，脑子一热就下单、就转账、就签字。**这不是意志力的问题，是大脑奖赏系统在病理状态下失控。** 所以不要靠"我下次忍住"，要靠制度。

二、躁狂期常见的财务"坑"清单

下面这些，是康复者和家属高频提到的真实场景，对照看看你中过几条：

- [ ] 疯狂网购/直播打赏，一次花掉一个月工资；
- [ ] 盲目投资：炒股/炒币/加盟/网贷理财，"这次一定赚"；
- [ ] 大额借贷：信用卡套现、网贷、甚至借高利贷；
- [ ] 给朋友"义气"转账、替人担保借钱；
- [ ] 冲动买大件：车、表、奢侈品、根本用不上的电器；
- [ ] 冲动辞职/裸辞创业，断了收入来源；
- [ ] 一时冲动把存款全取出来做"大项目"；
- [ ] 给游戏充值、给主播大额打赏；
- [ ] 冲动在网上签各种"课程加盟""代理"合同；
- [ ] 因为觉得自己"特别有魅力"，冲动进行高危的财务承诺。

> 中过几条不丢人——这是病的症状，你要做的是**提前装刹车，而不是事后自责。**

三、财务保护安排：在你状态好的时候搭好

【临床共识】财务保护的核心思路是：**把"躁狂高峰期的你"和"大额财务决策"隔离开。** 具体做法：

1. 设定"冷静期"规则

和自己（也和家人）约定一条铁律：

> **任何超过 X 元的支出/投资/转账，一律等 48 小时再决定。**

X 由你根据自己的收入定（比如 2000 元、5000 元）。48 小时后如果你还在正常睡眠、情绪平稳，再做决定。躁狂期的冲动，绝大多数撑不过 48 小时。

2. 限制高风险工具

- **信用卡**：保留 1 张日常用的就够，其他的在状态平稳期注销或调低额度；不要为了"方便"办一堆卡。
- **网贷/消费贷 App**：状态好的时候就卸载，不要留着"应急"——躁狂期你根本不会记得这是"应急"。
- **股票/币圈交易 App**：如果你的躁狂期曾经炒过，考虑在平稳期就把账户交给家人共管、或者干脆销户。
- **大额转账**：把银行卡的单日转账限额调低到你能接受的范围。

3. 授权一个你信任的人"共管"

这是最有效但也最难开口的一步。在你状态平稳的时候，和你最信任的家人（伴侣/父母）谈：

> "我跟你说个正事。我这个病，有时候会突然特别亢奋、控制不住花钱。我想请你帮我一个忙：如果我哪天突然要花一大笔钱、要借大钱、要做投资，你先拦我一下，问我一句'你最近睡眠怎么样'，等我两天再决定。"

具体可以做的安排（和家人商量着来，不勉强）：

安排方式	怎么做
共管账户	大额资产放一个双方共管的账户，大额支取需要两个人确认
信用卡副卡额度	日常用一张额度不高的卡，大额卡由家人保管
手机支付免密关掉	关掉小额免密支付，每笔都输密码——多一步操作，多一分冷静
家人保管银行卡/证件	极端情况下（反复躁狂挥霍），身份证、大额银行卡由家人保管，用时再取
紧急联系人知晓网贷账户	让家人知道你有哪些账户，万一出事能帮你止血

> 【争议观点】把钱交给家人管，听起来像"我不信任自己"。但康复者普遍的经验是：**这不是不信任，是像糖尿病患者把胰岛素放在固定位置一样，是对自己疾病的尊重。** 你状态好的时候设计的制度，是用来保护那个失控的自己的。

4. 提前做好财产与法律安排

- **写一份"复发应对财务备忘"**（不是遗嘱，是备忘）：你的账户、保单、贷款、欠别人的钱、别人欠你的钱——写下来放在家人知道的地方。万一你躁狂期被送住院，家人不至于两眼一抹黑。
- **不要在躁狂高峰期签任何大额合同**：加盟、代理、担保、借条、合伙协议——一律等 48 小时、等睡眠正常、最好跟你信任的人商量后再签。
- **担保是高危行为**：双相患者躁狂期特别容易"义气"替人担保。记住：**担保不是签字，是你替别人还钱的法律责任。**

四、如果已经花出去了：发作后怎么补救

【个人体验】如果你刚从一次躁狂挥霍中清醒过来，先做这几件事，不要先骂自己：

1. **先把"出血点"堵住**：关掉免密、注销多余卡片、卸载网贷和交易 App。
2. **列一张真实清单**：现在到底欠了多少、有哪些分期、有哪些要还的——写下来，数字比你想象的小（也可能比你想象的大，但写出来就不可怕了）。
3. **不要"翻本"**：这是最致命的一步——亏了就想"再投一笔赚回来"，结果窟窿更大。**已经亏的钱，不要再往里加一分。**
4. **和家人坦白，一起面对**：瞒着只会利滚利。家人帮你一起跟银行/平台协商分期，比你一个人硬扛强。
5. **已经涉及高利贷/暴力催收**：保留证据，拨 **110**，法律援助拨 **12348**。不要害怕，你不是第一个遇到这种事的人。
6. **复诊时告诉医生**：躁狂挥霍本身就是发作证据，医生可能需要调整治疗方案。
7. **不要因为这次就否定自己**：这是病的症状，不是你人品差。你现在做的补救，就是你在负责。

五、一张表：我的"财务保护清单"（状态好时填好打印）

```
==============================
  我的双相财务保护清单
==============================
我状态好时（连续睡够、情绪平稳），
我同意自己这样安排：

1. 日常消费卡额度：_________
   超出这个数，必须等 48 小时。
2. 我要卸载的 App：_________
   （网贷/交易/打赏类）
3. 我信任的"刹车人"：
   姓名：_______ 电话：_______
   他/她有权问我："你最近睡得好吗？
   这个决定等两天再做？"
4. 我的贷款/信用卡清单（自己留底）：
   银行/平台：____ 额度：____ 还款日：____
   银行/平台：____ 额度：____ 还款日：____
```

```
5. 任何担保/借款/投资/加盟合同，
   一律等 48 小时、和刹车人商量后再签。
6. 如果我已经开始大手大脚花钱、
   觉得自己马上要赚大钱、几天睡得很少——
   我承诺：本周主动联系医生复诊。

紧急电话：医生_____ 12356
法律援助：12348    公安：110
==============================
```

> 把这张表**存在你自己手机里、给"刹车人"一份、贴在家里抽屉里**。希望你永远用不上，但躁狂期的那个你，需要清醒时的你帮他踩刹车。

> **最后，请记住：** 躁狂期花出去的钱，不是"你管不住自己"，是病在发作。你现在要做的，不是自责，而是**在自己清醒的时候，给那个会失控的自己提前装一道护栏**。钱可以慢慢挣回来，别让一次躁狂把后几年的生活都押进去。

参考来源

- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG185)*（躁狂症状、冲动行为与社会功能损害章节）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng185
- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》（躁狂发作症状学标准相关内容）。
- 中国银保监会/国家金融监督管理总局：个人消费信贷与理性借贷消费者教育（以官网最新内容为准）。
- 《中华人民共和国民法典》（合同、担保相关条款，国家法律法规数据库 flk.npc.gov.cn）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/

模块 10

常见Q&A

1. 高频问答QA

> **这一页收集了双相情感障碍患者最常问医生、也最常自己搜着吓自己的问题。答案尽量客观、安抚但不夸大——不说"包好"，也不说"完蛋"。所有问题都不能替代面诊，具体用药和诊断请听你的主治医生。**
>
> 本资料库仅作健康知识参考，不能替代精神科医生面诊与诊断，不用于自行调药、确诊。

Q1. 双相到底能不能完全治好？是不是要吃一辈子药？

【临床共识】"治好"要分两层说。**症状层面**：规范治疗（心境稳定剂为基础 + 必要时心理治疗）的患者，多数可以长期保持稳定、正常工作生活，很多人发作间隔越来越长、程度越来越轻。**根治层面**：双相有一定的生物学和遗传基础，目前医学还做不到"根除后永不复发"，它更像高血压、糖尿病——**通过长期管理可以和它和平共处，而不是靠一次治疗斩草除根。**

关于吃药：**首次发作后，通常建议维持治疗一段时间；复发次数越多，维持治疗的时间越长，有些人确实需要长期甚至多年服药。** 但这不等于"一辈子被药绑架"——是不是可以减药、什么时候减、怎么减，由医生根据你的复发次数、发作严重程度、间隔时间综合判断，**绝不是你自己看着"状态好了"就停。**自行停药后的复发率很高，而且复发一次，治疗难度往往上一个台阶。

Q2. 双相和抑郁症到底有什么区别？为什么我一开始被当成抑郁症治？

【临床共识】这是双相最常见、也最让患者委屈的经历。区别不在抑郁发作本身——双相抑郁期和单相抑郁症**表现几乎一样**；区别在于：**你一生中有没有过躁狂/轻躁狂发作。**

- **单相抑郁**：只有低落期，从没有过"连续几天异常兴奋/话多/睡得少却不困/挥霍"的阶段。
- **双相 II 型**：有抑郁发作，也有过**轻躁狂**（程度较轻，可能只是那几天"状态特别好、效率特别高、睡得少"），但没有达到完整躁狂。
- **双相 I 型**：至少有过一次完整的**躁狂发作。**

很多双相患者第一次就诊时正好在抑郁期，医生和患者都没意识到"以前那段特别顺、特别能扛、睡得少还精神"的日子其实是轻躁狂——于是先按抑郁症治。**这在临床上不罕见，不是医生水平差**，因为那段"好时光"患者自己不会当成症状报告。

> 如果你现在只吃抗抑郁药，一定要主动跟医生提一句："我以前有没有过连续几天睡得很少却特别精神、话多、冲动的时候？"这可能改变整个治疗框架。

Q3. 为什么医生不让我单吃抗抑郁药？

【临床共识】这是双相治疗和单相抑郁治疗**最核心的区别。**在双相患者身上，如果只用抗抑郁药、不加心境稳定剂，部分人会从抑郁被"推"到躁狂/轻躁狂，或者出现**快速循环**（一年之内发作 ≥4 次），病情变得更难控制。

所以双相的药物治疗**以心境稳定剂为基础**（碳酸锂、丙戊酸盐、卡马西平等），抗抑郁药只在抑郁相时，由医生谨慎评估、短期联用，并且通常会密切观察你有没有"转躁"迹象。**你不需要自己判断该不该吃抗抑郁药——这是医生根据你整个病程做的决定。你要做的是：吃药期间如果突然变得特别兴奋、特别易怒、睡得很少，立刻告诉医生。**

Q4. 我躁狂期感觉特别好，为什么还要治？那不是我"状态最好"的时候吗？

【个人体验】这是双相患者最普遍的困惑。你躁狂期的主观体验确实是"棒极了"——自我感觉良好、脑子转得快、精力旺盛、觉得自己无所不能。但从客观上看：

- 你那几天可能只睡 2–3 小时，身体在被透支；
- 你可能在挥霍存款、跟人决裂、许下根本做不到的承诺；
- 这种状态不会一直持续——它几乎一定会转成抑郁，或者以一次更严重的爆发收场；
- 你在躁狂期做的决定，事后往往要花几个月甚至几年来收拾。

【临床共识】**轻躁狂/躁狂期的"好状态"，是大脑奖赏系统失控带来的病理状态，不是真正的好心情。** 就像发烧时的"反常精神"不是身体好，是病在进展。治疗不是把你"从好心情里拽出来"，而是防止你从山顶直接摔进谷底。

Q5. 为什么医生反复强调睡眠？睡得少为什么会诱发躁狂？

【临床共识】**睡眠剥夺和作息紊乱是双相转相最常见的诱因之一**，没有之一。熬夜、倒时差、跨时区出差、连续加班、熬夜追剧打游戏——这些对普通人可能只是第二天有点累，对双相患者可能就是一次轻躁狂发作的起点。

机制上，双相患者的生物节律本身就不稳定，睡眠-觉醒周期是这套节律里最关键的"锚"。锚一松，情绪钟就开始乱摆。所以双相的心理治疗里有一个专门流派叫**人际与社会节律治疗（IPSRT）**，核心就是帮你把每天起床、睡觉、吃饭、社交的时间尽量固定。

> 记住这条口诀：**睡得乱 = 情绪乱的前兆。** 发现自己连着几天入睡越来越晚、睡得越来越少却不困，这是要联系医生的信号，不是"我最近效率高"。

Q6. 双相会影响我结婚、生孩子、找工作吗？

【临床共识】都可以，但需要多一点规划。

- **结婚**：双相患者和普通人一样有结婚的权利。建议在双方状态平稳时、关系成熟时，找合适的时机把病情告诉伴侣（见模块9第3篇）。
- **生孩子**：能生，但**育龄女性计划怀孕要提前几个月和精神科+产科一起规划**；尤其是服用丙戊酸、卡马西平的女性，这两个药对胎儿有明确风险，必须在怀孕发生前就和医生谈方案。产后是复发高发期，家人要帮忙守住睡眠。
- **工作**：很多双相康复者在各行各业正常工作。关键是选节律相对稳定的岗位、守住睡眠、不在轻躁狂期做大决定（见模块9第2篇）。

一句话：**病会影响你的节奏规划，但不会剥夺你过正常生活的权利。**

Q7. 我会不会"疯掉"？会不会变成精神分裂症？

【临床共识】**双相不会变成精神分裂症。** 它们是两类不同的疾病：

- 双相的核心是**情绪的剧烈波动**——躁狂/抑郁来回摆；即使在最重的躁狂期出现幻觉、妄想（比如坚信自己有超能力、有特殊使命），这些精神病性症状也是**和心境发作绑定的**，发作过去了就消失，不会像精神分裂症那样持续存在。
- 精神分裂症的核心是**现实检验能力的持续损害**——幻觉妄想不是跟着情绪走的，社会功能衰退也更持续。

两者可以共病，但"双相恶化成精神分裂"这个说法不成立。你之所以担心，是因为躁狂期的失控感（话多、冲动、出格）让你觉得"我是不是疯了"——那种失控感是真的，但它是有药可治的发作，不是不可逆的崩溃。

Q8. 吃药会不会变傻、发胖、上瘾？

【临床共识】分开说：

- **"变傻"**：部分心境稳定剂和抗精神病药在刚开始服用时，确实可能让人反应慢一点、犯困、注意力差——这通常在用药初期更明显，身体适应后会减轻。**真正让认知变差的，是反复发作本身和长期睡眠剥夺**；规范治疗、减少发作，长期来看对大脑功能是保护。如果副作用明显影响生活，复诊时告诉医生，医生会调整，但**不要自己停药**。
- **发胖**：确实有部分药物（尤其是某些第二代抗精神病药）会增加食欲和体重。这是可管理的——规律作息、控制饮食、适度运动，复诊时也可以和医生讨论。不要因为怕胖就拒绝治疗，发作的代价远大于几斤体重。
- **依赖/成瘾**：心境稳定剂（碳酸锂、丙戊酸盐、卡马西平）**不是成瘾性药物**，不会越吃越想吃、不会带来快感。苯二氮䓬类（短期助眠/抗焦虑用）有一定依赖风险，医生通常短期使用。需要区分的是：长期用药后**突然停药**会出现撤药反应、诱发复发——这叫"需要慢慢停"，不叫"成瘾"。

Q9. 锂盐为什么老是要抽血？抽血是查什么？

【临床共识】碳酸锂是经典的心境稳定剂，效果确切，但它有一个特点：**治疗窗比较窄**——剂量不够没效果，剂量太高可能中毒。所以医生需要定期抽血查**血锂浓度**，看药在你体内的水平是不是在合适区间。

除了血锂浓度，医生还会定期查：**肾功能**（锂主要从肾脏排泄，肾功能变化会影响血锂浓度）、**甲状腺功能**（锂可能影响甲状腺）、有时还查心电图。这不是医院过度检查，是锂盐治疗安全有效的必要监测。

> 记住：**吃锂盐期间不要自己突然大量补水或脱水**（比如剧烈运动后暴灌水、或者脱水时大量出汗），也不要随便加利尿药、止痛药——这些都会影响血锂浓度。出现明显手抖加重、恶心呕吐、腹泻、说话含糊、走路不稳，可能是锂中毒信号，**立即就医**。

Q10. 我吃的是丙戊酸/卡马西平，听说对怀孕不好？

【临床共识】**是的，这是育龄女性必须知道的重点。** 丙戊酸和卡马西平均与胎儿畸形风险相关，尤其是丙戊酸，风险相对更明确。

- 如果你是育龄女性、在吃这两个药，**必须采取可靠避孕**；
- 如果计划怀孕，**提前几个月**告诉精神科医生，由医生评估是否换药、怎么换——不要自己停；
- 意外发现怀孕，当天联系医生，不要慌、不要自己停药。

具体怎么处理，医生会权衡"复发风险"和"药物对胎儿的可能影响"，没有统一答案，必须个体化。

Q11. 药漏服了一顿怎么办？能不能喝酒、喝咖啡？

- **漏服**：想起来的时候，如果离下一次服药时间还远，按常规补服；如果已经快到下一次时间，**不要把两次的量一次吃**——直接跳过那次，按正常时间吃下一顿。最怕的是"漏了就加量补"。长期规律服药才是关键，偶尔漏一顿天塌不下来，但**长期想起来才吃、经常断顿，复发风险会明显升高**。具体漏服处理拿不准，下次复诊问医生，或打药房电话。
- **喝酒**：尽量不喝。酒精破坏睡眠结构，而睡眠对双相患者就是命根子；酒精还和药物相互作用、加重肝脏负担。应酬场合能推就推，推不掉就少量、慢饮，不混着喝。
- **咖啡/浓茶/能量饮料**：咖啡因是中枢兴奋剂，下午 2 点后不喝，全天控制在 1–2 杯以内。**双相患者对咖啡因比普通人敏感**，很多人减咖啡后情绪稳了一大截。

Q12. 能不能开车？

【临床共识】原则：**正在躁狂/混合发作期、或者药物让你明显犯困、或者严重睡眠不足时，不要开车。**

- 躁狂期容易鲁莽驾驶、开快车、路怒，这是双相诊断标准里就写着的风险行为；
- 服药初期如果药物让你嗜睡、反应慢，先别开，等身体适应；
- 稳定期、药物耐受后，日常通勤通常没问题。**长途、高速、夜间开车要谨慎**，连续开车 2 小时以上注意休息。
- 如果你发现自己开车时特别容易暴躁、超速、有"冒险超车"的冲动——那可能是轻躁狂信号，先别开，复诊。

Q13. 什么情况下需要住院？

【临床共识】住院不是"你病得没救了"，而是急性期最安全的选择。以下情况要认真考虑住院：

- 躁狂期明显失控：冲动挥霍无法劝阻、激越伤人、彻夜不眠好几天、出现幻觉妄想；
- 抑郁相/混合相出现强烈自伤自杀念头、行为；
- 药物调整期间副作用明显、需要密切监测；
- 快速循环、在家怎么都稳不住。

住院的好处是：24 小时有人看着安全、药物调整快、能把作息强行拉回正轨。很多康复者的经验是——**该住就住，别因为"面子"硬扛，扛出来的代价更大。**

Q14. 为什么说混合状态特别危险？

【临床共识】混合状态指的是**同一时段里，躁狂和抑郁的症状同时存在**——比如你心情烦躁到想砸东西、脑子转得飞快停不下来，同时又觉得"活着没意思"。

它为什么危险？因为普通抑郁发作时，人是瘫着的，连动都不想动；普通躁狂发作时，人是兴奋的，但心里是"觉得自己很棒"，没有自杀意念。**混合状态是既烦躁有行动力、又同时有想死的念头——这是双相里自杀风险最高的状态之一。** 如果你处于这种"坐立不安、脑子里全是负面念头、又停不下来"的状态，不要硬扛，尽快就医，把风险告诉医生和家人。

Q15. 家属现在能做什么？

简短版（详见可选模块《家属参考附录》）：

- **观察睡眠和花钱**：你突然睡得少了还不困、话多了、开始大手大脚花钱——家属要第一时间提醒你联系医生；
- **陪复诊、记医嘱**：发作期你注意力差，回家就忘医生说的话；
- **提醒吃药但不翻包检查**；
- **在你乱做决定时拦一下**：大额支出、重大决定，等两天；
- **不要说"你想开点""你就是闲的"**；
- **如果你说"不想活了"，不要替你保密，帮你打 12356 / 120。**

Q16. 这个病看病要花多少钱？医保能报吗？

【临床共识】双相需要长期服药和复诊，确实是一笔持续开销，但：

- 心境稳定剂（如碳酸锂）本身是很便宜的老药，很多在医保目录内；
- 门诊特慢病种/门诊大病政策，很多地方把双相纳入了，长期门诊买药可以按比例报销——具体问你就诊医院的医保办，或拨 **12393**（医保服务热线）；
- 住院按医保住院比例报销；
- 各地政策不同，不要自己猜，直接问医院医保窗口。

如果经济确实困难，公立精神卫生中心是性价比最高的选择；不要因为怕花钱就不去复诊——**复发一次住院的花费，远高于长期规律复诊。**

Q17. 儿童/青少年得了双相，和大人一样吗？

【临床共识】儿童青少年双相的表现和大人不完全一样：孩子更多表现为**极端的情绪爆发、易激惹（一点小事就大发脾气摔东西）、睡眠骤变、在异常亢奋和极度低落之间快速摆**，而不是大人那种清晰的"高涨/低落"段落。

特别提醒：**不要把孩子的情绪剧烈波动简单归为"青春期叛逆""中二病"。**如果你的孩子连续几天睡得极少还特别精神、挥霍、易激惹毁物，或者长时间情绪低落、提到"活着没意思"，尽早带孩子去儿童精神科评估。治疗上，儿童青少年更强调心理治疗和家庭干预，药物由儿童精神科医生严格掌握。

Q18. 老年起病的双相要注意什么？

【临床共识】晚年新出现的情绪波动，要先排除**躯体疾病**（甲状腺功能异常、脑血管病、药物副作用、痴呆早期表现等），不要直接当成"老了脾气怪"。老年患者用药更谨慎，合并用药多、药物相互作用复杂，一定要在老年精神科医生指导下治疗，家属帮着监测服药和副作用。

Q19. 我已经复发好几次了，是不是没救了?

【个人体验】不是。【临床共识】双相是一个**复发率不低**的病，但它也是一个**每次发作后，医生和你都更了解你的病**的病。复发几次不意味着失败，意味着：

- 你和医生需要把维持治疗时间拉长、把节律管理做得更细；
- 你自己会越来越早识别自己的复发信号（睡得晚了、话多了、花钱冲了）；
- 第二次、第三次复发，往往比第一次好处理，因为你已经有经验、有支持网、有那套财务和作息的护栏。

很多人就是在第三次复发后，才真正开始好好管理这个病的。**复发不是终点，是你和这个病重新认识的机会。**

Q20. 我现在觉得撑不住了，有危险念头，怎么办?

【临床共识】如果你现在已经有强烈的"不想活"的念头、或者已经有具体的冲动——**这不是矫情，是急症。**

- 立刻拨打 **12356**（全国统一心理援助热线，24 小时免费，国家卫健委设置，2025 年起全国统一使用；核实日期 2026-10-20，号码可能调整，以当地官方公布为准）；
- 情况紧急、已经有自伤行为或身边不安全：拨 **120** / **110**，直接去有精神科急诊的三甲医院或精神卫生中心；
- 告诉一个你信任的人，不要自己一个人扛；
- 如果你是混合状态（又烦躁又有想死的念头），告诉医生和家属"我现在是混合状态"，这会让他们知道事情的紧急程度。

> 【个人体验】拨出那个电话不丢人。每一个走出来的人，都在某个时刻承认过"我现在搞不定了，需要帮忙"。

> **最后，请记住：** 这些问题之所以被问这么多次，是因为几乎每个双相患者都问过。你不是怪物，不是唯一一个"情绪会坐过山车"的人。**有问题、敢问、找专业的人问，本身就是康复的开始。**

参考来源

- 美国国家精神卫生研究院（NIMH）：*Bipolar Disorder*. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/bipolar-disorder
- NICE：*Bipolar disorder: assessment and management (NG185)*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng185
- 世界卫生组织（WHO）：Bipolar disorders fact sheet
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》。
- CANMAT/ISBD 双相障碍治疗指南（国际双相障碍学会）。
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：https://ncmhc.org.cn/（12356 热线信息）

附加

可选附加模块

可选附加模块

共病专题

> 双相很少"干净地单独存在"。【临床共识】临床中，双相与焦虑障碍、物质使用、ADHD、人格问题、进食障碍、甲状腺疾病等同时出现非常常见；反过来，很多双相患者最初是因为"抑郁症""焦虑症"就诊，辗转多年才被识别出来。这一章讲清楚：常见共病长什么样、为什么"双相被漏诊/误诊为单相抑郁"是个大问题、就诊时你该主动告诉医生哪些线索。共病不是你病情特殊，是疾病的常见形态，需要医生整体处理。

一、为什么双相特别容易"共病"和"被漏诊"

- **抑郁相太像单相抑郁**：双相抑郁发作时，情绪低、没兴趣、疲劳、想自杀，和单相抑郁几乎一模一样。如果医生只看到这一次发作、没追问"你以前有没有过一段异常好/异常兴奋/睡得少却不困的日子"，就容易按单相抑郁治。
- **轻躁狂期患者自己不当成病**：轻躁狂那几天效率高、心情好、社交旺——患者觉得"这是我状态最好的时候"，不会主动报告，医生自然不知道。
- **共病症状互相掩盖**：焦虑、物质使用、ADHD 的症状和双相的部分表现重叠，让鉴别更复杂。
- **生物节律紊乱贯穿所有共病**：睡眠、情绪、物质、甲状腺问题互相牵连，形成恶性循环。

【研究结论】大量临床研究和双相注册数据显示，相当比例的双相患者首次就诊时被诊断为单相抑郁，从第一次抑郁发作到医生真正识别出双相谱系，往往要间隔数年——很多人是在"抗抑郁药越吃越兴奋/越吃越频繁发作"之后，才被回过头来重新诊断的。

> 【给你的话】你要做的，是在就诊时**把所有"不对劲"都列出来告诉医生**，尤其是"我以前有没有过一段特别顺、睡得少、话多、冲动花钱的时候"。这条线索，可能改变你的整个治疗框架。

二、常见共病逐一说明

1. 焦虑障碍（广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑）

- **你的感受**：长期心里悬着、静不下来、心慌、过度担心、怕见人；抑郁相和躁狂相都可能伴焦虑。
- **为什么一起出现**：焦虑消耗心理资源，长期焦虑的人里有一部分其实是双相谱系；双相发作间期也常残留焦虑。
- **就诊时主动说**："我除了情绪波动，还长期紧张/心慌/怕出事/怕社交，有没有惊恐发作过？"
- **注意**：【临床共识】双相合并不焦虑很常见，治疗上医生会统筹考虑（心境稳定剂为基础，必要时短期联用抗焦虑药），**不要自己看哪种药"名气大"就要求开。**

2. 物质使用（酒精、大麻、镇静药、兴奋剂）

- **你的感受**："不喝一杯睡不着""抽点东西才能放松""吃点镇静药才能压住烦躁"，渐渐不喝/不用就难受、整天想着下一次。

- **为什么一起出现**：患者用物质自我麻醉躁狂期的烦躁和抑郁期的低落；而酒精、大麻、兴奋剂长期反而**加剧情绪波动、诱发转相、升高自杀风险**，并干扰心境稳定剂代谢。
- **就诊时主动说**：**必须坦诚**——"我大概一周喝几次、一次多少、有没有不用就难受、有没有用过别的东西。" 医生不会评判你，隐瞒才最危险。
- **注意**：【临床共识】物质使用问题需要**同时治疗**，不能一边吃心境稳定剂一边大量喝酒/滥用物质；有些药在物质使用期需要医生调整。

3. 注意缺陷多动障碍（ADHD）

- **重叠的感受**：注意力容易被无关小事吸走、坐不住、话多、冲动——这些在双相躁狂期和成人 ADHD 里都能看到，很容易混。
- **怎么区分（交给医生）**：ADHD 的注意力问题是**从小、长期、跨场景**的（从小学就坐不住）；双相的注意力/冲动改变是**发作性**的——平时正常，某段时间突然加重。
- **就诊时主动说**："我是从小就坐不住、注意力差，还是最近这段时间才这样？" 童年病史很关键。
- **注意**：ADHD 的兴奋剂治疗药物对双相患者有诱发转躁风险，**必须由医生在心境稳定的基础上评估**，不能自己买来吃。

4. 人格问题（尤其边缘型人格特质）

- **重叠的感受**：情绪波动大、人际关系剧烈起伏、害怕被抛弃、冲动。边缘型人格障碍和双相在情绪不稳定上确实像。
- **怎么区分（交给医生）**：边缘型的情绪波动通常是**对人际关系事件的剧烈反应、持续时间短（小时到一天）、和"被抛弃感"紧密绑定**；双相的发作是**持续数天到数周的、不依赖具体事件的情绪相**，有相对清晰的发作间期。
- **注意**：两者可以共病，治疗思路不同。不要自己对着量表贴标签，把你的情绪模式告诉医生，让医生纵向判断。

5. 进食障碍

- **你的感受**：躁狂期可能暴饮暴食、食欲大开；抑郁期可能反过来茶饭不思；有些患者合并贪食/厌食。
- **就诊时主动说**："我的食欲、体重最近怎么变化？有没有暴食后催吐/极端节食？"
- **注意**：进食障碍和双相互相加重，营养和体重紊乱又会影响情绪稳定，需要一起管理。

6. 甲状腺疾病

- **为什么重要**：甲状腺功能异常（尤其甲亢）本身就可以造成**类似躁狂的表现**——心慌、失眠、话多、易怒、消瘦；而双相患者本身甲状腺问题的比例偏高，锂盐长期治疗也可能影响甲状腺。
- **就诊时主动说**："有没有怕热多汗、心慌、体重明显变化、脖子肿大？"
- **注意**：【临床共识】初次诊断双相、以及长期用锂盐的患者，医生通常会查甲状腺功能；**如果你情绪突然波动明显，除了想"是不是双相复发"，也要想到甲状腺问题**，查个甲功很简单。

三、重点：双相被漏诊/误诊为"单相抑郁"

> 【临床共识】这是双相诊疗里最常见、代价最大的问题。很多患者抑郁发作多年，一直按"抑郁症"吃抗抑郁药，吃着吃着变得更兴奋、更快循环，最后才被识别为双相。你了解下面这些线索，可能帮你少走几年弯路。

1. 提示"你可能不是单纯单相抑郁"的线索

- 抑郁发作**很早**（青少年期就开始）；
- 抑郁发作时**特别"软"**——嗜睡、吃得多、肢体像灌了铅、情绪对好事有反应；
- 家族里有人被诊断过"躁郁症""双相"，或有人情绪像过山车、甚至有自杀史；
- **吃抗抑郁药后变得特别兴奋、话多、睡不着、易怒**（这是药源性转躁，要立刻告诉医生）；
- 你自己回忆：**抑郁发作之间，有没有过一段"什么都顺、睡得少、效率高、花钱大手大脚、觉得自己特别牛"的日子？** 哪怕只有一两周。

2. 为什么"只吃抗抑郁药"在双相里可能出问题

- 【临床共识】双相患者若只单药抗抑郁、不加心境稳定剂，部分人会转躁/轻躁狂，或出现快速循环（一年发作 ≥4 次），治疗难度明显上升。
- 双相的基础治疗是**心境稳定剂**或第二代抗精神病药；抗抑郁药只在抑郁相、由医生谨慎短期联用，并密切监测转躁。

3. 就诊时你可以这样直接说

【个人体验】很多康复者回头才想起："那阵子我连续一周只睡三四小时还通宵干活，我一直以为那是我'状态最好的日子'，根本没当成病告诉医生。"——**轻躁狂期的"好日子"，恰恰是你最该主动报告的病史。**

- "医生，我除了这段时间低落，以前有没有过**连续几天睡得很少却特别精神、话多、花钱冲动**的时候？我家里有没有人情绪像过山车？"
- "我吃抗抑郁药期间，有没有变得特别兴奋/易怒/睡不着过？"
- "我这个病，需不需要评估一下双相的可能？"

> 【重要】**你不需要自己下诊断。** 把线索告诉医生，由医生判断。早识别、治疗框架不同，预后会好很多。

四、共病/鉴别大表（就诊时对照勾选，写在手机备忘录里）

共病/鉴别	你要识别的线索	你要告诉医生的话	治疗方向提示（由医生定）
焦虑障碍	长期紧张、心慌、过度担心、惊恐、怕社交	"我除了情绪波动，还长期焦虑/惊恐"	心境稳定剂为基础，必要时短期联用抗焦虑药

共病/鉴别	你要识别的线索	你要告诉医生的话	治疗方向提示（由医生定）
物质使用	不喝/不用就难受、整天想着、越用越多	"我大概用多少、用多久、有没有戒断反应"	同时戒断治疗，调整用药
ADHD	从小就坐不住、注意力差、跨场景	"我是从小注意力差，还是最近才这样"	需鉴别；兴奋剂类须在心境稳定后由医生评估
边缘型人格特质	情绪随人际事件剧烈波动、怕被抛弃、关系大起大落	"我的情绪波动是不是总跟'被冷落/被抛弃'有关"	辩证行为治疗 DBT 等专门心理治疗
进食障碍	暴食/极端节食、体重骤变、催吐	"我的食欲和体重最近怎么变"	营养+心理+药物一起管理
甲状腺疾病	怕热多汗、心慌、消瘦、脖子肿	"我最近甲状腺这边有没有不舒服"	查甲功；躯体问题先治
单相抑郁 vs 双相（重点）	早年起病、吃抗抑郁药后变兴奋、有过"睡得少却不困"的好日子、家族情绪病史	"我有没有过一段特别精神/能花钱/易怒的时候？家里有没有人情绪过山车？"	心境稳定剂为基础；抗抑郁药由医生谨慎联用

五、给共病患者的三句话

1. **"我不是病情更重，我是症状更多"**——共病是常见形态，不是判决书。
2. **"一次说全，比每次只说一点点更省事"**——把上面大表当就诊提纲，写在手机备忘录里。
3. **"治疗可能要同时走几条线"**——药物、心理、睡眠、物质戒断、躯体检查，医生会排优先级，你配合就好。

参考来源

- 世界卫生组织：Bipolar disorders fact sheet
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management，NG185
- 美国NIMH：Bipolar Disorder
- 国际双相障碍学会（ISBD）/ CANMAT：双相障碍共病与诊断相关指南。
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》《中国注意缺陷多动障碍防治指南》相关内容。

可选附加模块

康复者视角

> 【个人体验】**本文为个人经历的综合与化名呈现，不代表所有双相患者的体验，也不能作为任何治疗依据。每个人的治疗反应不同，用药方案请务必遵医嘱。** 我们写这些，是想让正在"过山车"上的你知道：有人真的走出来过，而且走出来之后，生活还可以继续。
>
> 【临床共识】真正的康复（recovery）不是"从此再也不躁、不郁"，而是**学会在波动中认出自己、守住节律、让发作间隔越来越长**。下面三个故事都不回避误诊、挥霍、副作用和反复——这才是真实的复原。

故事一：被当成"抑郁症"治了三年，直到一次刷爆信用卡

【个人体验】以下为化名故事。

我30岁那年第三次住进精神科。在那之前，我已经在"抑郁症"这个名头下看了三年医生。每次我都是情绪低、不想动、觉得活着没意思去的，医生开抗抑郁药，吃一阵好像好一点。我一直以为自己就是个"比较严重的抑郁症"。

第一次出事是在一次升职后。 我突然觉得自己脑子转得特别快，连续一周每天睡三四个小时还精力旺盛，白天开会侃侃而谈，晚上还在"思考商业模式"。我觉得这是人生巅峰。然后我开始疯狂刷信用卡——报了一个根本不会去上的两万块课程、买了一块买不起的表、在网上跟人合伙"做项目"转了三万块。等我老婆拿着账单问我的时候，我正处在那波亢奋的尾巴上，还觉得她"不懂我的宏图大略"。

真正把我打下来的是接着而来的抑郁相。 我躺在床上，看着那张账单，连骂自己的力气都没有，脑子里全是"我怎么这么蠢""这个家被我毁了"。是我老婆发现我连着几天没怎么说话、盯着窗户发呆，硬把我拖去了精神科。

就医与重新诊断：这次医生问了我一句我之前所有医生都没问过的话——"你除了这段时间低落，之前有没有过**连续几天睡得特别少还特别精神、特别能花钱**的时候？" 我愣了一下，开始讲那阵子。医生点点头："你这不是单纯的抑郁症，是双相，II型。" 那一刻我没有崩溃，反而有一种"终于知道自己是什么了"的踏实。原来我不是"一阵一阵矫情"，我是病了。

治疗的真实过程：药物框架整个变了——以心境稳定剂为基础。**头一个月我还是半信半疑，老觉得"我又没疯，吃这个干嘛"。** 真正让我服气的是半年后：那半年里我没有再出现那种"连着几天睡三小时还打了鸡血"的阶段，也没有再从山顶直接摔到谷底。我的睡眠第一次稳定在每天六七个小时。副作用有——刚开始有点手抖、胃口变好了体重涨了几斤，复诊时跟医生说了，慢慢调过来了。

我学会的最重要的一件事：**在我感觉"状态特别好"的时候，要警觉，而不是兴奋。** 我现在和我老婆约定了：大额支出超过两千，等两天再说；我连着几天睡得少，她就问我一句"你最近睡得好吗"。就这两句，拦住了好几次。

现在：我还在服药，定期复诊，工作也回去了。我不再追求"彻底治好"，我追求的是**睡得稳、情绪不做大起大落、不在上头的时候做大决定。**

给当下的你：如果你也被当成"抑郁症"治了很久、或者你心里一直有个疑惑"我好像不只是抑郁"——**把你以前那段"特别顺、特别能扛、睡得少还精神"的日子，下次复诊讲给医生听。**这一个细节，可能改变你接下

来好几年的治疗。

故事二：躁狂期把工作和婚姻都作掉，从头再来的女生

【个人体验】以下为化名故事。

我26岁那年躁狂发作，一个月内辞了职、跟谈了四年的男友分了手、跟我爸妈在电话里大吵一架断绝关系、一个人跑到外地"创业"。我当时觉得全世界都不理解我，我要去证明自己。三个月后钱花光了，创业的梦碎了，我一个人在出租屋里哭，连买碗面的钱都要算。那是我抑郁相最暗的一段。

那段时间的错误认知：我不觉得自己病了。我觉得那些离开我的人都是"势利""不懂我"，我坚信只要我再努力一把就能翻盘。现在回头看，那三个月里我几乎每天只睡三四个小时，话多得身边人都插不上嘴，花钱如流水——**每一条都是教科书级的躁狂，只是当时我不认识它。**

就医与治疗：是我妈飞过来，在出租屋里找到我，没骂我，就说了一句"我们回家吧"。回家后她陪我去了精神卫生中心。医生问我那几个月发生了什么，我一边讲一边哭，医生说"你这是躁狂发作之后的抑郁相"。开始吃心境稳定剂。**最难熬的是前两个月——药让我犯困，我又要面对辞职、分手、和爸妈关系破裂这一摊子现实烂摊子。** 但和以前不同的是，这次我没有再一个人扛。

慢慢重建：我没有急着找工作，先用了半年把作息拉回来——每天固定时间起床、固定时间睡觉、晚上跟我妈一起散步。我开始接受每周一次的心理治疗，学着识别我自己的"转躁信号"：我发现我一旦开始**频繁刷新购物软件、开始觉得"这次我一定能成"、睡觉时间越来越晚**，就是要亮红灯了。

和家人的关系：我没有急着求我前男友回来。我先把自己稳住了一年，才开始重新联系朋友。**躁狂期作掉的关系，不要在抑郁期去挽回——你状态不对时做的修复，往往又是一次冲动。** 等你真的稳了，该留下的人会留下。

现在：我换了一个节奏更稳的工作，和我爸妈关系缓和了，也开始了新的感情。我手机里存着我的"复发预警清单"。我不害怕再来一次——不是因为我自信，是因为我知道了**下次再上头时，该找谁、该拦什么、该先睡一觉再说。**

给当下的你：如果你现在刚从一次躁狂挥霍/冲动决裂里醒过来，面前一地狼藉——**先不要急着修补任何关系、不要急着赚回钱、不要急着证明自己。先把觉睡够，先复诊，先把自己稳住。** 一地狼藉可以慢慢收拾，你自己垮了就什么都没了。

故事三：混合状态里，靠一通电话活下来的年轻人

【个人体验】以下为化名故事。

我28岁，确诊双相 I 型。我最危险的一次，不是抑郁期，是**混合状态。**

那阵子我表面上"看起来还好"——每天还能去上班，但只有我自己知道：我坐在工位上，脑子转得像开了几十个标签页，一个念头都抓不住，烦躁得想砸键盘；同时脑子里全是"我活着有什么意思""我就是个废物"。我跟谁都没说，因为我觉得"我又没哭又没闹，应该不算严重"。

那天晚上，我一个人在出租屋里，那种烦躁和绝望搅在一起，我拿起手机拨了12356。电话那头是一个很平静的声音，听我语无伦次地说了二十多分钟，没有催我"想开点"，就一直说"我在听""你现在安全吗""需不需要我陪你等你朋友过来"。我叫了我一个朋友过来陪我，第二天一早就去了医院。医生说，我那是混合发作，是双相里自杀风险最高的状态之一。

那段时间的错误认知：我一直以为"只有瘫在床上哭才算严重"。其实**那种"又烦躁又绝望、脑子停不下来"的混合状态，比单纯抑郁更危险**——因为你还有行动力。

就医与治疗：住院调整了一段时间，出院后坚持规律复诊。我现在有一张"紧急联系卡"，存在手机、钱包、贴在家里冰箱上。我跟我的好朋友说好了：如果我哪天突然开始说"我不想活了"，或者我连着几天特别亢奋之后突然特别安静，他不用跟我商量，直接陪我去医院。

现在：我不再要求自己"永远不发作"。我只要求自己三件事：**睡够、按时复诊、撑不住时直接拨电话。**

给当下的你：如果你现在正处于那种"坐立不安、脑子里全是负面念头、又停不下来"的状态——**这不是你矫情，这是需要立刻处理的急症。现在就拨12356，或者敲开一个人的门。** 我在康复的这头等你。

康复不是直线：关于"波动"和"与症状共处"

【个人体验】以上三位都经历过：

- **好一段时间 → 突然又兴奋/低落几天**：这不是"复发失败"，可能就是熬夜、换季、压力、停药漏服带来的波动。学会识别"这是波动还是要复发"，比要求自己"永远稳"更现实。
- **"我都好了为什么还吃药"**：维持期的药是为了稳住你，不是因为你"一直病着"。
- **偶尔还是会想"我是不是又要躁了"**：那种警觉不是焦虑过度，是你学会了照顾自己。
- **复发几次不丢人**：每复发一次，你就更认识自己的触发点。

> 【临床共识】康复（recovery）是一个**方向**，不是一个终点。你不需要"完全好"才能开始好好生活；你可以一边治，一边慢慢把生活拼回来一点——先从睡一个好觉开始。

参考来源

- 世界卫生组织：Bipolar disorders fact sheet
- 美国NIMH：Bipolar Disorder
- NICE：Bipolar disorder: assessment and management，NG185
- 世界卫生组织：Doing What Matters in Times of Stress（自助手册）
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：官网科普（12356 热线信息）

可选附加模块

家属参考附录

> 写给陪伴双相情感障碍患者的家人、伴侣、父母、成年子女、朋友。【临床共识】你的角色是**支持者，不是医生**。你不需要治好他，但你可以成为他最稳的那块地板——尤其在他躁狂期冲动挥霍、抑郁期瘫倒、混合期危险的时候。照顾好你自己，才能真正陪他走下去——这不是自私，是长期主义。
>
> 【重要声明】双相不是"脾气差""一阵一阵矫情"，是有生物学基础、需要长期管理的疾病。患者本人不是"在闹情绪"，家属也不是"活该受罪"。本章所有医学建议不替代面诊，用药与治疗方案请遵精神科医生医嘱；本文不提供任何调药方案。

一、先定位：你到底是谁

- 你**不是**治疗师：不要自己诊断、不要替他调药、不要评判"这个医生靠不靠谱"。
- 你**是**：稳定的陪伴者、就医协助者、作息节律的共同维持者、**财务与安全的观察者**、早期复发信号的"第二双眼睛"。
- 一条黄金原则：**"我在"比"我懂"更重要；"守住节律和钱"比"劝他想开点"更重要。**

> 双相和单纯抑郁最不一样的地方：你不只要防他"垮下去"，还要在他"飘上去"的时候**把他拉回来**。很多家属只在他低落时着急，没意识到他"突然特别好、特别能花钱、特别能熬夜"才是更要警惕的信号。

二、早期"间断"：怎么认出他要复发了

【临床共识】双相复发前，往往有一两周的**早期信号**，家属是最容易先看到的人。每天花两分钟观察，比复发了再抢救便宜得多。

要"飘上去"（转躁/轻躁狂）的信号

- **睡眠需要突然变少**：连着几天只睡三四个小时，却不觉得困、还精力旺盛（注意：不是"失眠痛苦"，是"不想睡、不困"）；
- **话变多、语速变快**：跟人抢话、电话打个没完、家里安静不下来；
- **特别易激惹**：一点小事就炸、跟家人同事起冲突、路怒；
- **花钱开始大手大脚**：突然网购、打赏、投资、买大件、给人转账；
- **自我评价膨胀**：觉得自己特别厉害、要干大事、辞了职要创业；
- **社交突然密集**：半夜约人、连续通宵聚会；
- **注意力随境转移**：一件事没做完就跳去下一件。

要"掉下去"（转抑郁）的信号

- 话变少、不想出门、对以前喜欢的事没兴趣；
- 睡觉变多或严重失眠、食欲明显变化；
- 说"活着没意思""你们以后怎么办""我是累赘"；

- 把珍贵的东西送人、开始清理手机/电脑、突然异常平静。

混合状态信号（最危险）

- 又烦躁又低落：坐立不安、想砸东西，同时说活着没意思——**这种状态自杀风险最高，不要当成"他就是脾气坏"。**

> 发现上面任何一组信号连续出现几天，**温柔但坚定地提醒他联系医生提前复诊**，不要等"它自己过去"。

三、"该说 / 不该说"对照表（15 对，直接可用）

别再说	试着这样说	为什么
"你就是脾气差 / 性格有问题"	"医生说这是大脑管情绪的地方出了问题，跟脾气是两码事。"	把疾病当性格缺陷，是二次伤害。
"你上次不是挺好的吗，怎么又这样"	"双相本来就是会波动的，跟感冒好了也会再感冒一样。"	不知道它是波动病程。
"你兴奋的时候不是挺正常吗，装的吧"	"你那几天睡得少还特别精神，其实是要复发的信号，我们去看看？"	轻躁狂期看起来像"打了鸡血"，不是真的好。
"想开点 / 你就是想太多"	"我看到你最近很难受，这不是你的错。"	否定感受只会让他闭嘴。
"别吃那些药了，是药三分毒"	"药的副作用可以跟医生说，咱们一起复诊问问。"	劝自行停药可能诱发复发，代价很大。
"你怎么又乱花钱了！"（躁狂高峰期）	先拦住大额支出，不当场吵架；等他稳一点再说。	高峰期争论没用，先把出血点堵住。
"为了这个家你也要振作"	"你对我很重要，但你不需要为了我硬撑；我们一起面对。"	道德绑架加重内疚。
"你就是懒 / 不上进"	"我注意到你最近起不来、睡不好，是身体/情绪出问题了，我们去看看？"	疾病导致的退缩不是懒惰。
"你看谁家谁谁不是也好好的"	"痛苦没法比，你现在是真的在受苦。"	比较不会减轻痛苦。
"出去玩玩 / 旅旅游就好了"	"等你状态稳一点再考虑出门；现在先把觉睡好最重要。"	强迫出游/熬夜旅行是转躁诱因。
"我都为你做了这么多了，你怎么还这样"	"我有点累，但我没怪你；我们一起想办法。"	付出感说出口就变成债务。
"你倒是说话啊 / 整天闷着算什么"	"不想说话也没关系，我坐这里陪你。"	允许沉默。
"你这样让我很崩溃 / 我快被你逼疯了"	"我今天状态也不太好，先自己待一会儿，晚一点再陪你。"	家属情绪要表达，但别倒在患者身上。
"一切都会好起来的"	"我不知道什么时候会完全好，但我会一直在。"	虚假乐观不如真实陪伴。

别再说	试着这样说	为什么
"你要是不想活了跟我说说"（敷衍）	"你说出来，我不会替你保密，我会帮你找医生/打12356，因为你的安全比保密重要。"	危机时不能答应保密。

四、实际可以做的 10 件事

1. **陪诊**：第一次就诊、每次复诊陪他去，帮忙记医嘱——发作期（不管躁狂还是抑郁）他的注意力都差，回家就忘。
2. **提醒服药，但不监督对立**："该吃药了哦"是温柔提醒；不要翻包检查、不要质问"你今天吃没吃"。发现他**自己偷偷停药**，温柔而坚定地问原因、联系医生。
3. **守住睡眠（这是双相家属最关键的任务）**：周末也别让他熬夜、别纵容他通宵打游戏/刷手机；晚上固定时间一起关灯睡觉。**睡眠一乱，情绪就乱。**
   - 【个人体验】很多家属后来都说，自己做过最有用的事，不是劝、不是讲大道理，而是**每晚到点一起把灯关了、把手机放到客厅**——这件不起眼的小事，拦住了不知道多少次转躁。
4. **守住钱**：见第五节。
5. **观察并记录**（见第六节），复诊时给医生看。
6. **配合治疗**：医生建议住院就住院，建议心理治疗就帮他预约；**不要替他拒绝治疗**，也不要因为"面子"拒绝住院。
7. **帮他筛信息**：把网上那些"七天治愈""断药断食治愈双相"的内容挡掉，把靠谱资料（12356、正规医院）放他手边。
8. **保护隐私**：不跟亲戚邻居到处说；不发朋友圈；病历、药盒收好。
9. **不做重大决定的同盟**：他躁狂期要辞职、要离婚、要借大钱、要加盟——你有责任说"这件事我们等三天再决定"。
10. **庆祝小稳定**：这周他连续七天睡够了、这个月没乱花钱——具体地、真诚地肯定。

【研究结论】大量临床研究显示，把家属纳入治疗、教家属识别复发早期信号、改善家庭沟通的**家庭焦点治疗（FFT）**和家庭干预，能显著降低双相患者的复发率、延长发作间隔。也就是说：你这个"家属"做得好，本身就是治疗的一部分，不只是"陪着"。

五、财务安全：家属的另一项核心任务

【临床共识】躁狂期的挥霍、盲目投资、借贷、担保，是双相家属最常面对的现实危机。你能做的：

- **在他状态好时，和他一起**把日常信用卡额度调低、注销多余的网贷账户、卸载交易类 App、关掉支付免密；
- **约定一个"刹车规则"**：他要花超过你们约定金额（比如两三千），你有权问一句"你最近睡眠怎么样？这个决定等两天吗？"
- **大额资产共管**：反复挥霍过的家庭，大额存款放共管账户、大额卡由你保管，不是不信任他，是保护那个会失控的他；
- **他躁狂期突然要借钱、担保、投资、加盟**：先稳住他（"咱们明天再去银行"），当晚就联系医生；
- **已经欠了网贷/高利贷**：保留证据，拨 110，法律援助拨 12348；不要怕丢人，这是病的症状，不是人品问题。

六、家属观察记录本（每天两分钟，复诊给医生看）

观察项	今天的情况
睡眠	昨晚几点睡、几点醒、睡了几小时、白天补不补觉
情绪	平稳 / 低落 / 亢奋 / 易激惹 / 混合（烦躁+绝望）
言语	话变多还是变少？有没有说"活着没意思""你们以后怎么办"？
行为	有没有开始大手大脚花钱、疯狂网购/投资、辞掉重要事、跟人决裂？
节律	吃饭、出门、作息有没有被打乱？
药物反应	有没有明显嗜睡、手抖、恶心、"好像变兴奋了/睡得很少却不困"？

> 【临床共识】**"睡得少却精神特别好、话多、花钱冲动"是转躁线索；"突然异常平静、把东西送人"是抑郁危机线索。** 这两类都要第一时间告诉医生。

七、危机时家属怎么办（只写安全，不写方法）

> 如果你发现他有以下情况：表达强烈的"不想活了/活着没意思"、安排后事、告别、把珍贵东西送人、突然异常平静、已经在伤害自己——**这是危机信号。**混合状态（又烦躁又有想死念头）风险尤其高。

- **直接问**："你是不是有过不想活的念头？"——**直接问不会"提醒"他自杀，反而让他感到被看见。**问完不要慌、不要骂。
- **不离人**：在确保你自身安全的前提下，不要让他独处。把危险物品从他身边移开（不要自己展开处理方法，交给专业人员）。
- **立刻求助**：
- **12356**（全国统一心理援助热线，24 小时免费，国家卫健委设置，2025 年起全国统一使用；核实日期 2026-10-20，号码可能调整，以当地官方公布为准）
- **120**（医疗急救）/ **110**（公安，现场有人身威胁或他拒不自保时）
- 直接送**有精神科急诊的三甲医院 / 精神卫生中心。**
- **住院不是抛弃他**：急性期住院是最安全的选择，配合医生；不要因为"面子"拒绝住院。
- **首次剧烈胸痛、意识异常、抽搐等**：不要当成情绪问题，先拨 120 排除躯体急症。
- **事后**：他情绪平复后，不要指责"你差点把我吓死"，而是说"我当时很怕失去你，我们以后遇到这种情况怎么办"。

八、不同对象的特别提示

- **青少年患者家属**：不要把孩子的情绪剧烈波动当成"青春期叛逆"。连续几天极度亢奋、睡得极少还不困、挥霍、毁物，或长期低落、提到活着没意思、手臂上有划痕——**早就医，不要等。**
- **育龄女性患者家属**：如果她在吃丙戊酸/卡马西平，提醒她**必须可靠避孕**；计划怀孕要提前几个月和医生谈。不要在她怀孕后劝她"为了孩子自己把药停了"。

- **伴侣家属**：躁狂期他可能特别易怒、特别爱花钱/社交/对人冷淡——那不是针对你；抑郁期他可能不想亲热不想说话——那也不是没感情。**不要在他发作高峰期谈分手离婚。**
- **老年患者家属**：晚年新出现的情绪波动，先陪他查甲状腺、脑血管等躯体问题，不要直接当"老了脾气怪"。

九、家属自己也要被照顾

- **你不是他的医生，也不是他的药。**把全部生活押在他身上，两个人都会垮。
- **给自己喘息**：和其他家属轮班、每周留半天给自己的事。这不是抛弃，是让你能撑得久。
- **你可以有自己的情绪**：委屈、疲惫、生气都正常；找你自己的朋友、心理咨询、家属支持团体（很多精神卫生中心有家属互助小组）。
- **不要自责**："我是不是哪里做得不好"——双相有生物学和遗传基础，不是你造成的。
- **处理你自己的病耻感**：你愿不愿意告诉别人，同样是你自己权衡的事，不必勉强。

十、家属一周自检（每周日花2分钟勾选）

- [ ] 这周我有没有说过"想开点/你就是脾气差/别吃药了"？（说过没关系，下周注意）
- [ ] 这周我有没有留意他的睡眠？有没有连续几天睡得少还精神好？
- [ ] 这周我有没有陪他按时复诊/取药？
- [ ] 这周有没有拦住他的大额冲动支出？
- [ ] 这周我有没有把自己的情绪倒在他身上？（有的话，下周找朋友/咨询师）
- [ ] 这周我有没有留半天给自己喘息？
- [ ] 我和他的紧急联系电话是否还存在手机里？

十一、紧急联系卡（可抄到手机备忘录 / 打印放钱包）

```
==============================
   双相情感障碍紧急联系卡
==============================
患者姓名：_______________
主治医院/科室：___________
主治医生/电话：__________
正在使用药物（不要自行停、
  不要自行加）：
   _________________________

【24小时心理援助】12356
【医疗急救】          120
【公安】              110
【医保咨询】          12393
【法律援助】          12348
```

家属/信任的人：
姓名：_____ 电话：_____
姓名：_____ 电话：_____

最近的有精神科急诊的医院：
名称：_____
地址：_____
电话：_____

【我的早期复发信号（患者本人填）】
飘上去：睡得少却不困/话多/乱花钱
掉下去：不想动/说活着没意思
混合：又烦躁又绝望——最危险

【如果出现强烈不想活、混合状态、
异常平静、自伤行为——
不要让他独处，立即拨120/12356，
就近送精神科急诊。】
==========

> 把这张卡**同时存在患者手机、家属手机、贴在冰箱上**三份。希望你永远用不上，但一定要有。

参考来源

- NICE：Bipolar disorder: assessment and management，NG185
- 世界卫生组织：Bipolar disorders fact sheet
- 世界卫生组织：Suicide prevention（PREVENT suicide）
- 美国NIMH：Bipolar Disorder（家属教育章节）
- 国家心理健康和精神卫生防治中心：12356热线与家属科普
- 中华医学会精神医学分会：《中国双相障碍防治指南》（家庭干预与复发预防相关内容）